

金匱發微

曹穎甫

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
藏府经终先后病脉第一	5
痉湿喝脉证第二	14
百合狐惑阴阳毒病证治第三	23
疟病脉证并治第四	29
中风历节病脉并治第五	32
血痹虚劳病脉证并治第六	41
肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治第七	49
奔豚气病脉证第八	56
胸痹心痛短气病脉证治第九	58
腹满寒疝宿食病脉证治第十	62
五藏风寒积聚病脉证并治第十一	70
痰饮咳嗽病脉证治第十二	76
消渴小便不利，淋病脉证治第十三	87
水气病，脉证并治第十四	91
黄閼病证并治第十五	104
惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证第十六	111
呕吐哕下利，病脉证治第十七	116
疮痈，肠痈，浸淫病脉证治第十八	130
跌蹶手指臂肿转筋狐疝疣虫病脉证第十九	134
妇人妊娠病脉证治第二十	137
妇人产后病脉证治第二十一	142
妇人杂病脉证治第二十二	147
跋	156
重刊（伤寒）（金匱）发微跋	157

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

藏府经终先后病脉第一

问曰。上工治未病。何也。师曰夫治未病者。见肝之病。知肝传脾。当先实脾。四季脾王不受邪。即勿补之。中工不晓相传。见肝之病不解实脾。惟治肝也。夫肝之病。补用酸。助用焦苦。益用甘味之药以调之。肝虚则用此法。实则不任用之。经曰。无实实。无虚虚。补不足。损有余。是其义也。余藏准此。

此节借肝病传脾。以明上工治未病之说也。肝脏血虚。则其叶燥挺而压于脾。脾气郁。则痛涎腹部。遂有腹中急痛之证。伤寒论云。阳脉急。先予小建中汤。盖桂枝汤其味本甘。加饴糖则其味益甘。内经所谓肝苦急。急食甘以缓之。即实脾之说也。脾王不必泥四季。但泾土当旺之时即是。长夏用小建中。即病胀满。故曰勿补。中工不知因肝脏血虚之故。而用甘味以实脾。而以小建中汤为治肝补脾不二法门。则大误矣。盖肝之味酸。而中含有胆液则苦。肝与胃同居膈下。而胃实为生血之原。肝胆之液。渗入胃中。并能消食。寒则吐酸。肝之液也。热则吐苦。胆之液也。要之为胃气不和。胃气不和。则无以资历肝藏之血。且泾胜则肝胆不调。故多呕泾。泾之所聚。尤病乃作。然则所谓补用酸。助用焦苦者。以乌梅丸言之也。但焦苦当言苦温。以乌梅之酸。合细辛干姜蜀椒桂枝附子之温。及黄连黄柏之苦燥。而后胃温泾化。肝胆之郁。方得条达。更有胃中虚寒。干呕吐涎沫。则专用苦温之吴茱萸汤。而不用酸以补之者。此证寒泾初起。肝脏未虚。故但需助胃阳而止呕也。若夫益用甘味以调之者。乃专指建中汤言之。以上三法。皆为肝虚而设。凡病虚则生寒。实则生热。故有肝乘脾。肝乘肺。而刺期门者。亦有厥深热深而当下者。亦有肝实血热。热利下重。而用白头翁汤者。若不问虚实。而概用建中汤以治肝补脾。不病胀满。即病烦躁。故曰。不任用之。无实实。无虚虚。补不足。损有余。当是古经文。见扁鹊难经。酸入肝至要妙也一段。述中工谬论。不著紧要。特删去之。从黄坤戴悬解例也。

夫人禀五常。因风气而生长。风气虽能生万物。亦能害万物。如水能载舟。亦能复舟。若五脏元真通畅。人即安和。客气邪风。中人多死。千般灾难。不越三条。一者。皮肤所中。经络受邪。内入藏府。为外所因也。二者。四肢九窍。血脉相搏。壅塞不通。为所内因也。三者房室金刃虫兽所伤。以此详之。病由都有尽。若人能养慎。不令邪风干革命忤经络。适中经络。未流传府藏。即医治之。四肢感觉重滞。即导引吐纳针灸膏摩。勿令九窍闭塞。更能无犯王法。禽兽炎伤。房室勿令竭乏。服食节其新热酸苦甘辛。不遗形体有衰。病则无由入其腠理。腠者。是三焦通会元真之处。理者。是皮肤藏府之文理也。（许半龙曰、从经络传达室藏府、当人外因、血脉壅塞不通为内因、原本倒误、今从其说校正。）

人禀五常。不过言人之禀五德耳。浅注谓曰在五气之中。非也。于以下方说到风气。便知所谓因风气而生长者。人得风中空气。则精神爽健。然必清晨吸受。方为有益。故昔人多有吹卯时风而得大寿者。然亦不右太过。过则为病。譬如今人多喜吸

受空气。甚至天寒地冻。夜中开窗眠睡。有不病伤寒者乎。此即风气生万物。亦能害万物之说也。是何异水能戴舟。亦能复舟。要惟本体强者。乃能无病。故藏府元气充足。呼吸调畅。然后眠食安而营卫和。若外来之客气邪风。亦当思患预防。否则中人多死。假如风中皮毛肌腠。则病伤寒中风。风中于筋。则病拘攣。风中府藏。即口噤不识人。风中于头。则颠眩或疼痛或口眼不正。风中于体。则半身不遂。是谓邪风。且风为百病长。合于燥则病燥。合于湿则病湿。合于寒则病寒。合于暑则病暑。是谓客气。然治之得法。犹有不死者。若夫疫疠之气。暴疾之风。中人往往致死。此节为全书大纲。故特与外因不外不内因三条以为之冠。六气之病。起于皮毛肌腠。故善治病者治皮毛。其次治肌膏。今以皮毛肌腠不固。邪中经络面临主藏府。是为外因。四肢九窍。血脉相搏。脾胃主四肢。中阳不运。风湿困于四肢。则四肢为之不举。肝开窍于目而资于肾。肾阴耗而肝火盛。则目为之昏。紧开窍于耳而资于脑。脑气亏而肝火张。则耳为之聋。肺开窍于鼻。风邪袭肺。则鼻中不闻香臭。胃开窍于舌。胃中宿食不化。则口中不知五味。胃与大小肠下穹穹在肛门。胃燥则大便闭。三焦下穹在膀胱。湿痰阻其水道。则小溲不利。阳热结于膀胱。则小溲为之不利。是谓内因。若夫房室之伤。则病内热惑虫。金刃之伤。缓则溃烂。急则病破伤风。虫兽之伤。毒血凝瘀。甚则走窜周身而死。（金刃初伤用小苏叶打烂涂之、不致出血太过。毒蛇咬伤、用壁虫入面暂内捣涂即愈。疯狗咬伤、血必走窜大肠、凝结成魂、久则发狂、宜抵当汤下之。）是为不内不外因。即此三因推之。全书大纲。略尽于此。凡此者惟防范者能免之。挽中皮毛肌腠。即用麻黄桂枝二汤以发之。然后病机不传经络。即传经络。未及藏府。即用葛根汤以发之。则外因之内陷者寡矣。血脉不流通。则四肢为之重滞。然当甫觉重滞。或用八段锦十二段锦法。使筋节舒展。或吸气纳于丹田。而徐嘘散之。使用身血水分。随之运行。甚至或湿壅关节。时作竣痛。则针灸以通阳气。膏摩以破壅滞。则内因闭塞九窍者寡矣。然犹必安本分以避弄辟。远山林以避蛇虎。远壮第以保精髓。节衣服之寒暖。节五味之过当。务令营卫调适。内外强固。六淫之邪。乃无入其腠理。则病之成于不内不外者又寡矣。所谓腠理者。人身肌肉方斜长短大小不等之愧。湊合而成。湊合处大隙即谓之腠。肌肉并系而成块。众系之小隙。即谓之理。胸中淋巴系统。发出之乳糜水液。出肌腠而成汗。故曰通会元真者。固有之元气真。血分中营阳及之。水分中卫阳亦及之。故曰通会文理。即合并成块之肉丝，不独肌肉有之。即胃与小肠大肠并有之。各具淋巴微管。发出水液。故仲师连类及之耳。其实病气之始入。原不关乎内藏也。

问曰。病人有气色见于面部。原闻其说。师曰。鼻头色青。腹中痛。若冷者死。鼻头色微黑者。有水气。色黄者。胸上有寒。色白者。亡血也。设微赤。非时者死。其目正圆者。痉。不治。又色青为痛。色黑为劳。色赤为风。色黄者。便难。色鲜明者。有留饮。

气色之见于面部者。无病之人亦有之。借如夏令行烈日中则面赤。暴受惊恐则色白。此其易知者也。明乎此。乃可推病之人气色，日鼻鼻头色青腹中痛者。鼻之上部

尽头处。非鼻准之谓。相家谓之印堂。医家谓之关下。小儿下利。印堂多见青色。腹痛不言可知。下利手足逆冷。为独阴无阳。故曰苦冷者死。湿家身色薰黄者。黄中见黑色也。今印堂微见黑。故知其水气。湿病属脾藏。脾统血。血中有黄色之液。湿胜而血负。病在营。故其其色黄黑相杂。水气属三焦肾与膀胱。病卫。故印堂微黑。胸中为饮食入胃发生水液之处。其水液由脾阳生发。中医谓之中焦。西医谓之淋巴系统。胸中有寒。是病留饮。故萎黄见于印堂。血不华色则白。故亡血者色白。人饮酒则面有赤色。行日中及向火并同，为其血热内盛。阳气外浮也。伤寒阴寒内剧据。真阳外脱。慢亦面见赤色。是谓戴阳。此证多属冬令。故曰非时者死。谓非夏令血热张发之候也。按寒饮之色黄。失血之色白。或全见面部。戴阳之赤色。或见额上及两颧。不定在鼻之上部。故无鼻头字。非省文也。而色既辨。然又必验之于目。刚痉无汗。周身、筋脉紧张。故目系强急而目正圆。此证脉必直上下行。内经所谓但弦无胃也。故曰不治。目色青。少年妇人时有之。或不必因病而见。然往往有肝郁乘脾。而脘中急痛。若夫色黑为劳。与女劳瘵额上黑同。凡人目中瞳人则黑。其外微黄。惟女劳则瞳人外圈俱黑。吾乡钱茂材信芳。诊宋姓病断其必死。不三月果死。予问故。钱曰。女劳目之外眶尽黑。法在必死。盖瞳人精散处溢。如卵黄之忽散。臭败随之矣。风邪中于头。则入于目而目脉赤。荆芥防风蝉衣疆虫等味薰洗足以愈之。仲师固无方治也。色黄便难。是谓谷瘵。宜茵陈蒿汤。惟鲜明有留饮。当指目鲜泽者。及目下有既形者言之。若专以目论。则巧媚妇人。固自有明眸善睐者。何裳留饮乎。

师曰。病人语声寂寂然。喜惊呼者。骨节间病。语声喑喑然不彻者。心膈间病。语声啾啾然细而长者。头中痛。

无病之人。语声如平时。虽高下疾徐不同。决无特异之处。寒湿在骨节间。发为竣痛。故怠于语言而声寂寂。转侧则剧痛。故喜惊呼。心膈间为肺。湿痰阻肺窍。故语声喑喑然不彻。头痛者出言大则脑痛欲裂。故语声喑喑然细而长。不敢高声语也。

师曰。息摇肩者。心中坚。息引胸中上气者。肺痿叶沫。（此条心中坚当为心下坚之误。）

痰饮留于膈间。则心下坚满。痰饮篇所谓虽利心下续坚满。膈间支饮人喘满心下痞坚。寒疝篇脉紧大而弦者。必心下坚。则此云摇肩心中坚者。其必为心下坚之误无疑。心为君主之藏。不能容纳外邪。惟心下为膈与胃相逼处。痰湿流于膈间。则气为之阻碍而气不顺。至于两肩用力摇动。则心下之坚满可知矣。此为湿痰凝固之证。所谓宜十枣汤者也。至于引胸中上气而咳。即后文喉则上气之证。吐黄蜀者宜皂荚丸。有水痰者宜射于麻黄汤。张口短气者。肺痿味沫。即后篇所谓肺痿之证。以上三者。皆出于主气之肺。辨息至为切近。故类及之。

师曰。吸而微数。其病在中焦实也。当下之则愈。虚者不治。在上焦者其吸促。在下焦者。其吸远。此皆难治。呼吸动摇振振。不治。息由丹田上出肺窍是为呼。由肺窍下入丹田是为吸。呼吸略无阴凝。乃为无病之人。人惟中脘宿食不化。则吸入之气。至中脘而还。不能下入丹田。故出纳转数。下之则上下通彻。略无寄人室凝。此大承气汤。所以为承接中气之用也。然有本为大承气证。始病失下。病久精气耗损。肠胃枯燥而死者。即有久病虚羸。一下正随邪恶尽。以致虚脱而死者。因此后医失误。转授前医以为口实。而硝黄遂成禁例。然则仲师言虚者。不治为法当早下言之非为见死不救之庸工言之也。（大下后食腹同此例。）若夫肺虚而吸气乏力故吸也促。肾虚而纳气无权故吸远。促者上焦不容。远者下焦不摄。故曰难治。其不日不治而日难治者。肺壅肺痿肺胀及膈间有留饮。其吸皆促。为其有所阻也。亡血失精。其吸皆远。为其不相引也。数者皆有方治。而愈期正不可知。故曰难治。至于呼吸动摇振振。其人必大肉痿陷。大骨枯槁。午后微热。死在旦夕。虽便扁鹊复生。无能为役矣。

师曰。寸口脉动者。因其王时而动。四时各随其色。非其时。色脉皆当病。

此寸口以两手六部言之。凡脉之大小。小视血分热度之高下。血分之热度。又以天时之寒暖为盈脑。天时至春而疏达。则其脉调畅。夏而张发。则其脉盛大。秋而收束。则其脉敛抑。冬而闭藏。则其脉沉既。所谓因王时而动也。夏令天气炎热。血分热度既高。甚有而色及掌心发红色者。亦有八九月间天气渐寒。红色渐变为白色者。此固因于血热之高低。非可以五色配四时也。不然。春日肝王。冬日水王。曾未见有春日色青。冬日色黑者。五色配四时之谬。固已不攻自破。然则四时各随其色。亦不过分赤白二色。以见血热之高低耳。非其时色者皆法当病。直以天时温暖。血不华色。营气不充脉络言之。亦以天时苦寒。血热暴张。面赤脉洪者言之。然则假令肝王色青及肝色青而反白二语。皆当删去。此必非仲师之言。或由门人袭内经东方生木节意而附会之。不可为训。

问曰。有未至而至。有至而不至。有至而不去。有至而太过。何谓也。师曰。冬至之后早子。夜半少阳起。少阳之时。阳始生。天得温和。此为未至而至也。以得甲子而天未温和。此为至而不至也。以得甲子而天大寒不解。此为至而不去也。以得甲子而天温如盛夏五六月时。此为至而太过也。

此一节。论天时气之愆伏。（愆太过也伏不足也。）以见病气所由受。未至而至数语。当是古医家言。师特借冬至后甲子以起例。古者十一月甲子朔夜半冬至为历元。则冬至后甲子当在正月。日夜半少阳起者。不过略言阳气初回。内经所谓春三月发陈之期也。当此期内。地气方得温和。春未至而地气转阳。故曰示至而至。皮毛早开。风邪易袭。多桂枝证。若时令当温不温。即为至而不至。设当春令阳回之时。而天气忽然大寒。春行冬令。是谓至而不去。皮毛未开。寒邪中之。多麻黄证。春气方回忽然大热如盛夏五六月。春令夏行。是谓至而太过。汗液大泄。津液早亏。

。多人参白虎证。四气之转移。莫不皆然。此特一隅之举耳。得甲子不过陈述故训。勿泥。

师曰。病人脉。浮者在前。其病在表。浮者在后。其病在里。腰痛背强不能行。必短气而极也。（浮在前当病表实、以麻桂二汤发之、固已一汗而愈、若浮在后则里虚、血不充脉、发其汗则里液益虚、以致不能行、短气而竭、其不死机希、皆其致死之源、因医家见其脉浮、以为表实而强为发汗、不知浮在后不当发汗也。）

脉浮在前。是通关前后言之，是谓表实。在后是指关后独浮言之。浮在关后。而不及关前。则脉管中血液不足。可知脉浮在表。为麻黄桂枝二汤证。若浮不及关以上。则血分本虚而不当发汗。此即淋家不可发汗。失精家不可发汗之意。太阳之里属少阴。脉之浮属太阳。不见微细病固无内传少阴之理。然太阳能之脉。夹抵腰中，即谓之里可也。脊为督脉经隧。腰为实少阴之藏。肾与膀胱为表里。自腰以下有两管。注小洩于膀胱。中医谓之下焦。西医谓之输尿管。即为其病在里亦可也。阴虚之人。强责其汗。势必牵涉于肾。腰竣背强。犹为太阳本病。至于阴寒精自出。遂削不能行。则水之上源。因发汗而竭。而下流亦涸矣。短气而竭是者。则以肾虚不能纳气故也。况阴虚必生内热。内热薰灼。至于骨痿髓枯。焉有不死者乎。

问曰。经云。厥阳独行。何谓也。师曰。此为有阳无阴。故称厥阳。

油灯将灭。火必大明。膏油竭于下。则光气脱于上。是故虚实劳不足之人。日晡有微热。甚至者入夜壮热。至有喉痹口燥而烂赤者。此火。如煤油如火酒。救之以水则漂焰益张。扑之。以灰则息矣。故昔人有甘温清热之法。内经所谓劳者温之也。然补血养阴。正不可少。若油灯之添油者然。但恐不能不受重剂耳。倘更以寒凉。焉有不死者也乎。

问曰。寸脉沉大而滑。沉则为实。滑则为气。实气相搏。血气入藏即死。人府即愈。此为卒厥。何谓也。师曰。唇口青身冷为入藏。即死。如身和汗自出为入府。即愈。

大气挟血。并而上逆。则寸口见沉大而滑之脉。但举寸口。则关后无脉可知。气血宛于上。冲动脑气。一进昏晕而为暴厥。血逆行而入于脑。则血络暴裂死。故唇口青。青者。血凝而死色见也。若冲激不甚。血随气还。身和汗出而愈矣。须知入藏入府为假设之词。观下文在外入里可知。不然。气血并而上逆。方异其下行为顺。岂有入藏即死。入府即愈之理。门人章次公言入藏为脑充血。脑膜为热血冲破。一时血凝气脱。故唇口青身冷者死。脑固藏而不泻也。入府为气还三焦脉络。散入肌肤皮毛。故身和汗出者生。三焦固泻而不藏也。此与内经所谓气与血并走于上。则为大厥。厥则暴死。气复还则生。不还则死。其义正同。否则云并走于上矣。内经虽未明言脑。而其旨甚明。尤在泾犹强指为腔内之五藏。通乎否乎。章说较鄙人为

详尽。故并存之。

问曰。脉脱入藏即死。入府即愈。何也。师曰。非为一病。百病皆然。譬如浸淫疮。从口起流向四肢者可治。从四肢流来入口者不可治。病在外者可治。入里者难治。

上节独言寸口。则有上无下。脉垂脱矣。则此云脉脱。当指无脉言之。陈修园以为脱换之脱。非也。按伤寒论云。利厥无脉。服白通汤加猪胆汁。脉微续者生。暴出者死。微续者。胃气尚存。故曰入府即愈。暴出者真藏脉见故曰入藏即死。非为一病下。特推广言之。譬之浸淫疮。湿热兼毒之皮肤病也。天痘溃烂入口者死。广疮入口者死。若小儿天泡疮黄水疮。未见有从四肢流入口者。盖亦外病流脂水者。通名浸淫耳。病在外者可治。入里即死。以伤寒病论。则三阳可治。三阴难治。以疮疽言。则仲痛色红者可治。平陷色白甚至痛者难治。故师言百病皆然也。

问曰。阳病十八。何谓也。师曰。头痛。项腰脊臂脚步掣痛。阴病十八。何谓也。师曰。咳上气喘哕咽阳鸣胀满必痛拘急。五藏病各有十八。合为九十病。人又有六微。微有十八病。合为一百八病。五劳七伤六极。妇人三十六病。不在其中。清邪居上。浊邪恶居下。大邪恶中表。小邪中里。谷托之邪。从口入者。宿食也。五邪恶中人。各有法度。风中于前。寒中于后。泾伤于下。风令脉浮。寒令脉急。雾伤皮腠。泾流关节。食伤脾胃。极寒伤经。极热伤络。

治病以明理为先务。设病理不明。死守成方。则同一病证。且有宜于彼而不宜此者。则阳病十八一节。当是为拘守成方治病者言之。然变证虽多。岂可拘于十八之数。阳病十八。阴病十八。五藏病各有十八。六微复有十八病。令学者于此。昏无所得。若涉大川。不见津涯。卒致临证不敢用药。谤徨歧路。不知所归。此亦仲师之过也。惟善读书者。正不当以辞害意。今姑就所举之病名而释之。凝者关焉。病在外体为阳。寒邪袭表。体温郁而不达。则阳热上冲而病头痛。风中于筋。郁而不达。则病头痛。肠胃不通。燥气上于脑。则病头痛。闭症发热。血气上入于脑。则病头痛。又有气挟热血宛而犯脑。则亦病头痛。头痛同而所以为头痛者不同。项为太阳经脉出脑下行之路。风寒外束。热血抵抗。胀脉历兴。项因强痛。寒凝太阳之脉。发为脑疽。则项亦强痛。项之强痛同而所以强痛者不同。腰为少阴寒水之藏。下按输尿管而输入膀胱。寒湿内阻三焦。水道不通。则病腰痛。强力举重。气阻胁下。则病腰痛。汗出为冷。久为肾著。则腰下冷嘲热讽痛。腰痛同而所以为腰痛者不同。太阳能经络。夹脊抵腰中。而脊髓则为督脉。寒袭于表。经络不舒。则背脊痛。强力入房。伤其督脉。则背脊亦痛。脊痛同而所以为脊痛者不同。四肢者。诸阳之本。湿流关节。则臂脚步掣痛。风中四末。四肝不用。则臂脚亦掣痛。血不养筋。筋络强急。则臂脚亦掣痛。此外复有肢节疼痛。脚步肿如脱之历节。阳明燥实。伤及支脉。右髀牵掣膝外廉而痛。寒湿流筋髀肉内痛。掣痛同所以掣痛者不同。复有脚气肿痛者。痛而腹中麻木。属血分。宜四物加生附牛膝防已呈莢木器厂瓜以治

之。腹中急痛者。属气分。宜鸡鸣散以治之。又有血络不通。脚变急者。宜芍药甘草汤以治之。有肠燥伤筋而脚变急者。宜大承气以治之。此又脚病之不同也。然则阳病十八与多数而言之也。病在内脏为阴。风伤于肺则咳。膈间支饮则咳。肠中燥气犯肺则咳。咳固不必同也。谬痰在中脘。不能不时倾吐则上气。水痰在心下。阳气欲升不得则上气。上气固不同也。寒缚表阳。外不得汗则喘。元气下虚。肾不纳气则喘。喘固不必同也。呃逆之证。有属胃气虚寒者。有属大肠腑滞不行。及膀胱小溲不利者。则哕固不同也。咽当为噎。老年之人。血气并亏。有食未入胃。梗于胸膈而不上者。又有噎膈之证。既入于胃。梗塞而不下者。是噎又不同也。水湿入肠。下利不止。则病肠鸣。痰饮为病。水入肠间。则亦肠鸣。虚劳之人。亦复肠鸣。是肠鸣又不同也。太阴寒湿。则腹中胀满。水结膀胱。则少腹胀满。宿食不化。则腹中胀满。血结胞门。则少腹胀痛。是胀满又不同也。久事伛偻。胸中阳气否塞。则心痛微背。阴寒凝结膈。则亦心痛彻心。是心痛又不同也。虚劳之人输尿管不通小便不利而腰痛者。小腹为之拘急。下后发汗。津液亏耗。则筋脉为拘急。是拘急又不同也。然则阴病十八。亦举多数言之也。若夫五脏之病。散见内经及元化中藏经者。不胜枚举。第就本书著录者言之。曰肺痿。曰肺郁胀。曰肺中风。曰肺中寒。曰肺饮。曰肺水。此肺病之可知者也。曰肝中风。曰肝中寒。曰肝著。曰肝乘脾。曰肝乘肺。曰肝虚。曰肝实。此肝病之可知者也。曰心中风。曰心中寒。曰心中痛。曰心下痞。曰心下悸。曰心烦。曰心。此心之可知者也。曰脾中风。曰脾中约。曰脾水。此脾病之可知者也。曰肾著。曰水在肾。曰奔豚。此肾病之可知者也。谷瘕。宿食。呕吐哕。反胃。消渴不能食。食已即吐。胃病也。肠壅下利清谷。不大便。圉脓血。肠病也。胁下痛。小便不利。遗溺。三焦病也。寒则下重便血。热则为痔。小肠病也。呕吐。口苦耳聋。下利纯青。胆病也。膀胱无专病。时与三焦相出入。此六府病之可知者也。然则五脏病各有十八。合为九十。微在十八病。合为一百八病。要不过示人病出了经。寒热虚实之不同者。居其多数。不当泥成法以为治耳。不然病之变证。多端一切以十八限之。而谓绝无增减有是理乎。据后文五劳七伤六极。妇人三十六病。不在其中。便可识立言之旨。在多数而不在定安数。自此以下。略为疏折病源。风露中人。挟高寒之气。故清邪居上。湿热蕴蒸。挟地中水气而出。故浊邪居下。六气中人。起于皮毛。故大邪中表。气体先虚。邪乃乘之。故小邪中里。系即谷字。传写者误作系耳。饪尤本作饪。饼也。谷饪之邪。从口入者。为宿食。胃中胆汁胰液不足。消化之力薄也。曰五邪中人。各有法度。胃邪之中人。各不可变易之处。风为阳邪。已至上。为阳气方盛。故风中于前。寒为阴邪。申至戌上。为阴风始出。故寒中于暮。湿从地升。太中于下。足先受也。雾散空中。故中于上。头先受也。风脉浮缓其表疏也。寒脉浮急。其表实也。雾伤皮腠。乃生癣疥。湿流关节。因病历节。食伤脾胃。是病腹痛。极寒伤经。项背斯痛。极热伤络。不病吐衄。即圉脓血。可以识辨证之大纲矣。

问曰。病有急当救里救表者。何谓也。师曰。医下之。续得下利清谷不止。身体疼痛者。急当救里。后身疼痛。清便自调者。急当救表也。

此下二节。皆以治病缓急言之。治病大法。固当先表后里。如伤寒论太阳未罢。阳明化燥。先其表。后攻其里。此其常也。若夫太阳失表。一经误下。汗反入里。遂有水激中脘。直走小肠大肠。至于完谷不化者。此时水寒湿陷。中阳垂绝。危在须臾。虽有身痛当汗之太阳表证。正当置为后图。而急温其里。譬之侍疾之人。忽闻兴下失火。势必殒息往救彼其心。非不爱病者。有急于此者也。若内脏无病。但有身疼痛之表证。则一汗可以立愈。不烦再计矣。（此条见伤寒论）

夫病痼疾。加以卒病。当先治其卒病。后乃治其痼疾也。

病之暴起者易变。而痼疾则无变。变则加剧。不变则固无害也。故曰先治卒病者。伤寒也。虽然痰饮痼疾也。感于表寒而病。可用小青龙汤以汗之。膈间支饮。痼疾也。伤寒胃家实。可用大陷胸汤以下之。然则痼疾卒病，何裳不可同治乎。善治病者。可以观其通矣。

师曰。五脏病各有所得者愈。五脏病各有所恶。各随其所不喜者为病。（得、古作合解、音会、与人契全日相得）

五脏病各有所得者愈以五味为最近。本篇首节举例甚至明。肝虚者补用酸。故厥阴病之乌梅丸。以乌梅为君。肝虚乘脾。则腹中急痛。急痛者。肝叶燥而压于脾。脾气不舒。痛延腹部。因用甘草味之药以实脾。故小建中汤方治。以饴糖为君。若入心。故泻心汤降逆方治。以黄连为君。辛入肺。故十枣汤泻痰泄水方治。以芫花为君。（近人以芥菜卤治肺癰、白芥子治痰饮、同此例。卤入肾。故小便不利之蒲灰散。以蒲灰为君。（此节水中菖蒲烧灰、近人以为蒲黄则误。）

茯苓或盐汤。治小便不利。亦此意也。此五脏之病。各有所得而愈之大略也肺恶寒而主皮毛。寒由皮毛犯肺。则病伤寒，汗出不彻。水在膈间。即病喘咳。脾恶湿而主肌肉。外风凝互肌腠。因病中风。留著不去。渗入关节。因病历节。湿与水并居。留于中脘。即病痰饮。下陷大肠。即病下利。泛滥充塞。即病水肿。心恶燥亦恶水。胆胃燥气上薄心藏。则心气不足。而病吐血衄血。是为泻心汤证。水气凌心。则心下悸。是为小青龙汤证。肝恶燥。燥则胆火盛而病消渴。肝恶拂郁。有所逆则乘脾。而腹中急痛。肝又恶湿。湿胜而血败。秽浊年聚。尤病乃作。肾恶寒。水寒则血败。因病下血。肾又恶燥。藏燥则精竭。筋脉不舒。因病痿痹。此五藏各有所恶之大略也。脾喜燥而恶湿。多饮茶酒。则病湿痰。多卧湿地。则病风痹。肺喜温而恶寒。形寒饮冷。则病寒饮。风寒袭肺。皮毛不开。则病风湿。肾喜温而恶水。水停胁下。则小便不利。不病腹满。即病腰痛。肝喜凉而恶热。血虚生燥。则病善怒。气上撞心。（心为君主之藏、无所谓喜、亦无所谓恶、其偶亦有病、变不过他藏所牵及耳。心喜静而恶人人皆但不在病情之中、故不述）血热伤络。则便脓血。此则五脏之气。随其所不喜为病之大略也。要而言之。脾脏湿。故恶湿。肺腑凉。故恶寒。心脏热。故恶热。肾多水。故恶水。肝脏合胆火生燥。故恶燥。此藏气有

余而为病者也。然发汗太过。脾精不濡。痉病乃作。肠胃燥实。肺热叶焦。乃生痿辟。心阳不振。则脉郁结代。肾寒精冷。令人无子。肝脏血寒。则病厥逆。然则藏气不足。又何裳不为病乎。究之治病当求其本。断无成亦之可拘。读金匱者。亦观其通焉可耳。

病者素不应食。而反暴思之。必发热也。

此三句当别为一节。古本与五脏病混而为一。以致不可解说。陈修圆以为藏气为病气所变。直臆说耳。夫曰素不应食。原非素不喜食。为使病本不欲食者言之耳。此证或出于病后。或出于病之将愈。盖病气之吉凶。原以胃气之有无为验。病固有时证悉去。始不能纳谷以致于死者。此固有胃则生无则死之明证也。但胃气之转。为病者生机。与脉伏之复出同。脉暴出者死。渐起者生。故胃气之转。亦以渐和为向愈。暴发为太过。夫胃主肌肉常人过饥。忍饥则瑟恶寒至饱食之后肢体乃渐见温和。故厥阴篇有厥利欲食以素饼而发热。热者即为不死之。微但病后胃火太甚。即有急欲得食。食已即发壮热。而病食复者。予于家人见之。亦有阳明燥热。饱食之后。以致累日不大便。一发热而手足拘攀者。予于沉松寿见之。此仲师劳复篇中所以用博棋大五六枚之大黄。内经治痿所以独取阳明也。

夫诸病在脏。（此脏字当作藏历之藏解、谓病藏证在里也、非指五脏、学者其勿误）欲攻之。当随其所得而攻之。如渴者与猪苓汤。余皆放此（猪苓汤方见伤寒论阳明篇又见后消渴证中、以猪苓之利湿、所以通其小便、以阿胶之滋阴、所以解其渴、此猪苓汤所以为利小便而兼解其渴之神方也、攻其实而补其虚、惟仲师能深知其内情。诸病在脏为里证。别于皮毛肌腠筋络言之。非谓五脏也。此节表明因势利导之治法。特借渴者与猪苓汤以起例。盖下利则伤津液而渴。加以小便不利。水气在下。是当以利小便为急。然又恐甚其渴。与猪苓汤。则既解其渴。又利小便。此一举两得之术也。如伤寒转矢气。及宿食下利脉滑。可用大承气。亦此例也。

痉湿喝脉证第二

太阳病。发热无汗。恶寒者。名曰刚痉。

太阳病发热汗出。而不恶寒。名曰柔痉。

此二证。说解详伤寒发微。风寒外薄。血热内张。正与邪相争。故名刚痉。汗出表疏。正气柔弱。不与邪争。故名柔痉。

太阳病。发热。脉沉而细者。名曰痉。为难治。

此条见伤寒论。盖痉为津液枯燥之证。卫气不和于表。故发热。营气不足于里。故脉沉细。发热为标阳。脉沉细则为本过时。里气不温，则水寒不能化气。是当用栝蒌桂枝以解表。加熟附以温里。释详伤寒发微兹不赘。

太阳病。发汗太多。因致痉。

此条典见伤寒论。释解具详伤寒发微。兹不赘。

夫风病。下之则痉。复发汗。必拘急。

风病。陈修圆以为发热有汗之桂枝汤证。是不然。太阳病固自有先下之不愈。因复发汗。表里俱虚。其人因致冒。终以自汗解者。亦有下后气上冲。而仍宜桂枝汤者。亦有误下成痞。误下成结胸者。独发汗致痉之证。为中风所希见。则所谓风病者。其为风温无疑。夫风温为病。其受病与中风同。所以别于中风者。独在阴液之不足。故脉浮自汗心烦脚攀急者。不可与桂枝汤。得汤便厥。所以然者。为其表阳外浮。里阴内虚。阴不抱阳。一经发汗。中阳易于散亡也。俱此犹为证变未甚也。更有脉阴阳俱浮。自汗出身重息鼾。言语难出之证。一经误下。即见小便不利。直视夫洩。若火劫发汗。则瘵瘵如惊。所以然者。里阴素亏。误下则在上之津液下夺。日系因之不濡。火劫则在里之津液外烁。筋脉因之不濡。津液本自不足。又从而耗损之。风燥乃益无所制。故上自日系。下及四肢。无不拘急。而痉病成矣。不然。本篇汗出发热不恶寒之柔痉。与伤寒温病条之不恶寒。何其不谋而合乎。是知中风一证。津液充足。虽误汗下。未必成痉。惟津液本虚者。乃不免于痉也。

疮家虽身疼痛。不可发汗。汗出则痉。

此条见伤寒太阳篇。盖人之汗液。由卫气外出者属水分。由营气外出者属血分。身疼痛。原系寒凝肌腠。急当发汗以救表。惟疮家营分素亏。一经发汗。血液重伤。至于不能养筋。一身为之拘急。是亦投鼠忌器之过也。夫病至无可措手。要当用

药薰洗。使邪从外解。而不当任其疼痛。如浮萍叶本荆芥薄荷防风等味。俱可煎汤薰洗。但使略有微汗。疼痛当止。（语详伤寒发微）

病者身热足寒。颈项强急。恶寒。时头热。面赤。目赤。独头动摇。卒口噤。背反张者。痉病也。若发其汗。其脉如蛇。

此条见伤寒论本篇而佚其后半节。身热至恶寒。为葛根汤证。时头热至背反张。为大承气汤证。（语详伤寒发微）惟发其汗下。当有衍文。痉病之未成。原有属于太阳而当发汗者。惟已传阳明。燥气用事一经发汗。即见经脉强急。不当有寒湿相得。其表益虚。恶寒益甚。之变数语似属湿证脱文。不知者误列于此。陈修圆明知阳邪用事。热甚灼筋。不当恶寒。犹为之含混强解。此亦泥古之过也。愚按若发汗其脉如蛇。独承上时头热面赤以下言之。非承上身热足寒言之也。内经云。肝主筋。肝脏血虚生燥。则其脉弦急。后文所谓直上下行是也。发其汗。其脉如蛇。乃肝真藏脉见。五脏风寒积聚篇所谓肝死脉浮之弱按之如索不来或曲如蛇行者死也。盖痉病脉本急。重发汗，则经脉益燥。直上下行之弦脉。一变而成屈难伸之状。脉固如此。筋亦宜然。一身之拘急可知矣。黄坤载以为即直上下行。非是。

暴腹胀大者。为欲解。脉如故。及伏弦者。痉。（此节承上节言之、脉如故、即上之其脉如蛇也。）

夫痉脉。按之紧如弦。直上下行。

痉病之成。始于太阳。而传于阳明。太阳水气。受阳明燥化。阴液消烁。筋脉乃燥。但阳明不从标本而从中气。容有一转而入太阴者。伤寒太阳篇发汗后腹胀满面厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。即此证也。痉病本由血少。统血之脾藏当虚。而复以发汗张其虚气。病乃转入太阴。而腹部虚胀。病机由表入里。筋脉不更受灼。故为欲解。惟下文脉如故。反伏弦。则殊不可通。沉弦则非曲如蛇行矣。何得云如故耶。按此反字当为及字。传写之误也。脉如故。即上节曲如蛇行之谓。沉弦。即下节直上下行。。其所以屈曲如蛇者。为其脉中营气不足。汗后阳气暴张。气欲行而血不从也。所以直上下行者。为血分热度增高。脉道流行。暴张而副省长也。夫血少则筋燥。悬生物之筋于风中可证也。热血灼筋，则亦暴宿。投生物之肉于沸油中可证也。故痉病之作。由于筋之受灼。验之于脉。无不可知。血虚固伤筋。血热亦伤筋也。

痉病有灸疮。难治。

痉病为风燥伤筋之证。血虚不能养筋。而复加以灸疮。使其证属中风传来。则当用栝蒌根以生津。桂枝汤以发汗。然又恐犯疮家发汗之戒。故云难治。但里急于外。又不当先治灸疮。耦意先用芍药甘草加生地以舒筋。加黄耆防风以散风。外用圻灰

年久者。调桐油以清热毒而生肌。其病当愈。陈修圆浅注谓借用风引汤去桂枝干姜一半。研末煮服。往往获效。盖此方主清热祛风。揆之于理。当自可用。

太阳病。其证备。身体强。几几然。脉反沉迟。此为痉。栝蒌桂枝汤主之。

栝蒌桂枝汤方。

栝蒌根（二两）桂枝（三两）芍药（三两）甘草（二两）生姜（三两）大枣（十二枚）

右六味。以水九升。煮取三升。分温三服。微汗。汗不出。食顷。啜热粥发之。

太阳病。其证备。则颈项强痛。发热自汗。恶风之证也。身体强几几。背强急而不能舒展。邪陷太阳输也。自非将成痉证。则有汗之中风。脉宜浮缓。而不宜沉迟。夫痉脉伏弦。沉即为伏。迟为营气不足。此正与太阳篇无血尺中迟者同例。血不养筋。而见沉伏之痉脉。故以培养津液为主。而君栝蒌枝。仍从太阳中风之桂枝汤。以宣脾阳而达营分。使卫与营和。汗出热清。筋得所养。而柔痉可以不作矣。

太阳病。无汗。而小便反少。气上冲胸。口噤不得语。欲作刚痉。葛根汤主之。（葛根汤方、葛根四两、麻黄三两去节、桂枝、甘草炙、芍药各二两、生姜三两、大枣十二枚、上七味、以水一斗、先煮麻黄葛根、减三升、去沫、内诸药、煮取三升、去渣、温服一升复取微似汗、不须啜粥、余如桂枝汤法将息及禁忌。）

太阳病无汗。小便少。气上冲。此与太阳篇下后气上冲。可与桂枝汤如前法同。惟筋强急。牙关紧而见口噤。风痰阻塞会压而不得语。实为刚痉见端。以气上冲而用桂枝。此为太阳中风正治法。惟本证为风寒两感。寒互皮毛。内阻肺气。故外见无汗。内则会压隔阻。故本方于桂枝汤加麻黄。期于肌表双解。太阳经输在背。邪陷经输。久郁生燥。于是背反张。卧不苦席之变。故于肌表双解外。复加葛根。从经输达邪外出。而刚痉可以立解。所谓上工治未病也。按此方本为太阳标热下陷经输而设。故加清热润燥上升之葛根。于背强痛者宜之。推原所由成。以外风陷太阳为标准。无论刚痉柔痉一也。柔痉起于中风。故用栝蒌桂枝汤。栝蒌生上行。主清经络之热。功用与葛根同。刚痉之成。起于风寒两感。故用葛根汤。盖非风不能生燥。非风窜经输恶性循环不成痉。可以识立方之旨矣。

痉为病。胸满。口噤。卧不着席。脚惊急。必介齿。可与大承气汤（大承气汤方、大黄四两酒洗、厚朴半斤炙去皮、枳实五枚炙、芒硝三合、上四味、以水一斗、先煮枳朴、取子升、去渣、内大黄煮二升、内芒硝更上微火一两沸、分温再服、得下利、余勿服。）

风燥入阳明之府。津液受灼。上膈乃有湿痰。痰阻胸膈。风痰塞会压。而阳热上灼。牙关之筋燥急。则口噤。背脊经输干燥。则卧不着席。周身筋脉液干而缩。故肢惊于下。齿龄于上。可与大承气汤。此亦急下存阴之义也。盖必搜其燥热。然后膈上之风痰。得以下行。周身筋脉。亦以不受薰灼而舒矣。下后叶其余药者。正以所急筋脉。非燥矢宿食可比。故不日宜而日兴。独怪近世儿科。既不识痉病所由来。而概名为惊风。妄投镇惊药。杀人无算。为可恨也。

太阳病。关节疼痛而烦。脉沉而细者。此名中湿。亦名湿痹。湿痹之候。小便不利。大便反快。但当利其小利。

前篇曰湿流关节。又曰湿伤于下。盖太阳病汗出不彻。由腠理流入肢节空隙。因病竣疼。是为历节所由起。阳气为寒湿所遏故内烦。脉之沉细。在痉病为寒水在下不能化气。湿病亦然。湿者。水及膏液合并。滞而不流。若痰涎然。下焦垢腻。故小便不利。水道壅塞不通。溢入回肠。故大便反快。大便有日三四行。而饮食如故者。是宜五苓散倍桂枝。但得阳气渐通。而小便自畅。大便之溏泄。固当以不治治之。余解详伤寒发微。不赘。

湿家之为病。一身尽疼。身色如薰黄也。

湿家之病。起于太阳寒水。表汗不出。则郁于肌理。而血络为之不通。一身尽疼者。寒湿凝互肌腠也。此证则恶寒。继则发热。终则湿热蕴蒸。而身色晦暗如薰黄。湿证小便不利。大率以麻黄加术为主方。师所以不出方治者。要以病变多端。随病者之体温为进退。血分温度不足。易于化寒。温度太高。易于化燥。未可执一论治也。说解详伤寒发微。

湿家。其人但头汗出。背强。欲得被覆向火。若下之早。则哕。或胸满。小便不利。舌上如胎者。以丹田有热。胸上有寒。渴欲得饮而不能饮。则口燥烦也。

但头汗出。约有二端。阳热之证。阴液内竭。则但头汗出。寒湿之证。毛孔闭塞。则亦但头汗出。寒湿郁于经输。故背强。（此与太阳病之项背强同）寒互皮毛。内连肌肉。恶寒甚至者。遂欲得被子向火。（此与太阳伤寒同）此时正宜麻黄加术汤以发其汗。使水气外达。中气化燥。不得已而后下。然下之太早。水气太甚。随药内陷。与人体之膏液并居。留于上膈。则渍寒呃胸满。陷于下焦。则滋腻之湿。阻于水道。小便为之不利。此证寒湿在上。郁热在下。故有时渴欲饮水。水入口而不能不咽。促师不立方治。陈修圆补用黄连汤。（语详伤寒发微）

湿家。下之。额上汗出。微喘。小便利者。死。若下利不止者。亦死。

湿家水异。水可从小便去。而湿不可去。水清。而湿浊也。与燥反。燥结者易攻。

而湿不可攻。燥易去而湿粘滞也。故下之而湿流上膈。故有胸满小便不利之变。但此犹易为治也。至下后阳气上脱。至于上汗出如珠。微喘而气咻咻若不续。阴液下脱。而小便反利。或下利不止。疾乃可为矣。按伤寒阳明证。于下法往往慎重者。亦以太阳之传阳明。下燥不胜。上湿恐下后利遂不止也。否则宿食下利脉滑者。犹当用大承气汤。何独于阳明证而反不轻用乎。

风湿相搏。一身尽疼痛。法当汗出而解。值天阴雨不止。医云。此可发其汗。汗之病不愈者。何也。盖发其汗。汗大出者。但风气去。湿气在。是故不愈也。若治风湿者。但微微似欲汗出者。风湿俱去也。

太阳病。发汗后。或自汗。风邪乘之。毛孔闭塞。汗液之未尽者。留著肌理成湿。一身肌肉尽痛。是为风湿相搏。此证本应发汗。现太阳伤寒之体痛同。后文麻黄加术汤。麻黄杏仁薏苡甘草汤。其主方也。以麻黄之发汗。白术薏苡之去湿。本期风湿俱去。然适当天时阴雨。病必不去。药可与病气相抵。而地中之湿。与雨中之寒。决非药力所能及。故虽发汗。病必不愈。（说解伤寒发微）

湿家，病身上疼。发热。而黄而喘。头痛鼻塞而烦。其脉大。自能饮食。腹中和。无病。病在头中寒湿。故鼻塞。内药鼻中则愈。

湿家身上疼。非一身尽疼之比。风湿在皮毛。故发热。湿郁则发黄。湿在上体故而面黄。肺气不宜故喘。头痛鼻塞。风湿入脑之明证也。惟内药鼻中则愈。仲师未出方治。予每用煎药薰脑之法。倾药于盆。以布幕首薰之。汗出则愈。（详伤寒发微、头痛甚者加独活。）

湿家。身烦疼。可与麻黄加术汤。发其汗为宜。慎不可以火攻之。

麻黄加术汤方

麻黄（三两去筋）桂枝（二两）甘草（一两）白术（四两）杏仁（七十个去皮尖）

右五味。以水九升。先煮麻黄减二升。去上沫。内诸药。煮取二升半。去渣。温服八合。复取微汗。

太阳寒水。发于外者为汗。壅阻皮毛之内即成湿。故太阳伤寒。皮毛不开。无汗恶寒发热体痛者。宜麻黄汤以汗之。湿家发热身疼者。宜麻黄加术汤以汗之。加术者。所以去中焦之湿也。盖水湿凝互肌肉。血终停阻。乃病疼痛。壅疽。之生患难与共处必先疼痛者。血络瘀结为之也。故欲已疼痛者。必先通其不通之血络。阴疽之用阳和汤。亦即此意。若急于求救。而灼艾以灸之。断葱以熨之。或炽炭以薰之。毛孔之内汗液被灼成菌汗乃愈。不得出而血络之瘀阻如故也。况火劫发汗。汗洩而

伤血分。更有发黄吐血衄血之变乎。

病者。一身尽疼。发热。日晡所剧者。此名风湿。此病伤于汗出当风。或久伤取冷所致也。可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

麻黄薏苡甘草汤方

麻黄（半斤）杏仁（十个去皮尖）薏苡（半两）甘草（一两炙）右做麻豆大。每服四钱匕。（匕者。茶匙也、四钱匕者、四茶匙也。）水一盞半。煎八分。去渣温服。有微汗。避风。

一身尽疼。为寒湿凝互肌理。血络阻滞作痛。若阴疽然。前文已详言之。发热者。寒湿外闭。血分之热度。以阻呃而增剧也。日晡所为地中蒸气上腾之时。属太阴湿土。故阳明病欲解时。从申至戌上。所以解于申至戌上者。为热盛大之证。当遇阳衰退阴盛而差也。明乎此。可知申至戌上为太阴主气。湿与湿相感受。故风湿之证。常当日晡所剧。究病之所由成。则或由汗出当风。或由久伤取冷。内经云。形寒饮冷则伤肺。肺主皮毛。务令湿邪和表热。由皮毛一溲而尽。其病当愈。师所以用麻黄汤桂枝加薏苡者。则以薏苡能去湿故也。

风湿。脉浮身重。汗出恶风者。防己黄耆汤主之。

黄已黄耆汤方

防己（一两）甘草（半炙两）白术（七钱半）黄耆（一两一分）

右做麻豆大。每抄五钱匕。生姜四片。大枣一枚。水盞半。煎八分。去渣温服。喘者。加麻黄半两。胃中不和者。加芍药三分。气上冲者。加桂枝三分。下有陈寒者。加细辛三分。服后当如虫行皮中。自腰下如冰。后坐被上。又以上被子绕腰下。温令微汗差。

脉浮为风。身重为湿。汗出恶风。为表气虚，而汗溲不畅。此亦卫不与营和之证。防己溲热。黄耆助表气而托汗畅行。白术炙甘草补中气以胜地湿。此亦桂枝汤助脾阳俾汗出肌腠之意也。（按本条方治下所列虫行皮中云云、殊不可通。此证本非无汗、不当云服药后令微汗差。本方四味俱和平之剂、非尽汗猛剂。何以服之便如虫行皮中、且何以腰下如冰冷、谬二。且阳明久虚无汗、方见虫行皮中之象、为其欲汗不得也、何以服汤后反见此壮、谬三。此必浅人增注、特标出之。

伤寒八九日。风湿相搏。身体疼烦。不能自转侧。不呕不渴。脉浮虚而涩者。桂枝附子汤主之。（桂枝附子汤方、桂枝四两、附子三枚炮去皮破八片、生姜三两切、

甘草二两切、甘草二两炙、大枣十二枚擘、上五味、以水六升、煮取二升、去渣、分温三服）若大便坚。小便自利。去桂枝加白术汤主之。

白术附子汤方

白术（一两）附子（一枚泡去皮）甘草（二两炙）生姜（一两半）大枣（六枚）

右五味，以水三升。煮取一升。分温三服。一服觉身痹。半日许再服都尽。其人如里状。勿怪。即是术附并走皮中。遂水气。未得除故耳。

此条见太阳篇。说解详伤寒发微。于不呕不渴及大便坚小便自利二证。辨则至为明聊。兹特举其示备者言之。桂枝附子汤。为阳旦汤变方。而要有差别。阳旦之证。表阳盛而营血示为湿困。故加桂以助芍药之浅营。此证脉见浮虚而涩。表阳已虚。营血先为湿困。故但加熟附以温里。以营虚不可浅。而去疏营气芍药。阳旦所以用生附者。所以助里阳而浅在表之水气也。此用熟附三枚者。所以助表阳而化其湿也。彼为表实。此为表虚也。顾同一风湿相搏。身体疼烦不能转侧。不呕不渴之证。何以大便燥小便自利者。便须加白术而去桂枝。加术为去湿也。大便坚小便自利。似里已无湿。而反加白术。身烦疼不能自转侧。似寒湿独留于肌腠。而反去解肌之桂枝。此大可疑也。不知不呕不渴，则大便之坚直可决为非少阳阳明燥化。小便自利。则以阳气不行于表三焦。水道以无所统摄而下越也。盖此证小便色白。故用附子以温肾。湿痹肌肉。故加白术以扶脾。但使术附之力。从皮中运行肌表。然后寒湿得以从汗解。津液从汗后还入胃中。肠中乃渐见润泽。大便之坚。因当以不治治之。

附服白术附汤后见象解。商书云。若药勿螟眩。厥疾弗瘳。旨哉言乎。篇中大剂每分温三服。独于白术附子汤后。详言一服觉身痹。痹者。麻木之谓。凡服附子后。不独身麻。即口中额上俱麻。否则药未中病。即为无效。予尝亲验之。继之日三服都尽。其人如冒状。勿怪。即术附并走皮中。水气未得除故耳。夫所谓里冒者。如中酒之人。欲呕状。其人头晕眼花。愤愤无可奈何。良久朦胧睡去。固已渍然汗出而解矣。此亦余所亲见。独怪今之病家。一见麻木晕。便十分悔恨。质之他医。又从而痛诋之。即病者已愈。亦称冒险。吾不知其是何居心也。

风湿相搏。骨节疼烦掣痛。不得屈伸。近之则痛剧。汗出短气。恶风不欲去衣。或身微肿。甘草附子汤主之。（甘草附汤方、甘草二两炙、附子二枚炮去皮、白术二两、桂枝四两、上四味。以水六升、煮取三升、去渣、温服一升、日三服、初服得微汗则解、能食、汗出复烦者。服五合、恐一升多者。宜服六七合为妙。）此与上节并见太阳篇。于伤寒发微烦掣疼不得屈伸。近之则痛剧。此可见寒湿流入关节。表里气血隔塞不通。（此与疮溃作痛略同、盖气血以不通而痛也。）不通则痛。此证暴为湿。积久即成历节。汗出短气。亦与历节同。湿犹在表。故恶风不欲去衣。

或身微肿。不似历节之纯为里证。风阳引于外。故小便不利。惟证情与历节同源。太方治亦相为出入。甘草附子汤。用甘草白术桂枝。与桂枝芍药和知母同。用熟附子二枚。与乌头五枚炙草三两同。惟一身微肿。似当用麻黄以发汗。仲师兼而不用者。正以湿邪陷入关节。利用缓攻也。否则发其汗而大汗出。风去而湿不去。庸有济乎。

太阳中喝。发热恶寒。身重而疼痛。其脉弦细芤迟。小便已。洒洒然毛从。手足逆冷。小有劳。身即热。口开前板齿燥。若发其汗。则恶寒甚。加温针。则发热甚。数下之。则淋甚。

中喝系在太阳。则伏气之说。正当不攻自破。发热恶寒。似伤寒。身重疼痛。似风湿。小便已洒洒然毛从。手足逆冷。又似表阳大虚。所以有此见象者。夏令天气郁蒸。汗液大洩。则其表本虚。表虚故恶寒。感受天阳。故发热。加以土润溽暑。地中水气上升。易于受湿。湿甚。故身重而内痛。小便已。洒洒然毛从者。暑令阳气大张。毛孔不闭。表虚而外风易乘也。所以手足逆冷者。暑湿郁于肌肉。脾阳顿滞。阳气不达于四肢也。是证营卫两虚。卫虚故脉见弦细。营虚故脉见芤迟。小有劳。身即热。口开。前板齿燥。此证要属阴虚。卫阳本虚之人。发汗则卫阳益虚。故恶寒甚。阴虚之人而加温针。故发热甚。营阳本虚之人。下之则重伤其阴。故淋甚。此证忌汗下被火。与太阳温病略同。但彼为为实证。故汗下被火后。多见实象。此为虚证。故汗下温针后。多见虚象。要之为人参白虎竹石膏汤证。固不当以形如伤寒。妄投熟药也。

太阳中热者。喝是也。汗出恶寒。身热而渴。白虎加人参汤主之。（白虎人参汤方、知母六两、生石膏一斤碎细绵里、甘草二两炙、粳米六合、人参三两、上五味、以水一斗、煮米熟、汤成去渣、温服一升、日三服。）

暴行烈日之中。则热邪由皮毛入犯肌腠。于是有太阳不热之病。外热与血热并居。则身热而汗出。暑气内侵。胃液旁洩为汗。则中燥热。因病渴饮。寒水沾滞。卫阳不固皮毛。故表虚而恶寒。陈修圆谓太阳以寒为本。虽似相去不远。究不免失之含混。此证用人参白虎汤。与太阳篇口渴渴心烦微恶寒同。然则本条所谓恶寒。与伤寒中风之恶寒甚者。固自不同也。

太阳中喝。身热疼重。而脉微弱。此以夏月伤冷水。水行皮中所致也。一物瓜蒂汤主之。

瓜蒂汤方

瓜蒂（二十个）

右以水一升。煮取五合。去渣顿服。

夏令地中水气随便阳上蒸。是为暑。暑者。湿热相搏之动气也。此气不著于人体则已。著于人体。无有不身热疼痛者。以有热复有湿也。但此证脉当浮大。所以然者。以血受阳热蒸化。脉道中热度必高。高者脉大。有表热而病气在肌肉。属太阳部分之第二层。与中风同。其脉当浮。而反见微弱之脉者。是非在浚寒泉瓷其溷濯。或者中宵露处卧看星河。皮中汗液未出者。乃一时悉化凉水。此即心下有水气之水。不由外入。水渍皮中。因病疼重。暴感阳热。转被郁陷。因病身热。瓜蒂苦泄。能发表汗。汗出热泄。其病当愈。伤寒发微中附列治验。兹不赘述。（予意浮萍煎汤薰洗、亦当有效、他日遇此证、当试验之）

百合狐惑阴阳毒病证治第三

论曰。百合病者。百脉一宗。悉致其病也。意欲食。复不能食。常默然。欲卧不能卧。欲行不能行。饮食或有美时。或有不欲闻食臭时。如寒无寒如热无热。口苦。小便赤。诸药不能治。得药则剧吐。如有神灵者。身形如和。其脉微数。每溺时头痛者。六十日乃愈。若溺时头不痛。淅淅然者。四十日愈。若溺快然。但头眩者。二十日愈。其证或未病而预见。或病四五日而出。或二十日或一月后见者。各随证治之。

百合之病。余未之见。然意则可知。仲师以百脉一宗悉致其病为提纲。即可知其病在肺。盖饮食入胃。由脾阳运行上承于肺。乃朝百脉而输精皮毛。百脉精液得以沾既而不燥者。肺为水之上源。足以贯输而不竭也。故肺主一身治节。而独为五脏主。肺主皮毛。过于发汗。则肺液由皮毛外泄。而水之上源一竭。肺与大肠为表里。过于攻下。则太阳寒水由大肠下陷。而水之上源再竭。咽为食管。喉为气管。并接会压。吐之太过。则胃液竭而肺液亦伤。而水之上源三竭。三者之中。苟犯其了。则肺必燥。肺燥则无以滋既百脉。而百脉俱病。加以肺阴虚耗。病延血分。阴络内伤。肠中败血瘀阻。或由上源虚耗。胃中生燥。因病渴饮。或久渴不愈如消渴状。况肺阴一虚。易生内热。水泽不降。虚阳外浮。是生表热。病情不同。皆当以补肺之百合为主治之方药。此百病之大略。可由方治而揣测者也。肺阴不濡。则浊气不降。清气不升。诸藏之气。悉为顿滞。是太胃气顿滞。则欲食而不能食。意与萧索。百事俱废。故常默然。且肺阴不降。胆火上逆。因病烦躁。故欲卧不能卧。欲行不能行。肺阴虽伤。胃气尚存。故饮食或有美时。然以筋脉懈弛。不能动作。中脘易于停顿。故或有不欲闻食臭时。肺主皮毛。肺阴伤则卫阳不能卫外。微觉恶风。故似寒无寒。津液不濡皮毛。时苦干燥。故如热无热。口苦者。肺阴不能滋既中脘而胆胃燥也。小便赤者。水之上源不足而下焦热郁也。溺时头痛者。水液下泄。郁热上冲于脑也。冲激不甚。则太阳穴经脉跳动。而但见淅淅然似痛非痛小便畅适。但有浮阳上冒。而病头眩。则其病更轻。若不知其肺阴之虚。而误投药剂。热药入口即吐。为其阴虚而内热也。凉药入胃即利。为其初无实热也。所谓如有神灵者。正如左氏传所云普候梦二竖。居膏之上。药所不能攻。针所不能达。使良医无能为力也。但病者身形虽如微和。其脉必见微数。微数者。肺阴亏而水之上源不足以即五脏而濡百脉。五脏热郁而经脉俱燥也。故此证但补肺阴。而诸恙不治当愈。譬之发电总机一开。而万灯齐明。万机齐动。所谓伏其所主也。此证或未病而见者。肺阴先虚也。或既病而见者。肺阴因病而虚也。或二十日一月后见者。则药误也。所以致此病者不同。故治法亦略有差别。此证大抵出于失志怀忧之人。平时本郁郁不乐。以致此病一发。行住坐卧饮食。不能不自主。若有鬼物驱遣之者。口中喃喃。时欲速死。又如前生怨鬼索命。世无良医。无怪乡愚病此。召幽灵而女巫唱秋贲之鬼曲。设香颤而道士擅司令之淫威。未收愈疾之功。而已室如悬击矣误用哉。

百合病。发汗后者。百合知母汤主之。

百合知母汤方

百合（七枚）知母（三两）

右先以水洗百合。渍一宿当白沫出。去其水。别以泉水二升。煎取一升。去渣。别以泉水二升煎知母。取一升。后合煎一升五合。分温再服。

百合病。下之后者。百合滑石代赭汤主之。

百合没有石代赭汤方。

百合（七枚）滑石（三两碎绵里）代赭石（如弹丸大一枚碎绵里）

右先煎百合如前法。别以泉水二升。煎滑石代赭取一升。去渣打后合和重煎。取一升五合。分温再服。

百合病。吐之后者。百合鸡子汤主之。

百合鸡子汤方

百合（七枚擘）鸡子黄（一枚）

右先煎百合好前法。内鸡子黄搅匀。煎五分温服。

百合病。不经吐下发汗。病形如初者。百合地黄汤主之。

百合地黄汤方

百合（七枚擘）生地黄汁（一升）

右先煎百合如前法。内地黄汁。煎取一升五合。分温再服。中病勿更服。大便秘如漆。

太阳寒水。由三焦下达膀胱为溺。由肾阳蒸化膀胱。外出皮毛为汗。故溺与汗为一源。寒水下陷。轻则为蓄水。重则为蓄血。。汗之由肺出皮毛者。属水分。由脾出肌腠者。属血分。故血与汗为证。营为血之精。行于脉中。卫为水之精。行于脉外。人一身之水。藉血热面化气。故肌腠孙络温而后皮毛固。一身之血。得水液而平燥。故三焦水道通而后血海濡。今方治标准。可知病之轻重。汗伤肺阴者。治以百合知母汤。但滋肺阴已足。下后水液下出大肠。由府病累及藏阴。湿热逗留为病。

则治以百合滑石代赭汤。吐后液亏。阳气上冒。累及主脉之心藏。而怔忡不宁。或至不能卧寐。则治以百合鸡子黄汤。此其易知者也。惟不轻吐下发汗。而见百脉俱病自来注家。未有知其病由者。陈修园知其病在太阳。不能从伤寒太阳篇悟到太阳之变证。黄坤载识为瘀浊在里。不能定瘀浊之名。识病而不能彻底。非所以教初学也。予以为此证直可决为太阳标热内陷蒸成败血之证。故方治用百合七枚以清肺。用生地黄汁以清血热。（一升约今一大碗、须鲜生地半斤许。）血热得生地黄汁清润。则太阳标热除。败血以浸润而当下。观其分温再服。大便如漆。可为明证矣。（按肠中本无血、惟热郁蒸腐经络乃有之。此亦利下脓血之类、观于病蓄血者大便必黑。于此证当可了解。）

百合病。一月不解。变成渴者。百合洗方主之。

百合洗方

百合一升。以水一斗。渍之一宿。以洗身。洗已。食煮饼。勿以卤豉也。

病至一月不解。则肺阴伤于里而皮毛不泽。脾阳停于里而津液不生。内外俱燥。遂病渴饮。此非水气停蓄。阻隔阴液而不能上承。不当用猪苓五苓之方治之。仲师主以百合洗方。已食以不用卤豉之蒸饼。其意与服桂枝汤后之啜热粥略同。盖食入于胃。营气方能外达。与在表之卫气相接。然后在表之药力。乃得由皮毛吸入肺脏。而燥热以除。所谓营卫和则愈也。其不用卤豉。以百脉既病。不当走血故也。

百合病。渴不解者。桥萎牡蛎散主之。

桥萎牡蛎散方

桥萎根、牡蛎（熬等分）

右为细末。饮服方寸匕。日三服。

百合洗方。所以润肺主之皮毛。以肺藏张翕之气。原自与皮毛之张翕相应。易于传达。臂之百川赴海。一区所受。万派同归。又惟其未也。更食煮饼以助脾阳。使里气外出。引药力内渍肺藏。而其为渴当差。其不差者。必浮阳上升。肺藏之受灼特甚也。桥萎根清润生津。能除肺胃燥热而濡筋脉。观柔痉用桥萎桂枝汤可知。牡蛎能降上出之浮阳。观伤寒柴胡龙牡救逆汤可知。合二叶以为方治。即降浮阳。又增肺液。渴有不差者乎。然必杵以为散者。则以病久正气不支。药当渐进也。试观久饥之人。骤然饱食则死。徐饮米汤则生。可以知用药之缓急矣。

百合病。变发热者，百合滑石散主之。

百合滑石散方

百合（一两炙）滑石（三两）

右二味为散。饮服方寸匕。日三服。当微利者止服。热则除。

人体之府藏。清阳内涵则凉浊阴。内蕴则热伤寒传阳明。由于胃浊失降。其明证也。百合病内脏虽燥。其初固无表热。变热者。久郁而生热也。此证阳气与阴液俱虚。肠胃初无宿食。欲去郁热。三承气汤俱非所宜。白虎斤竹叶石膏虽能清热。而不能疏其瘀滞。仲师言方。用百合滑石散。滑石剂量三倍于百合润燥。滑石以清热。石质重滞。取其引热下行。但使服后微利。其热当除。所以用散者。亦因病久正虚。不宜汤剂也。

百合病。见于阴者。以阳法救之。见阳攻阴。复发其汗。此为逆。见阴攻阳。乃复下之。此亦为逆。

见于阳者。以阴法救之。盖统上七节言之。水液不足。卫阳大伤。故曰见于阳。养阴泄热。故曰以阴法救之。百合病为似病非病之证。所谓见于阴者以阳法救之。本篇既不列病状。又无方治。读金匱者。不无疑虑。不知肺阴既伤。阳气外浮。故用百合养其肺阴。若营阴不达。当以扶助脾阳主治。即不当用百合。且不得谓之百合病矣。岂能更列于本篇乎。按太阳篇云。病人藏无他病。时发热自汗出而不愈者。此卫气不和也。先其时发汗则愈。宜桂枝汤。此证卫强营弱。为阴。故曰见于阴。桂枝汤能振脾阳。故曰以阳法救之。若夫阳浮于外。复发汗以壮里阴。阳乃无所制。阴盛于里。复下之以伤中阳。阴乃寢成寒中。故皆为逆也。

狐惑之为病。状如伤寒。默默欲眠。目不得闭。卧起不安。蚀于喉为惑。蚀于阴为狐。不欲饮食。恶闻食臭。其面目乍赤乍黑乍白。蚀于上部则声嘎。甘草泻心汤方之（甘草泻心汤方、甘草四两炙、黄芩、干姜、人参各三两、半夏半升、黄连一两、大枣十二枚、上七味、以水一斗、煮取六升、去渣在煎、取三升、温服一升、日三服）蚀于下部则咽干。苦参汤洗之。蚀于肛者。雄黄薰之。

苦参汤方

苦参一升。以水一斗。煎取七升。去渣。薰洗。日三。

雄黄薰法

雄黄一叶为末。筒瓦二枚合之。烧。商肛薰之

狐淫兽也。诗有狐绥绥。为寡妇欲嫁鰥夫而作。左氏春秋秦人卜与晋战。其系日乘三去。三去之余。获其雄狐。占之曰。夫狐蛊。必其君也。盖晋惠公蒸于贾君。有人欲而无天理。故秦人以狐名之。此可证狐为淫病矣。又晋侯有疾篇。有晦淫惑疾之文。下文申之曰。夫女。阳物而晦时。淫则有内热惑蛊之疾。内热为女劳瘵。惑蛊为二证。惑即本篇虫蚀之证。蛊则聚毒虫于雍。令自相食。或用暇墓。或用蜈蚣。最后通牒存其一。即为蛊。相传南方有此术。妇人于其所爱者将行。以蛊灰暗饮食中约期不至。即毒发而死。左氏传以三证并称。又可证惑为淫病矣。以理断之。直今之梅毒耳。盖阴阳二电。以磨擦生。火重之以秽浊虫生。遂成腐烂。蚀于喉为惑。蚀于阴为狐。不过强分病名。而其实则一。按此证先蚀于阴。阴蚀已。则余毒上攻而蚀于喉。并有蚀于鼻者。俗谓之开天窗。譬之郁伏之火。冒屋而出也。鼻烂尽。其人可以不死。蚀于上部则声嘎。会压穿也。蚀于下部则咽干。火炎上也。惟蚀于肛者甚少。或者其乐童欢。世所称龙汤阳毒。盖即指此。所以状如伤寒者。以头痛言也。毒发于宗筋。则其热上冲于脑而头痛。俗谓之杨梅风。宜水磨羚羊角以抑之。所以默默欲眠。起则颠眩者。小便数而痛剧也。（或用车前汁饮之、亦有小效。）所以目不得闭。卧起不安者。昼夜剧痛。欲卧而不得也。所以不欲饮食恶闻食臭者。小便结于前。故不欲饮。大便闭于后。故不欲食。浊阴不降。中气顿滞。故恶闻食臭。热毒攻于上。故面目乍赤。脓血成于下。故面目乍黑。营气既脱。加以剧痛。故面目乍白。以促师方治巧之。狐惑之为虫病。灼然无可疑者。苦参汤洗阴蚀。则以苦参味性寒。兼有杀虫功用也。雄黄末薰肛蚀。亦以雄黄功用。去毒而兼能杀虫也。然则蚀于上者。何不用杀虫之品。曰病起于下。虫即在下。蚀于喉。不过毒热上攻耳。（此厥阴证之口伤烂赤同。）故重用解毒之甘草为君。半夏黄连以降之。黄芩以清之。恐其败胃也。干姜以温之。人参大枣以补之。其不用杀虫之药者。口中固无虫也。陈修圆不知此证之为梅毒。乃至欲借用乌梅丸。夫证见乌梅丸能愈梅毒者乎。亦可笑已。

病者脉数。无热微烦。默默但欲卧。汗出。初得之三四日。目赤如鸠眼。七八日。目四皆黑。若能食者。脓已成也。赤豆当归散主之。

赤豆当归散方

赤小豆（三升浸令芽出爆干）当归（二两）

右二味。杵为散。浆水服方寸匕。日三服。

文曰。脉数无热微烦。但欲卧汗出。无无脉数。此为阳中有瘤。自汗出为脓未成。阳瘤条下已历历言之。惟瘕将成之状。疮痍篇初无明文。此云初得之三四日。目赤如鸠眼。内热蕴蒸之象也。又云七八日皆皆黑。若能食者。脓已成也。目四皆黑。为内瘕已腐。而败血之色见。此当是疮痍篇诸肿节后脱文。传写误录于此。赤豆当归散治肠中所下之近血。则此条当为肠瘤正治。妇人腹中痛用当归散。亦以其病在

大肠而用之。可见本条与狐惑篇阴阳毒绝不相干。特标出之。以正历来注之失。

阳毒之为病。而赤。斑斑如锦纹。咽喉痛。吐脓血。五日可治。七日不可治。升麻鳖甲汤主之。

阴毒之为病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻鳖甲汤去雄黄蜀椒主之。

升麻鳖甲汤方

鳖甲（手指大一片炙）雄黄（半两研）升麻、当归、甘草（各二两）蜀椒（炒去汁一两）

右六味，以水四升。煮取一升。顿服之。老小再服。取汁。肘后千金方阳毒用升麻汤。无鳖甲。有桂。阴毒用甘草汤。无雄黄。

邪中之人。血热炽盛为阳。血寒凝结为阴。此不难意会者也。然则阴阳毒二证。虽未之见。直可援证状而决之。阳毒为阳盛之证。热郁于上。故面赤斑斑如锦纹。热伤肺胃。故吐脓血。阳毒为凝寒之证。血凝而见死血之色。故面目青血凝于肌肉。故身痛如被杖。二证皆咽痛者。阳热薰灼固痛。阴寒凝阻亦痛。咽痛同而所以为咽痛者不同。以方治论。则阳毒有虫。阴毒无虫。譬之天时暴热。则蛰虫咸仰。天时暴寒。则蛰咸俯。盖不独阳毒方治有杀虫之川椒雄黄。而阴毒无之。为信而有微也。方中升麻。近人多以为升提之品。在本经则主解百毒。甘草亦解毒。则此二味实为二证主要。鳖甲善攻。当归和血。此与癰毒用炙甲片同。一以破其血热。一以攻其死血也。又按千金方阳毒升麻汤无鳖甲有桂。阴毒甘草汤无雄黄。以后文水四升煮取一升顿服取汗观之。似升麻鳖甲汤中原有桂枝。后人传写识脱耳。

疟病脉证并治第四

师曰。疟脉自弦。弦数者多热。弦迟者多寒。弦小紧者下之差。弦迟者可温之。弦紧者可发汗针灸也。浮大者可吐之。弦数者风发也。我饮食消自止之。

弦为少阳之脉。此尽人皆知也。然疟病何以属少阳。则以手少阳三焦寒水不得畅行皮毛之故。究其病由。厥有数因。人当暑令。静处高堂邃宇。披襟当风。则汗液常少。水气之留于皮毛之里者必多。秋风一起。皮毛收缩。汗液乃凝互肌理。是为一因。劳力之人。暑汗沾渍。体中阳气暴张。不胜烦热。尽则浴以凉水。夜则眼当风露。未经秋凉。皮毛先闭。而水气留著肌理者尤多。是为二因。又或秋宵若热。骤冒晓凉。皮毛一闭。水气被遏。是为三因。三因虽有轻重之别。而皮里膜外。并留水气。故其脉皆弦。痰饮之脉必弦者。由其水气故也。太阳寒水痹于外。一受秋凉。遂生表寒。营血受压。与之相抗。是生表热。故有寒热往来之变。惟水气轻者。随卫气而动。休作日早。其病易愈。水气重者。随营血内伏。休作日晏。其病虽愈。血热内张。故脉弦数而多热。水寒外胜。故脉弦迟而多寒。长女昭华治多热者。用小柴胡汤另石膏知母。治多寒者。则加干姜桂枝。此本孙氏千金方。每岁秋间。治愈者动至数十人。足补仲师方治之关。至如弦小紧者不之差。或不尽然。所谓小紧者。或即温疟其脉如平之谓。盖温疟之为病。但热不寒。即寒亦甚微。渴饮恶热。不胜烦苦。本属阳明热证。用桂枝白虎汤后。表虽解而腹及少腹必胀痛。亦必大便不行。予裳治斜桥一妊妇。先病温疟。继病腹痛。先用桂枝白虎汤。愈后。继以腹痛下利。用大承气汤而愈。后治一年近不惑之老人亦然。可见下之而差。为温疟言之。辛未六月。浦东门人吴云峰患间日疟。发则手足攀急麻木。口苦吐黄水。午后热盛谵语。中夜手足不停。脉滑数而弦。用大柴胡汤下之。一剂而差。此可证当下之疟脉。不定为弦小紧矣。迟为血寒。故弦迟者可温之。弦紧为太阳伤寒之脉。水气留著皮毛。故可发汗。留著肌腠。故可针灸。浮大之脉。阳气上盛。证当自吐。不吐其胸必闷。故可用瓜蒂赤小豆散以吐之。至谓弦数者为风发。证状未明。以理断之。大约阳暴发。两手拘攀。卒然呕吐。若呈生之证。所谓以饮食消息止之者。不过如西瓜汁芦根汤菜豆汤之类。清基暴出之浮阳。然究不如大柴胡汤。可以刈除病根也。惟此证病后胃气大伤。饮食少进。当以培养胃气为先务。此又不可不甘落后知耳。

病疟结为痼瘕。如其不差。当云何。师曰。此名疟母。急治之。以月一日发。当十五日愈。设不差。当月尽解。宜鳖甲煎丸。

鳖甲煎丸方

鳖甲（十二分炙）乌扇（三分烧即射干）黄芩（三分）柴胡（六分）鼠妇（三分蒸）干姜、大黄、桂枝、石苇（去毛）厚朴、紫葳（即凌霄）半夏、阿胶（各三分）芍药、牡丹（去心）魔虫、人参（各一分）瞿麦（二分）蜂窠（四分炙）赤硝（十

二分) 蟬螂(六分熬) 桃仁(二分去皮尖研) 右二十三味为末。取煨龟下灰一斗。清酒一斗五升浸灰。矣酒尽一半。着鳖甲于中。煮令泛烂如胶漆。绞取汁。内诸药煎为丸。如梧子大。空心服七丸。日三服。千金方用鳖甲十二片。又有海藻三分。大戟一分。无鼠妇赤硝二味。

病疟之由。不外寒热。早用加减小柴胡汤。何至十五日一月而始愈。况一月不差。结为微浸之说。尤不可信。此传写之误也。疟母之成。多在病愈之后。岂有疟未差而成疟母者。此痞或在心下。或在脐下。大小不等。惟鳖甲煎丸至为神妙。或半月而消尽。或匝月而消尽。予向治朱姓板箱学徒。及沙姓小孩亲验之。盖此证以寒疟为多。胎疟亦间有之。他疟则否。北人谓疟为脾寒。南人谓无痰不成疟。二者兼有之。脾为统血之藏。脾寒则血寒。脾为湿藏。湿胜则痰多。痰与血并。乃成微浸。方中用桃仁历虫蟬螂鼠妇之属以破血。宁历以涤痰。君鳖甲攻痞。而又参用小柴胡汤以清少阳。干姜桂枝以温脾。阿胶芍药以通血。大黄厚朴以调胃。赤硝瞿麦以利水而泄湿。疟母乃渐攻而渐消矣。细玩此节文义。当云病疟结为微浸。如其不差当云何。师曰。名曰疟母。当急治之。以月一日发。当十五日愈。设不差。当月尽解。宜鳖甲煎丸。陈修园黄坤载辈望文生训。殊欠分晓。

师曰。阴气孤绝。阳气独发。则热而少气。烦冤。手足热而欲呕。名曰阐疟。若但热不寒者。邪气内藏于心。外舍分肉之间。令人消烁肌肉。

此节为温疟标准。阴气孤绝。或由汗出太过。或由亡血失精。水分不足。血热独强。温疟之证。其脉不弦者。水分虚也。水分不足。则亢阳无制。是为厥阳独行。故此病不发。则如平人。一发即身热如灼。渴欲饮冷。气短胸闷。其苦不可言喻。手足热者。谓不似寻常疟证。手足尚见微寒也。欲呕者。阳气上亢。胆胃逆行也。但热不寒。故名阐疟。(说文、阐、劳也、人劳则阳气张、观于劳力之人、虽冬令多汗、阳气以用力外出之明证也) 邪气内脏于心。外舍于分肉之间。不过形容表里俱热。非谓心脏有热。各藏各无热也。予谓胃主肌肉。观下文肌肉消烁。此证当属阳明。原人一身肌肉。由水分与血分化合。水液本自不足。又经表里俱热。亢热薰灼。血分益增枯燥。则既类尧肌如腊。欲求如郭重之肥见恶于季康子者。不可得矣。大肉痿陷。大骨枯槁。能久存乎。

温疟者。其脉如平。身无寒。但热。骨节烦疼。白虎加桂枝汤主之。

白虎加桂枝汤方

知母(六两) 石膏(一斤) 甘草(二两炙) 粳米(二合) 桂枝(三两)

右五味。以水一斗煮米熟。汤成去渣。温服一升。日三服。

温疟之为病。太阳标热并入阳明之证也。太阳之气不宜。则阳明之热不去。此仲师用桂枝白虎汤之义也。外无水气压迫。故其脉不弦。一身无寒但热。骨节烦疼。及腰竣时呕。则诸疟并有之。不惟温疟为然。此于诊病时亲见之。但不如温疟之甚至耳。独怪自来注家。多称冬不藏精。水亏火盛。若内经疟论冬中风寒。气藏骨髓。遇大暑而发云云。尤为荒诞。治贵实验。安用此浮夸之言。使非阳明实热。何以温疟服桂枝白虎汤愈后。乃又有大承气汤证耶。

疟多寒者。名曰牡疟。蜀漆散主之。

蜀漆散方

蜀漆（洗去腥）云母石（烧二日夜）龙骨（各等分）

右三味。杵为散。未发前。以浆水服半钱匕。

疟之所以多寒者。皮毛为水气所遏。阳气不得宣也。水气留询问上膈。则寝成痰涎。故世俗有无痰不成疟之说。蜀漆为常山苗。能去湿痰。故用之以为君。云母石本经主治中风寒热。如在舟车。是为止眩镇风阳之品。龙骨当为牡蛎之误。本经牡蛎主治咳逆。并言治痰如神。水归其宅。可见蜀漆散方治。专为风痰眩晕而设。盖上膈之湿痰去。然后阳气得以外达。益可信无痰不成疟之说。为信而有微矣。

补三阴疟方治。

疟之轻者日发。血分热度渐低。则间日发。热度更低。则间二日发。世俗谓之三阴疟。然此证仲师无方治。俗工又不能医。故常有二三年始愈者。予蚤年即好治者。有乡人以三阴疟求诊。诊其脉。迟而弱。予决其为正气之虚。为之凝方。后此乡人愈后。将此方遍传村巷。愈十余人。后于李建初书塾诊其侄克仁之子。脉证并同。即书前方授之。二剂愈。名常山草果补正汤。此方并治虚疟。癸酉十月初三日。麦加利银行茶役韩姓子。寒热日三四度发。服此汗出而愈。方用常山四钱。草果四钱。生潞党五钱。茯苓四钱。全当归八钱。生白术四钱。灸草五钱。川芎三钱。熟地一两。小青皮三钱。知母二钱。半夏三钱。生姜八片。红枣九枚。

中风历节病脉并治第五

夫风之为病。当半身不遂。或但臂不遂者。此为痹。脉微而数。中风使然。

不明风之为义。不足以知中风之病。臂之擎颺乍发。林木披靡。风从东受。则木靡于西。风从西来。则木靡于东。本体所以偏斜不正者。风力之所著。偏也。故口眼喎僻。半身不遂所受之风。虽有轻重。而一面之暴受压迫则同。然则风之著于人体者。偏左病即在左。血气乃受约而并于右。血气乃约并于左。血气不行之手足。乃废而不用。故曰当半身不遂。但臂不遂者。此这寒湿痹于筋络。当用葳灵仙独活等合桂枝附子汤以治之。不当与中风同治矣。脉为血分盈虚之大验。血虚故脉微。（与伤寒太阳篇脉微脉涩同）风为阳邪。其气善于鼓动。故脉数。盖脉微者不必数。虚固多寒也。脉数者不必微。固多实也。今半身不遂。脉微而有数象。故决为中风使然。然则卒然晕倒痰涎上涌。两脉但弦无胃者。岂得谓之中风耶。予常治四明邬炳生右手足不用。与无锡华宗海合治之。诊其脉。微而数。微为血虚。其人向患咯血便血。营分之虚。要无可疑。日常由外滩报关行夜半回福田庵路寓所。风邪乘虚。因而致病。以伤寒之例求之。则脉为风。以杂病之例求之。则数亦为风。疟脉之弦数为发。可为明证。予因用麻黄汤外加防风潞参当归川芎熟地等味。宗海针手足三里风池委中肩并合谷环跳跗阳丰隆离钩等穴而灸之。三日即能步行。独怪金元四家。主痰主火主风。而不辨其为虚。根本先诊。独不见候氏黑散有人参芎归以补虚。风引汤重用龙骨牡蛎以镇风阳之犯脑耶。又不见防已地黄汤之重用地黄汁耶。

寸口脉浮而紧。紧则为寒。浮则为虚。寒虚相搏。邪在皮肤。浮者血虚。络脉空虚。贼邪不泄。或左或右。邪气反缓。正气即急。正气引邪恶。喎僻不遂。邪恶在于络。肌肤不仁。邪在于经。即重不胜。邪恶入于府。即不识人。邪入于藏。舌即难言。口吐涎沫。

伤寒论中有中风。杂病论亦有中风。同名而异病。究竟是一是二。此不可以不辨也。仲师云寸口脉浮而紧。紧则为寒。浮则为虚。寒虚相搏。邪在皮肤。此即太阳伤寒麻黄汤证也。此时营血不虚。络脉中热血出而相抗。因病发热。表气未泄。则犹宜麻黄汤。设汗液从皮毛。即当用中风之桂枝汤以助脾阳。俾风邪从络脉外泄。然此为营血不虚者。言之也。营血不虚。则所中者浅。而其病为伤寒论之中风。营血既虚。则所中者深。而其病即为杂病论之中风。是故素病咯血便血之人。络脉久虚。伤寒正治之法。遂不可用。伤寒论所以有亡血发汗之戒也。脾为统血之藏而主四肢。风中络脉。乃内应于脾而旁及手足。于是或左或右而手足不举矣。故其病源与太阳篇之中风同。而要有差别。风著人体。外薄于皮毛肌腠。散在周身。则气散而缓。惟偏注于一手一足。则气聚而急邪薄于左。则正气并于右。薄于右。则正气并于左。正气以并居而急。邪乃从之。因有口眼喎斜半身不遂之变。风之所著。受者见斜。昔诗人有寒食束风御柳斜。轻燕受风斜面之句。可为喎僻偏枯之明证也。至如后文所列四证。惟入于藏一条。为半身不遂者所必有。其余不过连类及之。夫所

谓邪在于络肌肤不仁者。则风与寒湿相杂之证也。湿凝于肌。则络为之痹。故有不痛不痿麻木不仁者。亦有湿胜而成顽痹者。此证治之未必即愈。不治亦必无死法。是为最轻。所谓邪在于轻即重不胜者。以太阴经病言也。盖风之中人。皆由血虚。风从肌腠而入。阻隔脾阳。阳气不达于肌肉。则身为之重。

此风湿为病，脉浮身重，防己黄芪汤证也。所谓邪入于府即不识人者，以阳明府病言之。风之中入，由于血虚，虚则生燥，如吐下后大便不解者，然不认识人者；即阳明篇发则不识人之证，故燥热在下，则阳气上冲入脑，而神志昏蒙。下之以大承气汤，脑中阳热下降，神志即清，所谓釜底抽薪也，只有入藏之说，向无确解。陈修园主心肾，黄坤成则主心肾脾，所谓三藏之脉，俱连舌本，但未见愈疾之方，而空言聚讼，徒貽笑柄耳。世传中风不语用黄芪、防风各数两煎汤，以大盎盛之，放置一会儿再薰之，冷则再煎、再薰，一日即能言，此为黄九峰法。镇江蒋实素用之入煎剂，名黄风汤（九峰医药传世、蒋为门人著有）大抵正气引邪上行，脑气闭塞，鼻窍不通，喉窍独开，故口中流涎，所以难言者。脉为风激，血蓄于脑，舌本之脉，牵制而愈短也，黄风汤只二味，一以祛风，一以补正，先令从鼻窍薰入于脑，脑气一疏，则脉之牵制者缓，脑舌本能转，鼻窍开而喉窍顺也。章次公以脑为藏而不泻，卒厥为血蓄于脑，故入脑亦名入藏，今西医亦以中风为脑充血，揆之此证。理解并合，山川可以崩竭，此义不可改也。

寸口脉迟而缓，则为寒，缓则为虚，营缓则为之血卫缓，则为中风，邪气中轻，则身痿而瘾疹，心气不足，邪气入中，则胸满而短气。风之中入，必乘营血之虚，脉之所以迟也，营虚则风从卫分传入者，营血热度不足以相闭拒，风就得以乘闭而入，此中风之大略也。邪气中轻，身疮瘾疹，当即世人所认为之风疹，其病犹在表也。应当治其毒蛭及上海姚金福室人，并以麻黄加术汤取效。又在清和方治愈一老年妇人，亦用此方，可为明证。只有心营不足，风邪转入里，肌肤、胸为太阳出入之道路，上、中二焦为水分、气分分布之统区也（西医谓之淋巴结），风从皮毛传入遏，其清阳之气阻水液之散布，故使其胸满而短气。张仲景不用此方治疗。他常用桂枝汤去芍药加人参、白术、防风、黄芪，助心阳而补脾阴，使营气略和，风将自息，风用此汤似不合病。

防己地黄汤

治疗病症：

如狂状，妄行，自言自语不停，无寒热，其脉浮。

防己、甘草各一分 桂枝、防风各三分

以上四味药，以酒一杯浸渍，绞取汁，生地黄二斤，咀蒸之，形如斗米饭，久以铜

器盛药汁，更绞地黄汁掺和，分次服用。

不明病理者，不可与论古人之方来治疗，蓄风邪失表之证，往往随经而瘀热于里，太阳标热内陷，因致热伤血海，太阳证所以蓄血也。此节病由，说病如狂状，妄行，自言自语不停，无寒热，其脉浮，此为中风而营血于下。与风吸百脉血充脑部，舌难言而口吐涎者，症状自不相同。热结在里，故无表热，病在太阳之府，故脉浮。如狂、喜、妄，在伤寒为蓄血之证。独语如见鬼状为热入血室，张仲景成功之例子具在，不可诬也。只有伤寒之蓄血为血实，故用抵当汤、桃核承气汤以下之，中风则本由血虚，虚者不可重虚，故可用防己地黄汤，重用地黄汁，以清瘀血，防己以泄湿，防风以疏风，甘草、桂枝以扶脾而解肌，此法正与百合证用地黄汁同服。后中病亦，当大便如漆蓄血同也。

方解附

候氏黑散解

候氏黑散.主大风，四肢烦重，心中恶寒不足者。

菊花四十分

白术、防风各十分

桔梗八分

黄芩五分

细辛、甘草、人参、茯苓、当归、川芎、牡蛎、蒙石、桂枝各三分

以上十四味杵为散，酒服方寸匕，每日一服，初期服二十日，温酒调服，禁一切鱼肉、大蒜，平常适宜冷食，六十日止。如果药积腹中不下的话，热食即下也，冷食自能助药力。

古人所立方治，一方有一方的作用，如作用不可知，当于病理求之；一方有一方的主名，如主名不可知，当于药味求之。候氏黑散一方，主治大风、四肢烦重，心中恶寒不足者。四肢烦重，为风湿痹于外；心中恶寒不足为气血伤于里，脾阳不达于四肢，故烦重。血分虚而热度不充内藏，故心中恶寒，此病理之易明者也。桂枝为伤寒论中风主药，防风以祛风，菊花能清血分之热（合地丁草能愈疗毒）黄芩能清肺热，白术、茯苓以祛湿，湿胜必生痰，故用桔梗以开肺，细辛、干姜及牡蛎以运化湿痰，但是湿痰的产生，是由于气血两虚，所以用人参以补气，当归、川芎以和

血，此药味之可知者也，只有蒙石一味，不怎么了解，近代人张锡纯始发明为皂石，按皂石色黑，能染黑布，主通燥粪而清内藏蕴湿。张三丰伐木丸用此以治黄瘴，俾内藏蕴湿，湿从大便而解者，正是此理。然则方之所以名为黑散者，实以皂石色黑为取名之。如黑虎丹、锡丹之例。想要知道病属气血两虚，风湿痹于表里，处方治疗以实主疏通，而不主固涩。崂瘴腹胀，治疗用以硝石、蒙石散，也是此意。由此观之，方后所说初服二十日，温酒调服者，借药力之通行脉络也。禁一切鱼肉、大蒜者，唯恐其更增湿热，使其为药力之障碍也。至于如果四十日常宜冷食以助药力，特以不用温酒言之。若四十日常食冷饮及粥，不病也会宿食，必病寒中。风疾未除，新病又发作，治病者固当如是乎，去皂石，热者速行，冷即缓下，所以欲药积腹中者，则以太阴蕴湿，有如油垢，不是一经过水就能去尽的。喻嘉言所谓的固涩诸药，使之积留不散，以渐填空窍，彼既误皂石为明石，于立方之宗旨已论。岂知，药于腹中，其人已胀满死也。陈修园从而称之是以何异疴者之唱，既者之听乎，亦可笑已。

风引汤解

风引汤治除热瘫瘳

大黄、干姜、龙骨各四两

桂枝三两

甘草、牡蛎各二两

寒水石、滑石、赤石脂、白石脂、紫石英、石膏各六两

以上十二味杵粗筛，以革囊盛之，取三指撮，井花水三升煮沸，温服一升，治大人风引。少小惊癇疳瘕日数发。医所不疗，除热方。巢氏说：脚气也适宜风引汤。本修说：除热瘫瘳，方后附有服用之法及主治；又说：治大人风引、小儿惊癇疳瘕日数发，医所不疗，除热方，病以风引为名，似当以半身不遂为主要，所谓正气引邪过僻不遂者是也。但是，风起于四末，则为偏中风，中于头则为眩晕，以方治致之。治疳瘕必有经验，治偏中必无济于是。所以说，除瘫瘳者，不一定以偏中言之也。血不过头，就如手上刀伤，以指按伤处，按于头顶，其血自止。只有风阳及于上，则一身之气血，一时并入于脑，故有卒然晕倒，痰涎上涌而死者。热血蓄于脑而脑膜为之暴裂也（西医称之为脑充血）血逆行于上，则百脉为之牵制，小儿所以病疳瘕者，亦由于此。蓄此类病证，胸中先有热痰，外风引之所以并热血而上入于脑，如风起水涌者。然方中大黄用以泄热，非以通滞。此与泻心汤治吐血同。所谓釜底抽薪也。干姜炮用，能止脑中上溢之血，像在常熟见某钱肆经理鼻衄，纳炮姜灰尽于鼻中，其衄血即止。所谓煤油着火，水泼益涨，灰扑立止也。（此味下脱注炮

序)所谓用龙骨、牡蛎者，此与伤寒太阳篇误下烦惊谵语，用柴胡加龙骨、牡蛎。火迫去之发为惊狂。桂枝去芍药加蜀漆、牡蛎、龙骨及下后烧锺，烦燥主桂枝甘草汤，用意略同。二味镇浮阳之行脑，而牡蛎又有运痰下行之力也。所以用桂枝甘草汤。桂枝汤方法原来之所以祛邪风而于本方风引之义，固未适合。所以桂枝汤发脾阳之汗而出之肌理，原为营气不虚者设。如果营气本虚，阳气张发于上，卫气被吸引而上，逆非状中土而厚共堤防，不足以制卫逆，而痰与热血将一时并入于脑，此即发汗过多，心下悸欲得按，主以桂枝甘草汤。脐下悸欲作奔豚，主以苓桂甘草汤之例。欲其不能蟪中脘而上冒也。其余所用寒水石、滑石、紫石英、石膏，不过是清凉重镇，使诸藏百脉之气不受外风牵引而已。主中只有赤石脂、白石脂二味，至为夹难不伦。喻嘉言寓意草所救治寒湿下利，颇著特效。伤寒利在下焦之禹除燔汤。寒湿下利之桃花汤，赤石脂并为要药，可见其功用，全系止涩，与上用大黄之意，绝然相反。所以有用此方则已，若用此方，此二味究当除去，否则药不合病，且更生诸药之助力也。

头风摩散解

头风摩散：大附子一枚

盐等分

以上二味为散，沐了，以方寸匕摩疾上，令其药力行。

此方之义不可知，只有近代人所传偏头痛、目赤用食盐和水涂太阳穴，半日之间，其痛立止，消当是此方造意。加以附子，善走风阳之入脑者，应当用更易散，此与纳药入鼻中同，不开于内藏者也。

寸口脉沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即为肾，弱即为肝，汗出入水中，如水伤心，历节痛，黄汗出，所以称为历节。

肺主一身治节，独为五藏，主故近世诊病者，都是取决于手太阴动脉，伤寒金匱所说的寸口，皆统开前后言之。（此磨本不缺，另有太阴脉浮而弱一条，恐入待言，因不明为手太阴动脉，故略言之）大凡历节之成要，外乎水寒血败，血痹于下，则营气不能上承，故手太阴之脉必弱，水气胜则阳气不升，故脉沉。此证以湿留关节为大纲。关节为筋与骨交会之所，汗出入水，不用麻黄加术汤以发之，寒湿伤筋，所以筋痛，伤骨所以骨痛。肝主筋，血不行所以筋痹，肾主骨髓，日败所以骨痹，而脉之沉弱应之，蓄人之一身，气分多地水分，则脉浮，水分多于气分，则脉沉，所以历节常见沉弱之脉，即可决为汗出入水所致。人身之汗孔，随肺气而张发，水渍于外，毛孔中要有正气抵拒，涓滴不能渗入，所以病此者，凉者浸灌于外，皮中汗液悉化寒水。水寒则伤血，心为主血之藏，所以张仲景说如水伤心。如水伤心云

者，原不是所谓水气凌心也，水湿渗入关节，所以历节痛。太阳标热而欲出，所以发黄汗，（黄汗在腋下，着衣成黄色），此为历节之第一因。

趺阳脉浮而滑，滑则杀气实，浮则汗自出。

太阴脉浮而弱，则血不足，浮则为风，风血相搏，即疼痛如掣。

盛人脉狭小短气自汗出，历节疼不可屈伸，此皆饮酒当风所致，

此节前半节以趺阳寸口之脉求出历节根原，寸口即手太阴动脉，陈修园本作少阴者误也，趺阳脉在小儿紧鞋带处，为胃脉之根，趺阳脉浮而滑，浮为阳气外出，滑则为杀气，实浮则汗自出，按宿食篇所说：脉数而滑者实也，也有宿食下之愈，外汗出而内有宿食，有似阳明府病，未可定为历节，所以此证当并取决于手太阴动脉。太阴脉浮为风，邪在太阳，弱为血虚，（营气不能上承与前证略出）风气著于肌理，则湿邪凝沍而血为之痹，然但专京寸口而观，可决为汗出当风，终不能断为酒后之汗出当风，蓄饮酒汗出当风，其肌肉先痹，此时不用桂枝汤以发之。则湿热蒸于内，而腑渴不行，趺阳之脉，因见浮滑，脾阳不运于四肢，于是营血内停，风湿就流于关节。手太阴动脉因见浮弱（太阳病中风，脉本浮缓，湿痹于外，血之热度愈低，就变浮弱）风束于外，湿不得泄，湿与血并，遂成阴寒，故疼痛如掣，此为历节。所以手足节骭外，疼痛不可屈伸，此为历节之第三因。

诸肢节疼痛，身体羸羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

桂枝芍药知母汤方

桂枝四两

芍药三两 甘草、麻黄、附子各二两炮 白术、知母、防风各四两

生姜五两

以上九味，以水七升煮取二升，温服七合，日三服。

历节一证，大率起于皮毛肌腠，阳气不能外达，寒湿遂留于关节，此即肢节疼痛所由来，所谓不通则痛也，身体羸羸者，统血之藏久虚，不能营养分肉也，脚肿如脱者，寒湿下注之象也，头眩为血虚（西医谓之脑贫血，亦有见于历节治愈之后者）气短为湿胜（病痰饮者，多喘，湿胜故也）独胃中尚有浮热，故温温欲吐。温如釜中冷水被炭火下迫，釜底时有一沷上浮，，俗名胃泛。

桂枝芍药知母汤方，只有知母一味主治欲吐，余则桂芍甘草生姜以通阳而解肌，麻黄、附子、白术以开表而祛湿，防风以祛风，方治之妙不可言喻，予当治一戴姓妇人亲验之，但病因与张仲景所举在有不同，乃知肢节疼痛，张仲景特下一诸字，正以其所包者广也，蓄此妊娠八月为其夫病求医，抱而乘车，病人身重，将腹中小儿压毙，夫病愈而妻病腹痛，乃求医，医药而堕之腐也，妊妇本属血虚，死胎既下，因贫不能善后，湿毒留顿腹中，久乃旁溢肢节，死血与寒湿并居，因病历节手足拘掣，入夜手足节骱剧痛，旦日较缓，其为阴寒，无疑近两年矣，予因用原方每两折为二钱，用熟附块四钱，二剂不应，二诊改用生附子，汗乃大出，两剂，肢节便可屈伸，足肿亦小，独手发出大泡，有脓有水，将成溃烂，予用丁甘仁法，用大小蓟各五钱、丹皮一两、地骨皮四钱以清血热，二剂而痂脱，遂与未病时无异，以为可无患矣，忽然阴痒难忍，蓄湿毒未尽而下注也。予因令其用蛇床子煎汤薰洗，良痒未几入市购物，卒然晕倒，诸恙退而血虚之真象见，予以乃用大熟地一两、潞党参五钱、川芎、当归各四钱、龙骨牡蛎各一两，凡二十余剂而止，今已抱子矣。

味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄，咸者伤骨，骨伤则痿，名曰枯，枯泄相搏，名曰断泄，营气不通，卫不独行，营卫俱微，三焦无所御，四层断绝，身体羸瘦，独足肿大，黄汗出，经冷，假令发热，便为历节也。

浪如星，巨舟覆，顺则利济，逆则杀人者，均之水也。鸟焚巢，旅人号，炊晕之所需，素出之可畏者，均之火也。故服食寒暖酸苦辛，皆常有节，于首篇已详言之，今特于历节证之。人皆知酸味之善敛，而不知其性最易发酵，今试以针化水，投醋其中，则如汤之沸溢出盆盎和面涂伤能去瘀血，非之挥发之性力能破血耶。此可各酸之所以补肝，实因酸味发扬肝藏血液，得遂其修达之性，而无寒胀痛之病也，若味过于酸则血液发挥太甚，久且不足以养筋，而筋为之缓，病在血液旁泄，故名曰泄，皆知咸味之为润下。而不知其性暴烈，今试投验于炽炭炉中，则火力加猛，多食盐，验而渴者，非以苦燥之质，足以伤津耶，此可知咸之所以补肾，实因咸味燥烈，能排下焦之水，而无助下硬满之变也，若味过于咸，则津液灼烧太甚，髓不足以充骨，而骨为之痿，病在精髓内枯，故名曰枯，血以发而过泄，精以燥而曰枯，汗液乃不达肌表，故曰断泄，营气不通，卫不独行，则阴弱而阳亦微，肾阳不能统摄水道，故三焦无所御，肝阴不能养筋，故曰四属断绝，血虚而湿在下，故身羸，而足肿血虚而湿胜。阳气不能达表，故黄汗时出腋下，寒湿流注于足，故胫冷。以上诸证，并属阴亏湿胜，若风寒乘虚侵入其表，气风湿相搏，乃外热发而内疼痛，故发热便为历节，此为历节之第四因。

病历节不可屈伸疼痛，乌头汤主之

乌头汤治脚气疼痛，不可屈伸

麻黄、芍药、黄芪、甘草各三两炙

乌头（五枚咀以蜜二升煎，取一升即出乌头）

以上四味以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中更煎之，服七合不知，尽服之。

历节一证，大约寒湿痹于关节，阳气痹于肌表，阴痹而阳欲外泄，则热发而黄汗，阳痹而寒湿阴于筋脉，则疼痛不可屈伸，此为阴寒重证，非桂枝芍药知母汤所能通治，故不得已而用乌头汤，亦犹蝼蛄重证，乌梅丸所不能治，不得已用甘草粉蜜汤也，按乌头为附子之母，若芋婆然，其颗甚小，一枚约有今权三钱，五枚则一两半矣，然则麻黄、芍药、黄芪、炙甘草之各三两，不当如日知录折成七成八分也，尽以两计可折，以枚计则无可折，岂古今药剂权量，初无沿革耶，此方重用乌头，以历节足肿胫冷，确定为少阳寒湿而用之，与寒痛用大乌头煎，同徐忠可乃谓膝胫不冷，似可加黄柏、知母，夫使膝胫不冷，岂可用乌头五枚矣，足见张仲景既殁，医家更无通才也。

蒙石汤

治脚气冲心

蒙石二两

以上一味以浆水一斗五升，煎三五沸，浸脚良。

方用蒙石二两，以浆水一斗五升煎，三五沸浸脚良，陈修园以为疼痛不可屈伸，以乌头汤主，至于冲心重证，似难以外治伟功似也，然近世所传验方，白蒙二两，地浆水十大碗（掘地灌水和泥取出，名曰地浆）新杉木三四片，煎六七沸，用杉木桶盛之，浸脚，留一半徐徐添入，上用衣被围身，使略有汗，洗毕，饮稀粥一碗，如不愈，用前方加硫黄三钱，无不愈参，按此方即即张仲景原方，本书尚多脱漏，特补出之。蓄脚气一证，湿胜于下，挟风阳而上升，故其气冲心，方中所以用蒙者，以蒙能燥湿故也。所以用地浆水者，钱乙所谓以土茯苓水，水得其平，风自止也，所以用杉木者，以杉木燥湿能治脚肿痛也（柳于厚救死方曰，得脚气，夜半痞绝，发块如石，昏困且死，郑洵美伟杉木汤，食顷天下，块散而气通，用杉木节一升，橘叶一升，槟榔十枚打，童便三升煎，一服下，止后服）所以使其略有微汗者，欲其气之外散，所以加用硫黄者，则以硫黄难燥热，能引大肠积涸下行。与他药炎上者不同，故冲心之脚气，亦得借引涸下行之力，使不上冒也，然则方用白蒙，不如用皂蒙为胜，以皂蒙引涸下行之力。与石硫适相等也，辛未八月，乡人庄姓病此，两足肿大，气急心痛易肌，此证气分居多，而寒湿不甚，长女昭华投以加味鸡鸣散，方用吴茱萸五钱，木瓜五钱，槟榔三钱，黑豆五钱，桔梗三钱，青陈皮各三钱，苍白术各三钱，生甘草一钱，生黄芪五钱，紫苏六两，生姜一大块，浓煎服之，一夕而足肿全消，此八月十四日事也，附录之以为临证之一助，又按，痛者属气分，麻

木在少腹属血分，予曾治焦店潘姓，用加味四物汤取效，方用川芎三钱，当归五钱，白芍四钱，生地一两，吴茱萸三钱，木瓜三钱，生附子二钱，防己三钱，牛膝一两，三剂而愈，与病属气分者不同，存以补参。

血痹虚劳病脉证并治第六

问曰：血痹之病，从何得之，师曰：夫尊荣人，骨弱肌腠盛重，因疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风遂得之，但以脉自微涩在寸口，关上小紧，宜针引阳气。令脉和紧去则愈。

血痹初得之状仲师初无明文，但云尊荣之人骨弱，肌腠盛重因疲劳汗出，卧不事动摇，加被，微风遂得之，自来注家，多未明了。予特快其隐情而发之大约与虚癆失精家病，原相伯仲耳，夫所谓尊荣之人者。美人充下，陈左雍，而右抱，卧必宴起，纳杀不多，静坐终日，动时慄少，脾阳先已不振(腑肉乏吸收作用)肌肉难盛，腠理实虚，加以肉璧既多，精气遂削，精髓空虚，骨乃荏弱，有受外邪，固已不能任事，况又入房汗出，全身动摇，微风袭之，血受风遏，阳气不达，阴会遂凝，此风不受于肩井，即受于风池，风府，以其背在上也，故知其臂必麻木，背必疼痛，平时脉本微涩，而关上独见小紧者，正以痹在上部不及中下也，此病在草野之夫，不足为患，独纨绔少年，气体素弱，因而成痹，故但需针炙所病之穴，俾血从内动，即风从外解，而运费去脉和矣，玩则愈二字，此意自见，丁甘仁云，五之门诊，所以多，多用轻药者，彼固未有重病也，亦此意也，近有富人金姓，多姬侍，时发病，无锡华宗海钱即愈，后宗海难上海，求诊于宁波平亦如之，倘今不异于古所云耶。

血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹关，黄芪、桂枝五物汤主之。

黄芪桂枝五物汤方

黄芪三两

芍药三两

桂枝三两

生姜六两

大枣十二枚

以上五味以水六升煮取二升，温服七日合，日三服

病至气血两虚，与上节本原柔脆，正虚病轻者，固自不同，寸口关上脉微，尺中小紧，阴血不充阳气，寒之脉证也。气血不通，故身体不仁，如风痹状，甚则两足痿弱或更因阳气闭塞不濡分肉，麻木不知通处，此证治法，以宜达脾阳俾风邪从肌肉

外泄为主，故用解肌去风之桂枝汤，去甘草而用黄芪者，正以补里阴之虚，而达之表也，夫男子平人脉大为劳，脉极虚亦为劳。

阴虚生内热，阳气外张，故脉大，阳衰生里寒，阴血不通，故脉极虚，脉大则发热，脉极虚则恶习寒，病情详后文药不实，男子面色薄，主渴及之血，卒喘悸脉浮者，里虚也。

此节为望色审证及脉而知虚劳之病也，面色之夺厚薄，视其人之气血为转移，气血充则颊转丰腴，无论诸如渥丹为厚，即夫如凝脂亦为厚，气血不充，则枯白不华，无论面如削瓜为薄，即肥白如瓠者亦为薄，为其精亏而血少也。

精亏则生内热，而引水自救，故主渴，血少则色天不泽，故主之血，此一望而可知者也，肾不纳气则喘（此为精竭者所必有）心营虚耗则悸（此为之血所必至）虽喘与悸皆有虚实之辨，要惟虚劳之喘，坐卧则略定，稍动则肩摇而息浊，是为卒然而喘，与汗出饮水之喘，痰饮之喘，不能暂停者，固不同也，虚劳之悸略无惊恐则坦坦如平人，若据梧沉思，忽闻对座高声或凝神夜坐，忽风灯旁物影，不觉怦然大动，是为卒然而悸，与水气凌心之悸，烦热之悸绝我断者，又不同也，至谓脉浮为里虚，则为促师失辞，原其意殆指浮取则见重，按若无芤脉，承上渴及之血言之，否则浮为在表，浮则为风，伤寒浮紧，中风浮缓岂得概谓之里虚耶。

男子脉虚沉弦，无寒冷，短气里气，小便利面色白时，目瞑兼衄，少腹满，此为劳使之然。

凡脉风沉弦者，不主里水，即主表寒，卫虚则生寒，营虚则生热，故表邪风沉弦者，心有寒热，今无寒热则非表邪可知，虚阳不归其根，故短气，里急者，似胀非胀，似痛非痛，而中气否塞也，小便不利而少腹满者，三焦水道由肾下达膀胱，水道得温则行，过寒则冻，肾阳既耗，水道遂瘀，按此证必兼腰痛，当见好眠，睡忍小便者，其腰必痛，水瘀肾藏，以膨急而伤也，否则，其膀胱必痛，亦以膨急而伤也，若夫肾阳以多欲而伤，则水藏虚寒，其气不能上下行不上行，则与水之上源隔绝，而见气短里急，不下行，则下流之，转泄无力，而见小便不利，少腹急，下文虽有小建中一方以治里急，八味肾气丸以治小便不利，自非猛自恋艾。实于生命无济，倘如西厢记所云，月移花影，疑是玉人来，虽虚，其奈之何。

劳之为病，其脉浮大，手足烦，春夏剧，秋冬差，阴寒精自出。瘦削不能行（上节面色白时目瞑兼衄，当在此节劳之为病下）。上节言肾阳之虚，小便不利与少腹急为连文，与下少腹拘急，小便不利同，面色白之语属阴虚，为此节脱简，今订正之，血虚而阳络之未空，不能上荣颜面，因而色白，脑为髓海，髓之精则以目睛为标，精竭而脑虚，目睛失养，不能胜阳光逼，故时目瞑，阴虚而浮阳充脑，气热则颅骨之缝开，故兼衄，此证惟目瞑者。予所亲见，予诗友吴华表名希鄂者，诗才高尚

，当患房劳证，畏阳光虽盛暑，必以黄布帘窗机与人对时，忽然闭目良久，人皆谓目力之不济，而不知脑气不能濡养，眸子不能久耐阳光也，手足烦为掌心足底皆热，脾阴虚也，春夏不胜阳热，故剧，秋冬阳气伏，伏故差阴虚之人，相火不能蛰藏，宗筋易举易泄，而胆火益弱，头益冷，宜乎脾肉日削，欲行不得，而一步之折摇矣。

男子脉浮弱而洩为无子，精气清冷，易始乾坤，生生之义大矣，繁辞传曰，夫干其静也，专其动也，直是以大生焉，其所以象人体者，尽人能言之，人子始生，则母之交骨开，故谓之关，寡欲则无二偶而肾阳义，故静专而动谊，此即大生之义也，若男子之脉，以阳气不足而浮弱，以精血不足而洩，则其实藏元阳必虚，而交感之时，精冷而不能有子，此证惟羊肉当归汤足为疗治。冬令服二三剂，定当黍谷回春，虽妇人有痛淋，亦能生子，屡试而效，阎者倘能传布功德莫大焉（予所定之方用生羊肉三觔，当归四两，生附子一枚，生姜四两，附子无麻醉性，羊肉不膻，生姜不辣，服此者向无流产，忽惧）夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩，发落，脉极芤迟为清杀之血失精，脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝龙骨牡蛎汤主之。

桂枝龙骨牡蛎汤方

桂枝、芍药、生姜各二两

大枣十二枚

龙骨、牡蛎各三两

以上七味以水七升，煮取三升，分温三服

失精之情不同，始则有梦而遗，是尚有相火也，至于不梦亦遗，而肾阳始败矣，又其甚则醒时亦遗，而肾阳益败矣，少腹弦急，属阴下注而小便不利也，阴头寒，精气虚而寒湿下注宗筋也，目之瞳入视脑气盈虚为出入，脑气以精血两竭而虚，故曰眩（（此与痰饮之眩少阳病之眩不同）此与历节之头眩同，精神恍惚，开目则诸的旋转，闭目则略定，世传防眩汤，间有特效，录之以为救急之助，方用党参半夏各三钱，归芍熟地白术各一两，川芎山萸各五钱，天麻三钱，陈皮一钱，轻者四五剂，可以永久不发，予早年病此，嘉定秦芍舫师曾用之，惟多川芎三钱耳，至今三十年无此病，皆芍师之赐也，发者惟血之余，故少年血盛则墨，老年血衰则白，至于肾藏寒，胞中血海之血，乃不能合督脉上行于脑，脑气不濡而发为之落，此正如高秋风燥，草木黄落者，然脉失精则虚，之血则芤，下利清杀则迟，劳之所以精者，相火不能蛰藏也，所以失血者，阴气益虚，相火益炽，阳根拔于下，血海之血乃随之而上脱也，所以下利清杀者，人体精血日损，水分益寒，入胃之水饮以不得温化

而下陷也，胆火下泻，真阴不守，在男子则为失精，在女子则为梦交，于是脉芤而见动脉微而见紧，泄之愈甚，阴寒愈急，若更以滋阴降火之剂投之，则阳气愈不得升，阴液益无统摄，故用桂枝汤以扶脾阳，加牡蛎龙骨以固肾阴，独怪近世医家，专用生地石斛，麦冬、知母、玉竹黄柏一切阴寒滋腻之品，吾不知其是何居心也。

男子平人脉虚弱，细微者，喜盗汗也。

人体血分多于水分，则热度高而脉道利，应指者修达而卫和，水分多于血分，则热度低，而脉道窒，应指者虚弱而微细，水分多则卫强血分少则营弱，凡人醒时则阳气外达，寐则阳气内守，卫所以夜行于阴也，卫气内守则营气当夜行于阳之时，不能外泄，故寐者无汗，惟卫气不守营气从之乃为盗汗，盗汗者卫不与营和也，按伤寒之例，卫不与营和先时以桂枝汤发汗则愈，更加龙骨以镇浮阳，牡蛎以抑上逆之水气，则盗汗当止，师难不出方治，读者当观其通也。

人年五六十，其病脉大者，痹侠背行，若肠鸣马刀侠瘦者，皆为劳得之。

少年气血俱盛，则脉当实大而动数，老年气血俱虚，则脉当虚细而安静，此其常也，至于病脉固不尽然，人当用力太过，阳气外张，则其脉必大，此固不可以年齿论，然则师言其病，脉大痹侠背行者，尽谓劳力阳伤于前，阳张汗泄，故始病倦怠，见浮大之脉，毛也不闭，风寒乘之汗液未尽者，乃悉化为湿，背毛钢于寒湿，因侠背而痹，但既痹之后，阳气一虚，即脉不应大，此证初起，当与风湿同治，麻黄加术，麻黄杏仁薏仁甘草二汤，皆可用之。至于痹证既成，则其脉当微，而为黄芪五物证，所以然者，痹在太阳部分阳气已为寒湿所困，岂有阳气不达而其脉反大者乎。

若阴寒内据，孤阳外越，则其脉亦大，阴寒内据，则水走阳关而为肠鸣，此证不见下利，即病腹痛，宜四逆理中辈，至于外证见马刀侠，凝则脉见弦大，进医以为小柴胡证，其实不然，马刀之状，若长形小蚌，生于腋下，坚硬如石，久乃成脓溃烂，侠凝生于头项，连连如贯珠，初起用旱烟杆中烟油涂之，三日即消，外科小金丹亦可用之，日三服，每服二粒，以消为度。此证虽起于矢志易怒，究与阴疽相类，其中必有寒湿结毒，小柴胡汤必然无济，若不早治，一二年后溃烂不收，未有不死者也。

脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝，手足逆寒，腹满甚则溏泄，食不消化也。

脉沉小而迟，是为水寒血败，血分热度愈低，津液不能化气，故名脱气，疾行则喘喝者，肾虚不能纳气也，血分之热度弱而又弱，故手足逆寒，寒水下陷，故腹满而溏泄，胃中无火，故食不消化，按此条在伤寒论中为少阴寒湿证，亦当用四逆理中主治。

脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革，妇人则半产，漏下，男子则亡血失精。

脉弦为阳气衰，脉大而芤为阴气夺阳，衰则中寒，阴夺则里虚，两脉并见，其名曰革，浮阳不降，则阳不摄阴，阴不抱阳，则精血寒陷，此条见妇人杂病篇，治妇人半产漏下，则有旋覆花汤，而男子亡血失精，独无方治，而补阳摄阴之法要以天雄散为最胜。天雄以温下寒，龙骨以镇浮阳，白术桂枝以扶中气，而坎离交济矣。黄坤载云，后世医法不传治，此乃用清凉滋润，中气崩败，水走火飞，百不一生，今之医士不可问也，谅哉斯言。

天雄散方

天雄三两炮

白术八两

桂枝六两

龙骨三两

上四味杵为散，酒服半钱匕，日三服，不知稍增之。

虚劳里急，悸衄腹中痛，梦失精，四肢痛疼，手足烦热，咽干口燥，小建中汤主之（小建中汤方，桂枝三两，甘草二两，芍药六两，大枣十二枚，生姜三两，饴糖一升，上六味，经水七升，煮取三升，去滓，内腹饴，更上欲火消解，温服一升，日三服）里急以下诸证，用小建中汤，此乃第一篇，所谓治肝脾之方治也，厥阴含少阳胆火，胆实则气壮而强，胆虚则气馁而悸，腹为足太阴部分，肝胆之火逆于太阴，则腹中痛，厥阴之脉络于阴器，胆火下泄，则梦失精，阴泄于下脑应于上，则为衄，脾精不行于四肢，故四肢痛楚而手足烦热，脾精不上承，故咽干而口燥，其病在脾，致病之由则为肝胆，此证肝胆俱虚而不任泻，故特出建中汤以补脾，使肝藏不虚，则胆火潜藏，

岂能曳肾阴而伤脾藏，故又云肝虚则用此法也。

虚劳里急诸不足，黄芪建中汤主之。

黄芪建中汤方，即小建中汤内加黄芪一两半，余依上法，若气短胸满者，加生姜，腹满者去枣加茯苓一两半，及疗肺虚损不足，补气加半夏三两。

虚劳一证，急者缓之以甘，不足者补之以温，上节小建中汤其主方也，但小建中汤于阳虚为宜，阴阳并虚者，恐不能收其全效，仲师因于本方外加黄芪以补阴液，而即以黄芪建中为主名，此外之加减不兴焉，气短胸满加生姜者，阳气上虚，故气短，阴于阳位，故胸满，因加生姜以散之腹满，所以去枣加茯苓者，腹满为太阴湿聚，防其雍阻脾气也，因去大枣加茯苓以泄之，湿去而脾精上行，然后肺得滋溉之益，故肺之虚损亦主之，补气所以加半夏者，肺为主气之藏，水湿在膈上，则气虚而喘促，故纳半夏以去水，水湿下降，则肺气自调，其理甚明。陈修园以为匪夷所思，不免自矜神秘，尽彼第见俗工以补为补而不知以泻为补，故自负读书得闻耳。

虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之（八味肾气丸见妇人杂病篇）

虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利，此肾阳不充之证也，肾藏虚寒，则水湿不能化气，膨急于上则腰痛，膨急于下则少腹拘急，此证仲师主以崔氏八味丸，然予曾用之，绝然不应乃知陈修园易以天雄散为不刊之论也。原肾藏所以虚寒者，则以肾阳不藏之故，肾阳不藏，则三焦水道得温而气反升，水欲下泄，虚阳吸之，此水道所以不通也，方用龙骨天雄以收散亡之阳，白术补中以制逆行之水，桂枝通阳以破阴翳之寒，于是天晴云散，水归其壑矣，虚劳诸不足，风气百疾，薯蓣丸主之。

薯蓣丸方

薯蓣三十分 人参七分 白术六分 茯苓五分 甘草二十八分 当归十分 干地黄十分 芍药六分 芎穹六分 麦冬六分

阿胶七分 干姜三分

大枣百枚为膏 桔梗五分 杏仁六分 桂枝十分 防风六分 神曲十分 豆黄卷十分 柴胡五分 白敛二分

上二十一味，末之炼蜜和丸，如弹子大，空腹酒服一丸，

百丸为剂，虚劳诸不足是为正虚，风气百疾是为邪实，正虚则不

胜表邪，散邪实则不应调补，此尽人之所知，若正虚而不妨达邪，

邪实而仍应补正，则非尽人所知也，仲师虚劳篇于黄芪建中、八

味肾气丸已举其例，后于气血两虚，外感风邪者，出薯蓣丸统治

之方，所用补虚凡十二味，舍薯蓣、麦冬、阿胶、大枣外，实为

后人八珍汤所自出，去风气百疾者凡九味，白敛能散结气，治壅疽疮，欲疮口愈，冻疮出箭簇止痛，大率能通血络壅寒而排泄之力为多，尽风之中人，肌腠外闭而脾阳内停，方中白敛，所以助桂枝之解肌也，风中皮毛，则肺受之，肺气被阻，咳嗽乃作方中用桔梗、杏仁所以开肺也，气血两虚，则血分热度愈低，因生里寒，方中用干姜所以温里也，风气外解必须表汗，然其人血虚，设用麻黄以发之，必致亡阳之变，故但用防风、柴胡、豆卷以泄之，且风著肌肉，脾阳内停，胃中不无宿垢，胃纳日减，不胜大黄、枳实，故但用神曲以导之，要之补虚用重药，惟不胜邪也，开表和里用轻药，惟伤正也，可以识立方之旨矣。

虚劳、虚烦不得眠，酸枣仁汤主之

酸枣仁汤方

酸枣仁二升 甘草一两 知母、茯苓各二两 川芎一两

上五味以水八升，煮酸枣仁得六升，内诸药煮取三升，分温三服。

酸枣仁汤之治虚烦不寐，予既屡试而亲验之矣，特共所以然，

正未易阴也，胃不和者，寐不安，故用甘草、知母以清胃热。

藏血之藏不足，肝有虚而属气不能归心，心阳为之不敛，故用酸枣仁以为君，夫少年血盛，则早眠而晏起，老年血气衰，则晚眠而晨兴，酸枣仁能养肝阴，即所以安魂神而使不外驰也，此其易知者也，惟茯苓、川芎二味，殊难解脱，尽虚劳之证，每兼失精亡血，失精者留湿，亡血者留瘀，湿不甚，故仅用茯苓（茯苓无真者，予每用猪苓、泽泻以代之，取其利湿也）瘀不甚，故仅用川芎，此病后调摄之方治也。

五劳虚极羸瘦，腹满不能饮食，食伤、夏伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤，内有干血，肌肩甲错两目黯黑，缓补虚，大黄蛰虫丸主之。

大黄蛰虫丸方

大黄十分蒸

黄芩二两

甘草三两

桃仁一升 杏仁一升

芍药四两

干地黄十两

干漆一两烧令烟尽

廕虫一升去翅足熬 水蛭百枚熬 蛭螬百枚熬 蛰虫半升熬

上十二味末之，炼蜜和丸，小豆大，酒服五丸，日三服。

大黄蛰虫丸主治为五劳虚极羸瘦腹满不能饮食，外证则因内有干血，肌腠甲错，两目黯黑，立方之意，则曰缓补虚，夫桃仁芍药干漆，所以破干血（芍药破血，人多不信，试问外科用京赤芍何愈）加以廕虫、水蛭、蛭螬、蛰虫诸物之攻瘀，（廕虫俗名地鳖虫，多生髓下垃圾中，伤药中用之，以攻瘀血，今药肆所用硬杀黑虫非是）有实也，大黄以泻之。有热也，杏仁、黄芩以清之，其中惟甘草缓中，干地黄滋养营血，统计全方，以攻邪者多而补正者少，仲师乃曰缓中补虚，是有说焉，营之强寇在境，不痛加剿除，则人民无安居之日，设漫为招抚，适足以养疽遗患是攻瘀，即所以缓中，缓中即所以补虚也，今有患阳明实热者，用大承气汤不死，用滋阴清热之药者，终不免于死，则本方作用可以比例而得之矣。

肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治第七

问曰：热在上焦者，因咳为肺痿，肺痿之病，从何得之，师曰，或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快药下利，重亡津液故得之。

热在上焦二语，为仲师所常言（见下五藏风寒积聚篇）兹特借此发问，以研求肺痿所从来，夫既称热在上焦，便当知上焦在人体中居何部位，焦字究属何义，固不当如庸工所言三焦有名而无形也，尽上焦在胸中，即西医所谓淋巴幹，为发水成汗输出毛也作用，中焦在胃底即西医所指谿肉，中医即谓之脾阳，为吸收小肠水液，由上焦输入肺藏作用，散布未尽之水液，乃由肺下降，由肾藏注膀胱，是为下焦，合上中下三部观之，方显出焦字之义。譬之釜中煮饭蒸气上浮，其饭始干，蒸气化水，仍回于下，釜底之饭，久而焦可见焦之为义，为排泄水液之统名，而排泄作用，实由于少阳胆火，师言热在上焦，因咳为肺痿，便可知病由燥热矣。故仲师历举燥热之病由经答之。曰或从汗出者，肺主皮毛，呼吸与之相应，太阳表汗，由肺外出皮毛，汗出太多，则肺藏燥，曰或从呕吐者，呕吐为胆胃上逆，胆胃气燥，则上灼肺藏，肺藏之液与之俱涸，曰或从消渴者，消则胆火逼水液而泄出肾膀，渴则胃中热而引水自救，随消随渴，则肺藏之液以涸，曰小便利数者，肺为水之上源，水从下焦一泄无余，则上源告竭，曰或从便难又被快药下利重亡津液者，大肠与肺为表里，大肠燥则肺藏与之俱燥，以视肺癰，但有虚实之别耳，故治此证者，火逆之麦门冬汤，肺癰之千金苇茎汤，并可借用。仲师固未出方治也。按内经云，肺热叶焦，则生痿痹，尽上源绝则下流涸，津液枯燥，不濡筋脉，而两足挛急，此因痿成痹之证，予于沉松寿亲见之，尽始则病后能食，继则便难，终则脚挛急，故治痿属取阳明也（章次公在红万字会治痿证，用大承气及鲜生地、玉竹、知母等味重剂，五剂而瘥，是时重证者为虚扶摇，瘥者始则两足不能移动，继则自行走去，尽步履如常矣）曰寸脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者，何师曰，肺痿之病，若口中辟辟燥咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺壅，咳吐脓血，脉数虚者为肺痿，数实者为肺壅。

上文但举肺痿病，由然犹未详，肺藏燥热之脉何如也，曰：寸口脉数，热在肺也，曰其人咳，气上逆也，脉数而气逆，病当口燥乃口中反有粘腻之司唾涎沫，可见肺藏之津液被燥气蒸逼，患化痰涎，故可决为肺痿，所以别于肺壅者，以其津液随热外泄而不内闭也，至于口中辟辟作声，燥咳无津，每咳则胸中隐隐作痛，便可决为肺癰者，壅也，尽此证肺络为外邪壅塞，变而生热，热伤血滞，因而成癰，风袭于肺故咳，血变成脓，故胸中隐隐作痛，血络壅则营分热度增高，故脉数，肺中热变血腐，故咳吐脓血，要之肺痿之与肺壅，皆出于热，不过为虚实之辨，故脉数相似，浮而虚者为痿，滑而实者为壅也。

问曰，病咳逆，脉之何以知其为肺壅，当有脓血，吐之则死，其脉何类，师曰寸口脉浮而数，浮则为风，数则为热，浮则汗出，数则恶寒，风中于卫，呼气不入，热

过于营，吸而不出，风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，口干喘满，咽燥不渴，多吐浊沫，时时振寒，热之所过，血为之凝滞，畜结壅脓，吐如米粥，始萌可救，脓成则死。

咳逆之证有痰饮，有风邪，有水气，所以决定为肺壅者，要有特异之脉证，肺壅之死证，固以吐脓血为最后一步，要其最初病因则甚轻，揆仲师所举脉证，特为中风之证。其脉浮，发热自汗恶寒，此宜桂枝汤以发之者也，今日寸口脉浮而数，泛则为风，数则为热，则汗出，数则恶寒，风中于卫，呼气不入，热过于营，吸而不出其与太阳中风发热汗出鼻鸣干呕者何异。或早用桂枝汤以发其汗，宜必无肺壅之病，惟其失时不治，改风热内陷肺藏，久久寢成肺壅，究其所以然，风伤皮毛，则内含于肺，热伤肺络，则变为咳嗽，但初见口干喘满，咽燥不渴，多唾浊沫时时振寒，虽非若前此之桂枝汤证，苟能清燥极肺，其病犹易愈也，惟其热变肺藏，肺中血络凝阻，若疮疡然，其始以血络不通而痛，痛之不已，遂至蒸化成脓，吐如米粥，则内壅已成，始崩尚有方治，脓溃则万无一生，此肺壅之大略也。

上气面浮肿，肩息，其脉浮大，不治，又加利，尤甚。

上气喘而躁者，此为肺胀，欲作风水，发汗则愈。

肾不纳气，则气上冲，肺气壅塞，则气亦上冲，但面浮肿，则痿黄而不泽，肩息则气短而不伸，加以浮大之脉，则阳气将从上脱，故曰不治，又加下利，则阳脱于下也，此上气以肺肾两虚而不治者也，若夫喘逆而躁疾，则为肺实，而胀为风遏太阳寒水不能外达皮毛之证，欲作风水则为风水未成，尽风水既成必至一身尽肿，此证独无，故曰发其汗，即愈，麻黄加术汤、越婢汤、小青龙汤，俱可随证酌用此上气以肺实而易愈者也。

肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴必遗尿，小便数，所以然者，以上虚不能制下故也，此为肺中冷，必弦多涎唾，甘草干姜汤以温之，若服汤已渴者，属消渴（甘草干姜汤方，甘草四两炙，干姜二两炮，上咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服）痰之言萎，若草木然，烈日暴之，则燥而萎，水泽渍之，则腐而萎，本条吐涎沫而不渴之肺痿，与上燥热之肺痿要自不同，所谓不渴必遗尿，小便数者，上无气而不能摄水也，气有余即是火气不摄水，则肺中无热，可知然，则仲师所谓肺中冷实为肺寒，眩为水气上冒，多涎唾，则寒湿在上也，故宜甘草干姜汤以温之，陈修园以为冷淡之，冷不可以不然，服汤已而渴者，何以属燥热之消渴也，便可知甘草干姜方治专为寒，肺痿设矣。又按伤寒太阳篇，干姜甘草汤治，误用桂枝汤发汗、伤其脾阳，而手足见厥冷而设，故作干姜甘草汤以复其阳，便当厥愈足温，但治厥倍干姜，治痿倍甘草耳，此亦虚寒用温药之明证也。（此方治寒肺痿，要为升发脾精上滋肺藏而设，章次公云）

咳而上气，喉中水难声，射干麻黄汤主之

射干麻黄汤方

射干三两

麻黄、生姜各四两

细辛、紫菀、款冬花各三两

大枣七枚

半夏半升

五味子半升

右九味以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药煮取三升，分温三服。

太阳水气，不能作汗外泄，则留著胸膈而成寒饮，饮邪上冒则为咳，胸有留饮吸入之气不顺，则为上气，呼吸之气引胸膈之水痰出纳喉间，故喉中如水难声，格格而不能止，此固当以温药和之者也，故射干麻黄汤方治，麻黄、细辛、半夏、五味子并同小青龙汤，惟降逆之射干，利水之紫菀（本草有云，能通小便）散寒之生姜，止咳之款冬，和中之大枣，则与小青龙汤异，究其所以然，咳而上气之证，究为新病，不似痰饮之为痼疾，及时降气曳水开肺散寒，尚不至寢成痰饮，外此若细辛之治咳，五味之治气卫，生麻黄之散寒，生半夏之去水，不惟与小青龙汤同，并与苓甘五味姜辛半夏汤同，可以设立方之旨矣。

咳逆上气，时时吐浊，但坐不得眠，皂荚丸主之

皂荚丸方

皂荚八两刮去皮炙 蜜丸梧子大，以枣膏和汤服三丸，日三夜一服。

上节云，咳而上气，是不咳之时，其气未必上冲也，若夫咳逆上气，则喘息而不可止矣，此证惟背雍叠被六七层，尚能垂头而睡，倘叠被较少，则终夜呛咳，所吐之痰黄浊胶粘，此证予于宣统二年侍，先妣邢太安人病亲见之。先妣平时喜食厚味，又有烟癖，厚味被火气蒸灼，因变浊痰，气吸于上，大小便不通，予不得已，自掣皂荚丸进之，长女昭华煎枣膏汤如法尽夜四服，以其不易下咽也，改丸如绿豆大，每服九丸，凡四服，浹晨而大小便通，可以去被安睡矣（后一年，闻晋乡城北朱姓

老妇，以此证坐一月而死，可惜也)

咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之，咳而脉沉者，泽漆汤主之

厚朴麻黄汤方

厚朴五两 麻黄四两

石膏如鸡子大

杏仁半升 半夏半升 干姜、细辛各二两

小麦一升

五味子半升

上九味以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，纳诸药煮取三升，温服一升，日三服。

泽漆汤方

半夏半升 紫参一本作紫苑

生姜、白前各五两 甘草、黄芩、人参、桂枝各三两 泽漆三升以东流水五斗
煮取一斗五升泽漆即大戟苗性味功用与大戟相同，今泥上药肆无此药即用大戟可也

上九味咀，内泽漆汤中煮取五升，温服五合，至夜尽

咳而脉浮，水气在胸膈间，病情与痰饮同，咳而脉沉，水气在肩下，病情与痰饮异，惟病原等于痰饮，故厚朴麻黄汤方治，略同小青龙汤，所以去桂枝、芍药、甘草者，桂芍甘草为桂枝汤方治，在伤寒论中，原所以扶脾阳而泄肌腠，中医所谓脾阳即西医谓腑，在胃底，为吸收小肠水气发舒津液作用，属中焦，此证咳而脉浮，水气留于胸膈，胸中行气发水作用，西医谓之淋巴管，中含乳糜，属上焦，去桂芍甘草加厚朴者，正以厚朴去湿宽胸，能疏达上焦太多之乳糜故也。人体之中，胃本燥热，加以胸膈留饮，遏而愈炽，所以加石膏者，清中脘之热，则肺气之下行者顺也，所以加小麦者，咳则伤肺，饮食入胃，由脾津上输于肺，小麦之益脾精，正所以滋肺阴也（妇人藏燥，悲伤欲哭，用甘参大枣，悲伤欲哭，属肺虚，三味皆补脾之药，可为明证也）此厚朴麻黄汤大旨，以开表蠲饮为主治者，惟病原异于痰饮，故泽漆汤方治，君行水之泽漆（本草利大小肠，治大腹水肿）而去水之生半夏、利水之紫苑佐之（原作紫参非）咳在上则肺热不降，故用黄芩以清之，白前以降之，水

在下则脾藏有寒，故用生姜以散之，桂枝以达之，水气在下则胃气不濡，故用人参甘草以益之，此泽漆汤大旨，以去水肃肺和胃为主治者也。

火逆上气，咽喉不利，上逆下气，麦门冬汤主之

麦门冬汤方

麦门冬七升 半夏一升 人参、甘草各二两

粳米三合

上六味以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三夜一服。

火逆一证，为阳盛极阴，太阳篇所谓误下烧针因致烦燥之证也，尽此证胃中津液先亏，燥气上逆，伤及肺藏，因见火逆上气，胃中液亏，则咽中燥，肺藏阴伤，则喉中梗塞，咽喉所以不利也，麦门冬汤，麦冬、半夏以润肺而降逆，人参、甘草、粳米、大枣以和胃而增液，而火逆可愈，喻嘉言不知肺胃同治之法，漫增清燥极肺汤，则不读书之过也。

肺壅，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之

葶苈大枣泻肺汤方

葶苈熬令黄色捣丸如弹子大

大枣十二枚

上先以水三升煮枣取二升，去枣，内葶苈煮取一升，顿服。

咳而胸满，振寒，脉数、咽干，不渴，时出蜀唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺壅，桔梗汤主之（桔梗汤方，桔梗一两，甘草二两，上以水三升，煮取一升，分温再服，则吐脓血也）肺为主气之藏，风热壅阻肺窍，吸气不纳，呼气不出，则喘，喘急则欲卧不得，叠被而倚息，证情与但坐不得眠之咳逆上气者相近。

但不吐蜀耳，壅脓未成，但见胀满，故气机内闭而不顺，此证与支饮不得息者，同为肺满气闭，故宜葶苈大枣泻肺汤，直破肺藏之变结，用大枣者，恐葶苈猛峻，伤及脾胃也（此与皂荚丸用枣膏汤同法）至如咳而胸满，尽即喘不得卧之证，见于内藏者，热郁于肺，皮毛开而恶风，故振寒，血热内炽，故脉数，肺液被风热灼烂，故咽干，口多涎沫，故不渴，要其使明，胸中便隐隐作痛，时出蜀唾腥臭，至于失

时不治，吐脓如米粥，则肺壅已成。桔梗汤方治，桔梗开泄肺气，兼具滑泽之针性，以去滋垢，倍甘草以消毒，使脓易吐出，而壅自愈矣。排脓汤之用桔梗，亦即此意，剧者赤小豆当归散，亦可用之，热重者，千金苇茎汤亦可用之，苇茎即芦根，瓜瓣不知何物，许半龙、章次公俱以冬瓜仁代之，亦通，尽冬瓜仁在肠壅大黄牡丹汤方治中，为保肺泄肠之品也，惟犀黄丸一方，最为消毒上品，初起时服之一料，无不愈者。方用犀黄五分，元寸五分，净乳香没药各二两，先将乳没研细，然后和入犀黄元寸，加糯米粉五钱，捣和为丸，如稗米大，每服三钱，又有俗传单方，用隔年针芥卤，每日半杯，和豆腐浆饮之，胸中梗塞顷之吐出脓血，日进一服，吐至无脓为度，而痈即愈矣。此皆补经方所未仅俾，济世者资采择为辛未七朋望后予治浦东陈姓一证，胸中痛，咯痰腥臭如米粒，初诊用桔梗一两，甘草五钱，五剂而胸痛止，二诊用葶苈五钱，黑枣十二八，五剂而如米粒之脓尽，三诊用千金苇茎汤，五剂而腥臭尽，岂知病根未拔，九朋初十日复来，咯痰腥臭如昔，但不似米粥耳，予仍用桔梗汤加冬瓜仁、昆布、海藻、大小蓟以消余毒，另授以犀黄丸九钱，令其日进一服，病者遂不复至，尽已愈矣，致肺壅初起脚骨必痛，或舌下肿起一粒，以刀针破之，脓已成者，其血紫黑，未成者淡红，服犀黄丸百不一失，医者审之，已已三月，长女昭华治愈王姓肺壅，亦用犀黄丸取效，附录之以告同志。

咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状，脉浮大者，越婢加半夏汤主之。

越婢加半夏汤方

麻黄六两

石膏半升 生姜三两

大枣十五枚

甘草二两

半夏半升

上六味以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

肺胀咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下水，小青龙加石膏汤主之

小青龙加石膏汤方

麻黄、芍药、桂枝、细辛、干姜、甘草各三两

五味子、半夏各半升 石膏二两

上九味以水一斗，先煮麻黄去上沫，内诸药，煮取三升，强人服一升，羸者减之，日三服，小儿服四合。

咳而上气，为民下有水，为咳嗽吸引而上冲，不咳之时则其气如平，与咳逆上气之全系燥热不同，前条已详辨之，惟水气所从，来则起于太阳失表，汗液留积胸膈间，暴感则为肺胀，寝久即成痰饮，使其内藏无热，则难不免于咳必兼见恶寒之象，惟其里热与水气相搏，乃有喘咳，目如脱状，或喘而并见烦躁，发之脉浮者，当以汗解，浮而大，则里热甚于水气，故用越婢加半夏汤，重用石膏以清里而定喘，脉但浮，则水气甚于里热，故用蠲饮之小青龙汤加石膏以定喘，重用麻桂干辛，以开表温里，而石膏之剂量独轻，观麻杏石甘之定喘，当可悟二方之旨矣。

奔豚气病脉证第八

师曰，病有奔豚，有吐脓，有惊怖，有火邪，此四部皆从惊发得之，此一节，因奔豚起于惊发而连类以及他证，吐脓为肺壅，桔梗甘草汤证也（见上篇）误列百合狐惑篇之赤小豆当归散，肠痛方治，亦可用之，火邪有太阳阳热，以水薰，下陷胞中，固脓血者，仲师未出方治，称意当用桃核承气汤以下之，亦有太阳寒水，因炙而陷下焦，邪无从出，腰以下重而痹者，俟其阳气渐复，乃能汗出而解（并见太阳篇）独惊怖一证，未见，太阳病加温针必惊，火劫亡阳则为惊狂，此本桂枝去芍药加蜀漆、龙骨、牡蛎证，予谓暴感非常而病惊怖者，病情正与此同。所以然者，以二证立有热痰上冲脑部故也，特无太阳表证者，但用蜀漆、龙骨、牡蛎已足，仲师以其与奔豚同出一原，故类举之耳。

师曰，奔豚病从少腹上冲咽喉，发作欲死，后还止，皆人惊恐得之。

奔豚气上冲胸腹痛，往来寒热，奔豚汤主之

奔豚汤方

甘草、川芎、当归、黄芩、芍药各二两

半夏、生姜各四两

生葛五两 甘李根白皮一升

上九味以水二斗，煮取五升，温服一升，日三夜一服。

奔豚之病，少腹有块贲起，发作从下上冲，或一块，或二三块，大小不等，或并而为一方其上冲，气促而痛，及共下行，其块仍留少腹，气平而痛亦定，但仲师言从惊恐得之，最为精确，与难以所云从季冬壬癸日得之者，奚啻郑昭宋龚之别，予当治平姓妇，其人新产，会有仇家至门寻事毁物漫骂，恶声达户外，妇大惊怖，嗣是少腹即有一块，数日后，大小二块，时上时下，腹中剧痛不可忍，日暮即有寒热，予初投以炮姜、熟附、当归、川芎、白芍，二剂稍愈，后投以奔豚汤二剂消，惟李根白皮，为药肆所无，其人于谢姓园中得之，意得痊可尽亦有天幸焉。

（发汗后）烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上至心，炙其核上各一壮，与桂枝加桂汤主之（桂枝加桂汤方，桂枝五两、芍药、生姜各三两，甘草二两炙 大枣十二枚，上五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，服一升）

伤寒论此节发端，无发汗后三字，尽衍文也，烧针令发汗，本桂枝汤证，先服桂枝汤不解，刺风池风府，却与桂枝汤则愈之证，乃针后不用桂枝汤，风邪未能外泄，寒气乘虚而闭针孔，夫风池本少阳之穴，风府以营脉之穴而属少阴，二穴为寒邪所遏，则少阳抗热，挟少阴卫气，一时暴奔而上，此所以针处核起而赤，必发奔豚也，故仲师救逆之法先炙核上，与桂枝加桂汤，比即先刺风池风府，却与桂枝汤之成例，所以汗而泄之不令气机闭塞，吸而上冲也。

余详伤寒发微太阳篇兹不赘

发汗后，脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之（茯苓桂枝甘草大枣汤方 茯苓半斤 甘草二两 大枣十五枚 桂枝四两 上四味，以甘澜水法，取水二斗，置大盆内，以杓搗之，上有珠子五六千颗相逐，取用之也）

发汗则伤阳，阳虚而水气上凌，则脐下悸，欲作奔豚者，不过水气为浮阳吸引，而非实有癰瘕也，故仲师苓桂甘枣汤方治，用茯苓以抑水，桂枝以通阳，甘草、大枣培中气而厚提防，使水邪不得上越，后煎以甘澜水搗之至轻使不邪之上越，脐下之悸平，奔豚可以不作矣。余详伤寒太阳篇，兹不赘。

胸痹心痛短气病脉证治第九

师曰，夫脉当坂太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也，今阳虚知在上焦，所以胸痹，心痛者，以其阴弦故也。

诊病者之脉，阳有余，阴不足，则为发热自汗之中风，以阳有余而阴不足也。故其脉右浮而左弱。阳不足阴有余，则为胸膈引痛之胸痹，故其脉右微而左弦，营弱而卫强，故脉有太过不及，阳虚而阴盛，故脉亦有太过不及。胸痹之证，阳气虚于上，而阴寒乘之之证也，阳气主上，阳脉微，故知在上焦（上焦在胸中，西医谓之淋巴管，为发抒水液之统机，微管中并有乳糜，乳糜停阻，则凝结而痛）心之部位在胸中，故曰胸痹心痛，与心中坚痞在心中，俱为仲师失辞，脉弦为有水，为阴寒，水气与寒并结胸中，故痛，是可于左脉沉弦决之。

平人无寒热，短气不足经息者实也。

其人素无他病，忽然肺窍气短，而呼吸不顺，非留饮阻于膈上即宿食留于中脘，与胸痹之阴寒上越者不同。法当蠲饮导滞，仲师以其与胸痹相似而举之，使人知虚实之辨也，胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝蒌薤白白酒汤主之。

栝蒌实一枚捣

薤白半升

白酒七升

上三味同煮取二升，分温再服。

凡人劳力则伤阳，耐夜则寒袭，然而采芙蓉膏泽一榻明灯冒，城郭星霜五更寒，析卒不病此者，尽以卧者，阳不散行者，阳独张也，惟劳国伛偻之人，往往病此，予身者，在同仁辅元堂亲见之，病者但言胸背痛，脉之沉而蓄尺，至关上紧，虽无喘息咳吐，其为胸痹，则确然无疑，问其业，则为缝工，问其病因，则为寒夜伛偻制裘，裘成稍觉胸闷，久乃作痛，予即书栝蒌薤白白酒汤授之。方用瓜蒌五钱，薤白三钱，高粱酒一小杯，二剂而痛止，翌日复有胸痛者，求诊，右脉沉迟，左脉弦急，气短问其业，则亦缝工，同其病同脉，则大同而小异，予授以前方，亦二剂而瘥，尽伛偻则胸膈气凝，用力则背毛汗泄阳所，虚而阴气从之也，惟本条所举喘息咳唾，所见二证皆无之，当移后节不得卧上为其兼有痰饮也。

胸痹不得卧，心痛澈背，栝蒌薤白半夏汤主之

栝蒌薤白半夏汤方

栝蒌实一枚捣

薤白三两 半夏半升 白酒一升

上四味同煮取四升，温服一升，日三服。

咳而上所，时吐浊，但从不得眠，与此证不得卧相似，惟不见黄厚胶痰，则非皂荚丸证可知，咳逆倚息不得卧为风寒外阻，吸起痰饮。与此证不得卧同，而心痛澈背为独异，则非小青龙汤证可知，夫肺与皮毛，束于表寒，则寢成留饮，甚至倚息不得卧，惟胸背痛为胸痹的证，固当从本证诊论治，特于前方加生半夏以蠲饮，所以别于前证也。

胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满胃下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之，人参汤亦主之

枳实薤白桂枝汤方

枳实四枚 薤白半斤

桂枝一两

厚朴四两

上五味以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升去滓，内诸药，数沸，分温三服。

人参汤方

人参、甘草、干姜、白术各三两

上四味以水八升，煮取三升，温服一升，日三服

寒缚于表，而肺气内停，清阳之位固已为阴霾所据，日久遂变痰涎，痰积于上，故胸中痞，气留积不散，胸中为上焦，发水行气之道路，下焦水道，由肾下接膀胱，肾膀并在胁下，胸中阻塞胁下，水气为阴霾所吸，乃从胁下逆行，冲迫心下，当见土润溽暑之时，云阴尽晦，地胁中水气，为在上蒸气吸引，暴奔于上，俗名挂龙，自非雷以动之，风以散之，雨以降之，安在于顷刻之间，俾天光下济，枳实栝蒌实运痰下行，譬之雨，薤白通阳，譬之雷，厚朴燥湿，譬之风，而胸中阴霾之气乃一

泄无余矣，上无所引，则下无所吸，胆得胸满一去，而胁下逆抢自定，至于人参汤一方，乃服，汤后调摄之方，而非胸痹正治，明者辨之。

胸痹、胸中气寒，短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳生姜汤亦主之

茯苓杏仁甘草汤方

茯苓三两 杏仁五十两 甘草一两

上三味以水一斗，煮取五升，温服一升，日三服，不差更服。

橘枳生姜汤方

橘皮一斤 枳实三两

生姜半斤

上三味以水五升，煮取二升，分温再服

胸中气塞，其源不二，一由水停伤气，一由湿痰阻气，水停伤气，以利水为主，而用茯苓为君，佐杏仁以开肺，甘草以和中，而气自顺，湿痰阻气，以疏气为主，而君橘皮枳实以去痰，生姜以散寒，而气自畅，证固寻常，方亦平近，初无深意者也。

胸痹缓急者，薏苡附子散主之

薏苡附子散方

薏苡十五两

大附子十枚炮

上二味，杵为散，服方寸匕，日三服

胸痹缓急，仲师以薏苡附子散为主治之方，薏苡去湿，附子散寒，此固尽人能言之，但缓急二字，毕竟当作何解，病状未知，而妄议方治，恐亦误人不浅也，尽胸为太阳出入之道路，湿痹则痛，平时痛缓，遇寒则痛急，故谓之缓急，方用薏苡以去湿，大附子以散寒，欲药力之厚，故散而服之，病不可以急攻，故缓而进之，方中薏苡用至十五两，大附子十枚，以今权量计，大附子每枚当得一两半，则十枚亦得

十五两矣，谁谓古今权量之不同耶。

心中痞诸逆，心绞痛，桂枝生姜枳实汤主之

桂枝生姜枳实汤方

桂枝、生姜各三两

枳实五两

上三味，以水六升，煮取三升，分温三服

湿痰阻于膈上，则心阳以不运而痞，心阳不运，则胸中之阳气虚，阳虚于上，肾邪凌之，卫气逆之，而心为之绞痛，治之者当伏其所主，扶心阳破湿痰，则痞去而痛止矣，此用桂枝枳实生姜之意也。

心痛澈背，背痛澈心，乌头赤石脂丸主之

乌头赤石脂丸方

乌头一分炮 蜀椒、干姜各一两 附子半两 赤石脂一两

以五味末之，蜜丸如桐子大，先食服一丸，日三服，不知稍加服，前证心痛澈背，既出栝蒌薤白半夏汤方治矣，此并见背痛澈心之证，其不当以前方混治，固不待言，按五藏风寒积聚篇云，心中寒者，其人苦病，心如瞰蒜状，剧者心痛澈背，背痛澈心，譬如虫注，脉浮者，自吐乃愈，然心何以中寒，何以如瞰蒜状痛，何以如虫注，何以自吐乃愈，与乌头赤石脂丸证是一、是二，皆不可知也。尽此证与胸痹同，阳微于上，阴乘于下也，如瞰蒜者，形容无可奈何之状，谚所谓猢猻吃辣椒也，注之言窘，背方痛而已窘于心，心方痛而又窘于背，一似虫之窘于前后，故如虫注，心阳衰微，阴寒乘之，自生湿痰，心阳始不受困也，尽此即乌头赤石脂丸证，以肾邪之凌心也，故用止涩之赤石脂（邓桃花汤及赤石脂禹余粮汤，可见止水功用）。方中乌头炮用，附子生用，一以固表阳，一以去肾寒，其中皆有学意，独怪近日药肆，至于不仅生附子有书于方版者，反以为怪，则庸工之教也（脉浮者能吐，故无方治，此证脉必沉紧，故别出方治如此）

腹满寒疝宿食病脉证治第十

趺阳脉微弦，法当腹满，不满者必便难，两肢疼痛，此虚寒从下上也，当以温药服之。

趺阳脉在足背，为胃脉根，其脉当滑大而和，今以微弦之脉见于趺阳，是谓阴邪上逆，是生胀满，譬之裘水坚冰，沃以沸汤，犹恐不济，稍事迟疑，则若然崩裂矣。所以然者，寒之力百倍于热也，是故寒入太阴，则腹满，不满亦必痰涎壅阻，浸成痼瘕，而大便不通，寒水上逆，则水道不行而两肢疼痛，两肢为下焦水道从出之路，寒水膨则腰中痛，引两肢，所谓虚寒从下上者，为水邪将上干阳位也，仲师但言温药服之而未出方治，称意当用大黄附细辛汤，所以然者，以腹满兼有寒痰故也。

（门人俞哲生腹满脉弦者无宿食，宜附子粳米汤，便难者有宿食，故宜温下，亦通）

病者腹满，按之不痛为虚，痛者为实，可下之，舌黄未下者下之，黄自去。

同一腹满，要有阴寒宿食之辨，宿食则按之而痛，不按亦痛，阴寒亦时而痛，按则痛止，然证情时有变化，不当有先入之见，予曾与丁济华治肉铺范姓一证，始病喜按，既服四逆汤而愈矣。翌日剧痛，按之益甚，济华决为大承气证，书方授之，明日，问其蛭愈矣，又与陈中权黄象鼎诊药姓女孩，始病腹满不食，渴饮不寐，既下而愈矣，翌日病者热甚，予乘夜往诊，脉虚弦而面戴阳，乃用附子理中汤，一剂而瘥，可见腹满一证，固有始病虚寒得温药而转实者，亦有本为实证，下后阴寒乘虚而上越者，倘轨而不化，正恐误人不浅也，至于舌苔黄厚或焦黑，大承气一下即愈，此庸工能知不具论。腹满时减，复如故此为寒，当与温药。

腹满不减，减不足言，仲师既出大承气方治矣，此却以时减时满为寒，知虚实之言辨，即在减与不减矣，尽宿食有形，阴寒无形，有形者不能减，无形者，能减，此人之所易知也，当视同乡章向青腹满证，病经半载，马泽人投以熟附子，则稍减，予改用生附子三钱，佐以干姜白术，五六剂减其太半，六月中至上海，以方示恽钱樵，以为不必再服，由恽处方服之，无效，后赴丹阳访贺医，乃用海参汤、韭菜子等味，日及此湿令治愈，乃不复发，回江阴后，服至十余剂，病乃大瘥，乃知去病方治，不可太过也。

病者痿黄，燥而不渴，胸中寒实，而利不止者死。

病者痿黄，寒湿之象也，燥而不渴，寒湿隔于中脘，胃中无热而津不上输也，胸中寒实而利下不止，是为上下俱寒，生阳俱绝，故仲师以为必死，然用大剂术附以回阳，用去湿之赤石脂，禹余粮以止涩下焦，或亦当挽救一二也。

寸口脉弦者，即胁下拘急而痛，其人嗇嗇恶寒也。

寸口脉弦者，即太阳病，浮紧之脉，太阳之脉，出脑下项夹背脊抵腰中，太阳本寒，入里，故齐下拘急而痛，嗇嗇恶寒，病在皮毛，此当用葛根汤，使下陷之寒邪循经上出而外运皮毛，便当一汗而愈，尽齐下之拘急，原待于项背强也，夫中寒家喜欠，其人清涕出，发热，色和者善嚏。

中寒，其人下利，以里虚也，欲嚏不能，此人肚中寒。

寒有微甚不同，轻者在肺，是为表寒，重者在肚，是为里寒，不日在肚者，以太阳寒水与太阴湿土混杂病，在脾而不在胃也，胃气郁而欲伸，故喜欠。肺窍之气，经寒化水，故清涕出，善嚏者，清寒入肺窍，肺中热气与之相冲激也，骨中之血与寒相抗，故发热，寒不入营，故色和，此证俗名伤风。以荆防姜苏煎薰头面而即愈者也，但失此不治，寒水陷入太阴，即病下利，寒入于里，不得外泄，故欲嚏不得，此时惟有重用五苓散，使水气从小便出，庶为近之，所谓因势利导也。

夫瘦人绕脐痛，必有风冷，杀气不行，而反下之，其气必冲，不冲者，心下则痞。

风邪挟寒，由肌腠入，则脾阳为之不运，表受风寒者，多不欲食，此杀气所由停也，杀气停则浊不行，故绕脐痛，此寒积也。治此者即宜四逆理中，否则亦当温下，若误用寒凉，则气必上冲，所以然者，宿食去而风寒不去也，按太阳篇下之后，气上冲者，可与桂枝汤，不上冲者，不得与之，所以然者，气上冲，则负邪不因下而陷，故仍宜桂枝汤，若不上冲而心下痞，便当斟酌虚实，而用泻心汤矣。

病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故，厚朴七物汤主之

厚朴七物汤方

厚朴半斤 甘草、大黄各三两

大枣十枚 枳实五枚 桂枝二两

生姜五两

上七味以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服，呕者加半夏五合，下利去大黄，寒多者加生姜至半斤

解外与攻里同治，此俗医所诃，系为厉禁者也，病见腹满发热是为表里同病，十日脉数，饮食如故，则里实未甚，而表邪未去，表邪为风，故用中风证之桂枝汤而去

芍药，里实为大便硬，故用和燥气之小承气汤，此仲师参变方治，不从先表后里之例者也，辛未秋七月，予治虹雨庙弄，吴姓小儿，曾用此方，下后热退腹减，疑用补脾温中法，病家不信，后仍见虚肿，延至八月而死，可惜也（下后脾虚，则气易胀，虚而寒气乘之，则寒亦能胀，）腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满，呕吐，附子粳米汤主之

附子粳米汤方

附子一枚炮

半夏、粳米各半升 甘草一两 大枣十枚

上五味，以水八升煮取，米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

此中阳将败，水寒上逆之证也，寒乘中气之虚，故曰寒气，水走肠间，故雷鸣，寒气结于太阴部分，故切痛，切痛者沉著而不浮也，胸胁逆满而呕吐者，阳虚于上而肾藏虚寒，乘中阳之虚而上越也，附子粳米汤用炮附子一枚以回肾阳，用粳米、甘草、大枣以扶中气，复加半夏以降卫逆，肾阳复则虚寒之上逆者息矣，中气实则雷鸣切痛止矣，卫逆降则胸胁逆满呕吐平矣。或谓腹中雷鸣为有水，故纳生半夏以去水，寒气在腹故切痛，故用附子以定痛，说殊有理，并存之。

痛而闭者，厚朴三物汤主之

厚朴三物汤方

厚朴八两

大黄四两

枳实五枚

上三味，以水一斗二升，先煮二味取五升，内大黄煮取三升，温池一升，以利为度。

病腹满发热，为表里同病，故参用桂枝汤以解外。若但见腹痛便闭而不发热，厚朴三物汤已足通大便之闭，一下而腹痛自止矣。按此方即小承气汤，惟厚朴较重耳。

按下心下满者，此为实也，当下之，宜大柴胡汤（大柴胡汤方，柴胡半斤，黄芩、芍药各三两，半夏半斤，枳实四枚，大黄二两，大枣十二枚，生姜五两，上八味，

以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，温服一升，日三服）

今日之世家，莫不知大柴胡汤为少阳阳明合病方治，而仲师乃以治心下满痛，心下当胃之上口，满痛为胃家实，非心尽关少阳，此大可疑也，不知小柴胡汤本属太阳标阳下陷方治，按伤寒之例，太阳病汗下利小便亡其津液。则转属阳明，汗出不澈者，亦转属阳明，一为寒水发泄太尽，一为标热下陷，故心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之，发热汗出心下痞硬，呕吐下利者，大柴胡汤主之，可见太阳将传阳明，其病心见于心下矣，此心下满痛所以宜大柴胡汤，亦犹心下痞硬，呕吐下利者之宜大柴胡汤，皆为标热下陷而设，初不关于少阳也。

腹满不灭，灭不足言，当下之，宜大承气汤（大承气汤方见伤寒阳明篇，又见痉病）

说详腹满时灭，条并见伤寒阳明篇

心中大寒痛，呕不能饮食，腹中满，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近者，大建中汤主之。

大建中汤方

蜀椒二合炒去汁 干姜四两 人参一两

上三味，以水四升，煮取二升，去滓，内胶饴一升，微火煎取二升，分温再服，如一烦顷，可饮粥二升，后更服，当一日食糜粥，温覆之。

阳气痹于上，则阴寒乘于下，心胸本清阳气衰而寒气从之，因而作痛，寒入于胃，则呕而不能饮食，寒入太阴则腹中满，寒气结于少腹，一似天寒瓶水冻而欲裂，于是上冲皮起，见有头足，上下俱痛而不可触近，此病于脾胃特重用大建中汤，干姜经温脾，人参以滋胃，加饴糖以缓痛，饮热粥以和中，特君蜀椒以消下寒，不待附子乌头，便已如东风解冻矣。

胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤

大黄附子汤方

大黄三两 附子三枚 细辛二两

上三味，以水五升，煮取二升，分温三服，若强人煮取二升半，分温三服，服后如人行四五里进一服。

弦为阴脉，主肾虚而寒动于中，寒水上逆则为水气，为饮邪，阳虚于上，则为胸痹，为腹满，寒疝，本条云，胁下偏痛发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤，夫胁下偏痛，可以知为寒水凝结，发热似有表证，何以知其当下，诊病者要不可无定识也，胁下为肾，属中下二焦水道之关键（由中焦而上出胸中，上接肺阴，出皮毛为汗，肺气下行，津液还入胃中，灌溉大肠，余则由齐下肾藏走下焦，输泄膀胱为溺）

水道阻于关键，故胁下痛，伤寒误下成痞，足为旁证，卧者平时偏著之处，即为痛处，所以然者，则气凝也，阴寒内据，则浮阳外泄，阴寒不破，则孤阳无归，弦数者当下其寒也，方中附子细辛以去寒而降逆，行水而止痛，更得大黄以利之，则寒之凝瘀者，破而胁下水逆通矣，内经云，痛则不通，稟其然乎。

寒气厥逆，赤丸主之

赤丸方

乌头二两炮 茯苓四两 细辛一两 半夏四两

上四味，末之，内真朱为色，炼蜜为丸，如麻子大，先食饮，酒下三丸，日再夜一服，不知，稍增之，以知为度。

寒气厥逆，此四逆汤证也，然则仲师何以不用四逆汤而用赤丸，知此意者，方可与论赤丸功用，尽汤剂过而不留，可治新病，不可以治痼疾，且同一厥逆，四逆汤证，脉必微细，赤丸证脉必沉弦，所以然者，伤寒太阴少阴，不必有水气，而寒气厥逆即从水气得之，肾虚于下，寒水迫于上，因病腹满，阳气不达四肢，乃一变而为厥逆，方用炮乌头二两，茯苓四两（茯苓无真者，惟浙苓为野山所产，但不出省，云南产更少）细辛一两，生半夏四两，朱砂为色，取其多，炼蜜成丸，但取其足用也，方治重在利水降逆，便可知厥逆由于水寒，即乌头细辛有回阳功用，实变足以行水而下痰，朱砂含有铁质，足以补血镇心，使水气不得上越，丸之分量不可知。如麻子大则甚小，每服三丸，日再服，夜一服者，欲其缓经留中，使得渐拔病根也，此则用丸之旨也。

腹满，脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，紧则不欲食，邪下相搏，即为寒疝，寒疝绕脐痛，若发则白津出，手足厥冷，其脉沉紧者，大乌头煎主之

大乌头煎方

乌头大者五枚熬去皮不必咀

上以水三升，煮取一升，去滓，内蜜二升，煎令水气尽，取二升，强人服七合，弱人五合，不差，明日更服，不可一日更服。

个人用附子，热者能用一钱，已为彼善于此，至于生附用至三钱，已令人咋舌，况在乌头，脱遇重证，有坐视其死耳，又其甚者，已不能用，而又禁病者之服，非惟寡识，抑双不仁，予读金匱至大乌头煎及乌头桂枝汤，为之废书三欢。乌头药力大，于附子干者小，干附子一枚合今权三钱有奇，五枚当得今权一两半，以水三升煮取一升，去滓，纳蜜二升，煎令水气尽，取二升，乌头之膏液，固已尽入于蜜，强人服七合则为三之一，弱人五合则为四之一，不差者，明日更服，何常不慎之又慎，仲师卒毅然用此者，正以危急之证，非此不能救死也。夫寒疝所由成，大率表阳不达，而阴寒内乘，阳衰于外，故恶寒而脉弦，阴乘于内，故不欲食而脉紧，表寒与里寒并居，然后绕脐急痛，发为寒疝，阴寒内迫，至于白津下泄，剥之上九几不得硕果，之孤县设非大破阴寒，此证将成不救，此予所以苦口相生，原天下有心人奉仲师为瓣香者也。

寒疝腹中痛及胁，痛里急者，当归生姜羊肉汤主之

当归生姜羊肉汤方

当归三两 生姜五两 羊肉一斤

上三味以水八升，煮取三升，温服七合，日三服，若寒多加生姜，成二斤，痛多而呕者，加橘皮二两，白术两，加生姜者亦加水五升，煮取三升，二合服之

人体血分多则生热，水分多则生寒，腹为足太阴部分，脾为统血之藏，水胜血寒，则腹痛，胁下足少阴部分，肾为寒水之藏，水气太盛，则胁痛而里急，当归生姜羊肉汤，当归羊肉以补血，生姜以散寒而其痛自止，虚寒甚者，可于方加生附子一枚，不但如仲师方后所载痛多而呕者加橘皮，白术已也，（此为妇科温经补血良剂，另详）

寒疝腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺诸药不能治，抵当乌头桂枝汤主之

抵当乌头桂枝汤方

乌头五枚

上一味，以蜜二升煎，减半去滓，以桂枝汤五合解之

令得一升后，初服五合，不知即服三合，又不知，复加至五合，其知者，如醉状，

得吐者为中病。

腹痛逆冷，手足不仁，身疼痛，视大乌头煎一证，似为稍缓，按伤寒论，凡身疼痛而无里证者，用麻黄汤以解表，兼里证而欲使之外达者，则用桂枝汤以解肌，乌头桂枝汤用乌头煎以回里阳，复加桂枝汤以救表阳，以蜜二升煎减半煮，煎去蜜之半而止，复减其半，而取桂枝汤之半数相加，合得一升而又仅服五合，不知更服三合，又不知，更服五合，岂不慎之又慎，最后却云其知者如醉状，得吐者为中病，此非亲验者不能言，尽乌头性同附子，麻醉甚于附子，服后遍身麻木，欲言不得，欲坐不得，欲卧不得，胸中跳荡不宁，神智沉冥，如中酒状顷之，寒痰从口一涌而出，胸膈便舒，手足温而身痛止矣，服生附子者，往往有此见象，予与长妇昭华，俱以亲试而识之，但昭华因痰饮服之，则呕痰而愈，予以寒利服之，则大泄而愈，要其为麻醉则一也

其脉数为阳热，为气，紧弦为阴寒，为水，惟其独阴无阳，故脉如弓弦，按之不移者，言其紧张，搏指，尽虽有歧出之脉，要当以弦脉为准，此正如航海南针，随所往而不迷所向，故无论脉弦而数，脉紧大而迟，脉大而紧，皆当以温药下之，而浮阳之数与大，俱可不问矣，仲师但言当下其寒，心中坚，阳中有阴，未出方治，陈修园以为即大黄附子汤，殆不诬也。

问曰，人病有宿食，何以别之，师曰，寸口脉浮而大，按之反啬，尺中亦微而啬，故知有宿食，大承气汤主之，脉数而滑者实也，此有宿食，下之愈，宜大承气汤。下利不欲食者，此有宿食，当下之宜大承气汤（大承气汤方，见伤寒阳明篇，又见痉病）

予每见脉滑数及下利不欲食者，既莫不以大承气汤为主治之方矣，此脉证之易知也，凡人胸腹上下有凝滞之处，其脉必滑，是故湿痰多者其脉滑，妊娠者其脉滑中有所阻，而气反有余也，下利不欲食，其人必不渴饮，阙上痛不寐，或心痞闷及腹痛，拒按诸证，惟寸口浮大，按之反啬，尺中微而啬者，最为难辨，尽浊阴不降，阳气不宣，故脉啬，寸口脉大者，肺与大肠为表里，腑气不通，肺中吸入之气格而不受，故寸口独大，此可见吸引必促啬者，凝滞之象，按之反啬，即可见腑滞不行，合之尺中之微而啬，益可决为当下之证矣。按伤寒阳明篇有谵语，潮热，脉滑疾服小承气汤，不转矢气，脉反微啬者为难治，彼惟不见浮大，而但见微啬，故为里虚，此则寸口浮大，气不下达，故知为宿食也，宿食在上脘，当吐之，宜瓜蒂散（瓜蒂散方，瓜蒂一分熬黄，赤小豆二分蒸，上二味杵为散，以香豉七合煮取汁，各散一钱匕，温服之，不吐者少加之，以挟吐为度而止）宿食在上脘，其气痞闷而不通，下不入于小肠，留积中脘，梗塞而不能下，非引而越之，使之倾吐而出，则胃气不降而新杀不纳，故宜瓜蒂散以吐之，尽此证必有寒痰，故伤寒论谓之胸有寒，可见宿食所以留积上脘者，为湿痰所格故也。

脉紧如转索无常者，宿食也

脉紧，头痛风寒，腹中有宿食不化也

宿食而见啬脉，已不易辨，至于紧脉，则尤在疑似之间，紧为表寒，惟表寒之紧，按之益紧，惟宿食之脉，则如转索无常，忽悬忽紧，亦有因外感风寒而停食者，其脉亦冯，其头必痛，此头痛为矢气上冲，一经下后，当得微汗，头痛止而风寒亦散矣，此予在苏垣亲验之。

五藏风寒积聚病脉证并治第十一

肺中风者，口燥而喘，身运而重，冒而肿胀

内经方肺风之状有三，一曰多汗恶风，即太阳中风证，象杂病亦有之，尽即痙湿蝎篇所谓脉浮身重汗出恶风之防己黄芪汤证，汗欲泄而风从毛孔相薄，故恶风，风出于毛，湿留于肌，故身重在表，故脉浮，可见内经言汗出恶风，即本篇身运而重之证，身运者风动于外，头目眩转，坐立不定之象也。二曰时咳，此即咳嗽上气篇所谓风舍于肺，其人则咳，上气顺而燥，欲作风水发其汗即愈之证也，可见内经所谓时咳，即本篇口燥而喘之证，风薄于外，故燥，湿藏于内故喘也。三曰身疼暮甚，此即身疼发热日晡所剧之麻黄杏仁薏苡甘草汤证也，夫此不治，表阳日痹，寒水陷于皮中，乃变为一身悉肿之风水，而为越婢汤证，甚则为久咳苦冒之支饮证，可见内经言身疼暮甚为本篇冒而肿胀之积渐水气停蓄，故肿胀，卫气上逆，故冒也，合参之而其义始仅也。

肺中寒，吐浊涕

寒从皮毛入，即内应于肺，太阳寒水为之不行，气闭热变，乃吐浊涕，表寒不散，即里热不清，发其汗即愈，若不知病源而漫为清燥矢之远矣。

肺死脉浮之虚，按之弱如葱叶，下无根者死

肺脉之绝也，内经谓之但毛无胃，此云浮之虚，按之弱如葱叶，下无根者死，尽浮按即轻如风絮，软若游丝，稍重似有沉取，则无之脉也，得此脉者，其气不续，故主死，按肺死藏之藏字，当为脉字之误，诸家解为真藏，脉文义不通，特更正之。

肝中风者，头目润，两胁痛，行常伛，两臂不举，舌本燥，善太息，令人嗜甘（此条两臂不举三句，在后条今订正之）肝为藏血之藏，而主一身之筋，即所谓中风者，亦血虚生风之类，非比肺藏外应皮毛，真有外风袭之也。肝藏血虚，则风动于上而头目润，此证仲师无方治，当用熟地以补血，潞参以补气，重有龙骨牡蛎以镇之，其效至速，万不可疏风破气，润甚者目中房舍林木旋转不已，往往途中顷仆，至于两胁痛，行常伛，则血弱气尽，邪正相搏，结于胁下之小柴胡汤证也，肝藏血足则柔，风胜则燥，燥气薄于脾藏，则腹痛食甘稍缓，故令人嗜甘，此先予小建中汤，不差者与小柴胡汤之证也，按后节两臂不举三语，亦为肝中风，列于肝中寒下实，为传写之误，风燥而血不养筋，故两臂不举，血虚于下，风胜于上，故舌本燥（内经肝中于风，嗑干）风胜而气变，故善太息，此理甚明，特订正之。

肝中寒者，胸中痛，不得转侧，食则吐而汗出也

肝中寒之证有三，曰胸中痛，曰不得转侧，曰食则吐而汗出，胸中痛有二证，一为水寒血腐，疣厥，亦有如后文所云胸常气痞，按之小愈之旋覆花汤证，谓之肝著，肝胆之气，主疏泄营卫二气，太阳寒水与太阴寒湿并居，则肝胆不得疏泄，故凝滞胸膈作痛，不得转侧亦有二，一为寒阻胸膈，阳气不通，水道阻于下焦，痛达胁下，不得转侧，为胸胁苦满，往来寒热，或胁下痞鞭之小柴胡汤证，亦有脾藏蕴湿，寒湿凝闭肌腠者，则为一身尽重不可转侧之柴胡加龙骨牡蛎汤证，肝胆与胃同部，胃底原不消食之胆汁，肝中寒，则胃中亦寒，故食即吐酸而汗出，此即呕而胸满之吴茱萸汤证，阳明病之不能食为胃中虚冷，亦正以肝藏困于寒湿，消食之胆汁少也，肝死脉浮之弱，按之如索不来，或曲如蛇行者死，肝脉之绝也，内经但言，但弦无胃，此云浮之弱，谓浮取之无力也，重按之则如绳索之弦急，忽然中止，则弦而见代脉矣，曲如蛇行即痉证，发其汗，脉如蛇之证，尽筋脉以燥而强急也。

肝著其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热，旋覆花汤主之

旋覆花汤方

旋覆花三两即金沸草 葱十四茎 新绛少许

上三味，以水三升，煮取一升，顿服

肝著之病，胸中气机阻塞，以手按其胸则稍舒，此肝乘肺之证也，胸中阳气不舒，故未病时当引热以自救，旋覆花汤方用葱十四茎，以通阳而和肝，旋覆花三两以助肺，新绛以通络而肝著愈矣。

心中风者，翕翕发热，不能起，心中饥食即呕吐，风邪入藏，舌即难言，口吐涎，中风篇既言之，乃又有翕翕发热不能起心中饥食，即呕吐之证，与前证是一是二，前人未有言及此者，此大可疑也，按此为风邪袭肺，吸动心阳之证，心阳随卫气外泄，故翕翕发热，热伤气，故无气以动而卧不能起，心营虚，故嘈杂似饥，胃底胆汁为风阳吸而上逆，故食入即呕吐，风一日不去，则心阳一日不定，胃气一日不和，是当用黄芪防风以泄风，甘草大黄以降逆，不必治风而风自愈，若漫用羚羊以熄风，犀角以凉心则失之矣。

心中寒者，其人苦病，心如瞰蒜状，剧者心痛澈背，背痛澈心，譬如虫注其脉浮者，自吐乃愈。

此乌头赤石脂丸证，说详胸痹篇不赘。

心伤者，其人劳倦，即头面赤而下重，民中痛而自烦，发热，当脐跳，其脉弦，此为心藏伤所致也。

此营虚证也，营虚则虚阳浮于上而头面赤，浊阴滞于下，浮阳伏之，则为下得者，大便欲行而气滞也，此证当便脓血，但证由劳倦淹见，即属虚寒。当用桃花汤经温中去湿，或用四逆理中，而非实热之白头翁汤证，阳气浮于上，则心中热痛，自烦发热，浮阳吸肾邪上僭，则当脐跳动，此与发汗后欲作奔豚同，脉弦者，阴寒上僭之脉也，此尽心阳虚而卫气上冒之证，故曰为心藏所伤，法当用桂枝以扶心阳，甘草、大枣以培中气，桂枝加桂汤，茯苓桂枝甘草大枣汤，正不妨随证酌用也。

心死脉浮之实，如麻豆，按之益躁疾者死。

心脉之绝内经云，但钩无胃，谓如带钩之坚守，数急而不见柔和也，此云浮之实，如麻豆，即以坚实言之，按之益躁疾，即以数急而不见柔和言之也。

邪哭，使魂魄不安者，血气少也，血气少者属于心，心气虚者，其人则畏，合目欲眠，梦远行而精神离散。

魂魄妄行，阴气衰者为颠，阳气衰者为狂

邪哭，当从黄坤载作邪入，陈修园谓如邪所愚而哭，此望文生训之过也，表邪乘里，必从其虚气少则卫虚血少，则营虚，营卫两虚，则外邪从皮毛肌腠而入，一日使人魂魄不安者，不过言梦寐之不安，原不指肝肺二藏言之心为主，血之藏而主脉营气之环周应之，故血气少者属于心，心气虚，则中馁，故善畏，神魂不宁，故合目即梦远行而精神离散，魂魄妄行，譬之釜下薪火，将灭烟胜而烟飞，将一散而不要收也，此证正虚为重，外邪为轻，治此者朱砂以镇之，枣仁以敛之，熟地潞参当归以补之，而又加远志以化痰，半夏以降逆，秫米以和胃，或者十活四五，否则积之既久，虽不即死，为癫、为狂将成痼疾矣（太阴无阳气，则脾藏聚湿成疾，痰蒙心窍是为癫，阳明无阴气，则肠胃积燥生热，热犯心包是为狂）

脾中风，翕翕发热，形如醉人，腹中烦重，皮目润润而短气，始病尽即伤寒太阳篇系在太阴之证也，翕翕发热，形如醉人，此即太阳篇翕翕发热，鼻鸣干呕之桂枝汤证，腹为足太阴部分，风中脾藏，里湿应之，风湿相搏，故腹中烦重，风淫于上，吸水湿上行，肺气为之阻塞，故皮目润润而短气，此证湿邪不流关节而入于里，轻则为风湿，重则为风水，风邪吸于上，则湿邪壅于腹部而不行，非去其上之所吸，则下部之壅湿不去，寓意越婢加术汤亦可用也。

脾死脉,浮之大坚，按之如覆杯洁洁状如摇者死

脾脉之绝，内经言但代无胃，而不举其形状，此言浮之坚，按之如覆杯洁洁，即但代无胃之的解也，浮取似实，重按绝无，或如杯中酒空，覆之绝无涓滴，或忽然上出鱼际，忽然下入尺部，初如摇荡不宁，继乃卒然中绝，后人所谓雀啄脉也。

趺阳脉浮而耑，浮则胃气强，耑则小便数，浮耑相搏，大便则坚，其脾为约，麻仁丸主之（麻仁丸方，麻仁二升，芍药半斤，大黄去皮一斤，枳实半斤，厚朴一斤去皮，杏仁一升去皮尖熬别作脂，上六味，末之炼蜜和丸，桐子大，饮服十丸，日三服，渐加以知为度）

此条见伤寒阳明篇，趺阳脉在足背为胃脉之根，浮则胃气上盛，耑则阴液下消，胃热盛而小便数，乃见浮耑相搏之脉，搏之为言合也（搏，合也，义如搏沙为人之搏，书合两为一也，今本皆误搏，搏之为言掣也，义如搏而躡之之搏，按之交叉，殊不可通，今订正之）胃液日涸，遂成脾约，此脾约麻仁丸方治，所以为阳明证也。

肾著之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦，身劳汗出，衣里冷淫，久久得之，腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘草苓术汤主之

甘草干姜茯苓白术汤方（一名肾著汤）

甘草、白术各二两 干姜、茯苓各四两

上四味，以水五升，煮取三升，分温三服，腰中即温

由肾达膀胱，为水道所自出，古人谓之下焦，西医谓之输尿管，故有谓三焦有名无形者，不特与内经不符，求之仲师意旨，亦然未合，此可见汉以后医家无通才也，即以肾著一证言之，仲师言其人身体重，腰中冷，如坐水中，反不渴，小便利，饮食如故，病属下焦，身体重，为水湿泛滥渗入肌肉，肌肉著湿，故体重，腰中冷，如坐水中，形如水肿，则寒湿壅阻，寒水之藏也，水气阻于腰下，则津不上承而当渴，小便当不利而反见口中不渴，小便自利，里藏无阳热，则小便色白，不言可知，日饮食如故，病在下焦者，明其病在水道，原其得病之始，则以身劳汗出，里衣冷湿，久久得之，尽上焦在胸中，西医谓之淋巴腺，为发抒气水作汗之枢机，汗出而里衣沾渍，则毛孔闭塞，而水气内积，下注寒水之藏，则腰以下冷痛，水道难通于下，而水之上源不能化气外出，则积日并僭于下，输尿管不能相容，水乃溢入腹部与湿并居，故黏滞不利而腹重如带五千钱，师主以甘草干姜茯苓白术汤者，作用只在温脾去湿，尽以腹为足太阴部分，腹部之寒湿去，不待生附走水，而腰部当温也。

肾死脉之坚，按之乱如转丸，益下入尺中者死

肾脉之绝，内经云但石无胃，此云浮之坚，坚者实也，曰按之乱如转丸，益下入尺中，是躁疾坚硬，动至尺后而无柔和之象也。问曰，上焦寒，善噫，何谓也，师曰，上焦受中焦气，未和不能消杀，故能噫耳，下焦寒即遗溺失便，其气不和，不能

自禁，制不须治久则愈。

此节发端，原有三焦竭部四字，当是编书旧标目，传抄者误入正文耳，但竭字亦不可解，上焦在胸中为发抒水气之统枢，上焦竭，则淋巴斡乳糜不足，胸中当热，不当云善噫，下焦水道涸，则大便当硬，不当云遗溺失便，经下节三焦热观之，竭字当为寒字之误，尽寒入胸中，胃底淬藏吸收小肠水液为上焦，寒气所压，不能发抒而留于中脘，胃寒不能消杀，故善噫，噫者，气从咽中出，哑哑有声，时兼有食臭，之谓下焦合肾与膀胱，下焦水寒，即遗溺失便不能自禁，此证正需四逆理中，然则仲师所谓不须治久则愈者，亦谓不须治上下二焦，非谓不治中焦也，善读书当自悟之。

师曰，热在上焦者因咳为肺痿，热在中焦者，则为坚，热在下焦者则尿血，亦令淋闷不通，大肠有寒者，多鹜溏，有热者便肠垢，小肠有寒者，其人下重便血，有热者必痔。

胸中发抒水液之枢，不能自行发热，所谓上焦热者，要为大肠燥实而移热于肺，此所以因咳为肺痿也，故澡痿独取阳明热在中焦，中焦为脾与腑吸收水液之处，水液为胃热所夺，自汗过多，则胃以燥而便难，下焦由肾接膀胱，膀胱两旁为血海，热入胸中则尿血，热留精管，败精阻之，则淋闷不通，大肠寒则便溏，热伤血络，则便脓血，然亦有水寒血败，而便脓血者，桃核承气汤证，正不当与桃花汤证同治也，小肠之端为十二指肠，胆汁最燥，胆汁不足，则小肠寒而下重，便血，先言下重，后言便血，此即先便后血之黄土汤证也。

小肠有热，则湿热注于大肠，壅阻肛门，乃病痔疮，此证唯枯痔散最神效，方用白砒煅尽白烟，研末一钱，枯凡二钱，乌梅炭研末一钱，朱砂三分和研，手指蘸药敷痔头，然之，一日二次，五六日出臭水，水尽痔枯，重者不过半月，可以全愈。

问曰病者积有聚，有杀气，何谓也，师曰，积者，藏病也，终不移聚者，腑病也，发作有时，展转痛移，为可治，杀气者胁下痛，按之则愈，复发为杀气。

腹中阻滞之病，大概有三，积为藏病云者，心积伏梁，肾积奔豚，肝积肥气，肺积息贲，脾积痞，气是也。然师以为终不移，似不可以概奔豚，奔豚之病，有痞块从少腹上冲心下，但痛定后仍在少腹，是终不移也，然奔豚一证，得自惊恐，要为肝肾两经病，正不当以肾积名之，心下之伏梁为予所亲见。至如中脘之痞气，左胁之肥气，在胁之息贲，皆未寓目，大抵久留不去之病，必非可以急攻者，加味平胃散，至为平稳（苍术、陈皮、厚朴、甘草、扁豆、小麦炒、大麦芽、川芎各五钱，沉香、木香各一钱，大黄二两）每服药末三钱，尽汤送下，须于黄昏时不进晚餐服之，明早大便，必见恶物，一月可愈，一切加减法，在陈修园时方妙用中，聚有血，有痰，有水，一时凝闭不通，则聚而为痞，发则展转痛移，痰则痛在心下，

血则痛达少腹，随其实而泻之，则其病易愈，故曰可治杀气为食滞，食滞者当在脐下，此云胁下痛者，误也，按之则小愈，更发则仍痛，此证服饭灰即愈，陈修园不知馨为杀字之误，乃以为馨香之馨，亦可笑已。

诸积大法，脉来细而附骨者乃积也，寸口积在胸中，微出寸口积在喉中，关上积在脐旁，上关上积在心下，微下关积在少腹，尺中积在气卫，脉出左积在左，脉出右积在右，两出积在中央，各以其部处之。

积为阴寒之证，故脉细而沉，曰在寸口，积在胸中者则寸口脉沉迟之胸痹证也，曰微出寸口积在喉中者，则妇人咽中如炙，衡之半夏厚朴汤证也，曰关上积在脐旁者，则绕脐痛，脉沉紧之寒疝证也，曰上关上积在心下者，则心积伏梁之证也。曰微下关积在少腹者，自非肾积奔豚证，即瘀血在少腹不去也，曰尺中积在气卫者则妇人经候不匀，气卫急痛之证也，曰脉出左积在左，脉出右积在右，脉两出积在中央者，谓所病部分不同，而脉之部分处之，即内经上附上中附中下附下之义也。

痰饮咳嗽病脉证治第十二

问曰，夫饮有四，何谓也，师曰，有痰饮，有悬饮，有溢饮，有支饮。

问曰，四饮何以为异，师曰，其人素盛，今瘦，水走肠间，漉漉有声，谓之痰饮，饮后水流在脐下，咳唾引痛，谓之悬饮，饮有水流行归于四肢，当汗出而不汗出，身体重，谓之溢饮，咳逆倚息，不得卧，其形如肿，谓之支饮。

首节先辨四饮之名，次节进求四饮之义，水与津液并居，则为痰饮，痰粘肠膈，水湿流入痰囊，倒悬肠间，则为悬饮，水溢四肢，则为溢饮，水痰为卫气上激支撑胸膈则为支饮，是为四饮定名，夫所谓痰饮者，太阳寒水，失于开泄，外不达于皮毛，内不行于下焦，于是留积成痰，人体水分与血分平均则盛，水气不达于皮毛肌腠，血肉中水分不充则瘦，故病痰饮者，往往系盛而今瘦，水痰下注大肠，则漉漉有声，此肺病延入大肠之证也，所谓悬饮者，水至中焦，阳气不足，不能直达下焦，于是结于胁下而病支满，咳则痛引胸胁，此下焦不通之证也，所谓溢饮者表汗不泄，与太阴之湿混杂，即身体为之疼重者，脾阳不运，肌肉为水气所痹也，水流四肢，则四肢肿，谓水从中道外溢也。所谓支饮者，卫气从下上逆，支撑无已，故咳逆倚息不得卧，表里水气壅塞，故形如肿，此则四饮之义也。

水在心，心下坚紧，硬短气，恶水不欲饮，水在肺，吐涎沫，欲饮水，水在脾，少气身重，水在肝，胁下支满，噎而痛，水在肾，心下悸。

心为君主之官，居清阳之位，诸藏可以有水，而心藏不当有水，所谓水在心者，直以水气凌心言之，水气不能作汗外泄，内陷中脘，则心下坚硬而短气，恶水不欲饮者，心阳被遏而中气寒也，肺主皮毛，卫气充则太阳寒水，外泄皮毛而为汗，卫气虚，则太阳之气留于胸中为水，胸中阳气蒸化乃一变而成似痰非痰之涎沫，吐之不已，津液日耗，乃欲饮水，水入不化，涎沫益多，脾主一身肌肉，而为湿藏，水湿混杂，伤及中气，故少气而身重，肝脉布胁，胁水在胁下，故曰水在肝，太阳之脉夹脊抵腰中，与三焦水道并行，中焦水道瘀积，则胁下支满，胁下为寒水之藏，水道痞结，故噎而痛，其实病不在肝也，肾水上泛，水气凌心，故心下悸，是谓五藏饮。

夫心下有留饮，其人背寒，冷如掌大，留饮者，胁下痛引缺盆，咳嗽则辄已，胸中留饮，其人短气而渴，四肢历节痛，脉沉者有留饮。留饮之来源不同，证情则往往相类，阳气痹于外，则水邪停于里，此其握要之区，不可不察也，大抵病之所由成，莫不起于形，寒饮冷，形寒者当发汗，汗出太过，内藏燥实，是病阳明，汗出不澈，即为留饮，饮冷者，中气先病，水陷于胃与大肠，转为濡泻，是病太阴，水气停蓄上膈，亦为留饮，以手入冷水浣濯，亦多病此，为其阳气痹也，以上二端，病根皆中于太阳，太阳阳气微，则汗溺俱少，始则水停心下，当胃之上口，久留不去

，寒气遏其心阳，甚则为心痛澈背，背痛澈心之乌头赤石脂丸证，轻则背冷如掌大，而为小青龙汤证，夫饮入于胃之水液，由脾阳从小肠吸收（此脾藏，西医谓之淬，胰液所出）上输胸中是为中焦，由胸中散布皮毛是为上焦（二焦皆上行，散布不尽之水液，还入内藏，伤寒所谓津液还入胃中）由肾走膀胱，是为下焦，下焦不通，则留积胁下，水停腰部，而痛引缺盆（缺盆，俗名琵琶骨，在肩骨齐颈处）咳嗽则痛不可忍，故欲咳而辄，短气，水在胸中，津液不得上承，故渴（必喜热饮）水不循三焦，故道下行，乃流溢四肢，而历节痛，此为当发汗之溢饮证，于麻黄加术为宜，水寒不得阳热之化，其脉沉弦，故曰脉沉者，有留饮，若脉不见沉而浮，则犹为风湿证耳。

膈上病，痰满，喘咳吐发则寒热背痛，腰疼，目泣自出，其人振振身润剧，心有伏饮。

伏饮之证，以痰满喘咳为见端，一触外寒，即突然呕吐涎沫，寒热交作，背痛腰疼，呕吐剧时，目泪并出，全身润动，所以见寒热者，伏饮本起于太阳，加以新寒，则太阳标本同病，太阳之脉在背，夹脊抵腰，以呕吐牵动经脉，故疼痛，气并于头，故目泣自出，阳衰气弱，故全身振振润动，今之医家，动以润动为肝风，殆不然也（按此证仲师不出方治，似真武汤加五味干姜细辛，未知然否）

夫病人饮水多，必暴喘满，凡食少饮多，水停心下，甚者则悸，微者短气，脉双弦者，寒也，皆大下后，里虚，脉偏弦者，饮也，但中阳本虚，饮水过多，未易消解，于是停积心下，卒然而病喘满，此不惟病人为然，凡胃气素虚者，皆是水在心下，甚则目眩而心悸，譬之履危崖而俯百尺之深渊，即懔然，而忧惕其或未甚，肺中吸入之气，亦必因有所格而见促，譬之当炎暑而处无风之密室，必变然而不怡惟见象，如此尤当辨之于脉，脉双弦为寒，即为大下后里虚，附子理中汤证，偏弦为饮，为小青龙及苓甘五味姜辛半夏汤证，但此节特举崖略言之，当见纳杀少而饮酒多者，往往病此，尽酒标热而本寒，酒性一过，悉成寒水，故病停饮，又有身弱多眠者，亦往往病此，尽卧者，阳气停太阳之气内伏，必聚而为湿，久久成痰，亦病停饮，固知治病者当观其通，幸无泥仲师之言而不为隅反也。

肺饮不弦，但苦喘短气，支饮亦喘而不能卧加短气，其脉平也。

肺饮支饮，一在胸中，一在膈间，心下留饮在胸，未及中下二焦，故曰肺饮，上有湿痰之凝互，下有太阳标热之支撑，故曰支饮，惟仲师俱谓其脉不弦，所以不弦之故，前人未有议及之者，陈修园黄坤载并谓金能制木，此术家之言，非必为仲师意也。尽肺为水之上源，水气积而不降，但见吸入气短，寒湿犹未甚也，肾藏虚寒，寒水上逆，乃见弦脉，肺饮在上而不在下，故其脉不弦，此苓桂术甘汤及肾气丸之证，但利小便而即愈者也，而支饮胸胁支满视此矣，凡支饮眩冒之宜，泽泻呕吐不渴之宜小半夏汤，卒呕吐，膈间有水，眩悸者，宜小半夏加茯苓汤，一切导水下行

者视此矣，尽二证初起，皆在阳位，未涉阴寒，故其脉不弦者，特为始病而言，未可据为成例，若执此而求之，则后文咳家脉弦为有水，十枣汤矣，设谓支饮不涉阴寒，则后文之咳而胸满者，与冒而呕者，不当用苓甘五味姜辛汤及苓甘五味姜辛半夏汤矣，要知凡饮皆始于肺，以失治而寢成支饮，支饮失治，由胸下胁，转为悬饮，胁下固厥阴脉络所在，而实为少阴之藏，水道出焉，水结胁下，肾藏乃寒，下焦寒甚，生附子亦当加入，然后欢仲师温药和之之训，为大有深意也，独怪今日市医，遇当用姜辛之证不过五六分而止，曾亦念烧薰条之无以洁水而宣防之功不立乎。

病痰饮者，当以温药和之

近日市医，动以不凉不热为温药，是不然，仲师云，病痰饮者，当以温药和之，究为何等药味，此不可不辨也，据本篇云，加干姜细辛以治咳满，又云，细辛干姜为热药，服之当遂渴，渴反止者，支饮也，可知此节所谓温药，即后文所谓热药，又按太阳篇真武汤后所列加减法，咳者加五味细辛干姜，益可信温药之为细辛干姜矣。

心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之（苓桂术甘汤方，茯苓、桂枝、白术各三两，甘草二两，上四味以水六升，煮取一三升，分温三服，小便则利）

夫短气有微饮，当从小便去之，苓桂术甘汤主之，肾气丸亦主之（肾气丸方见妇人杂病）

此二节为支饮，脉平，肺饮，不弦者，出其方治也，夫胸胁支满，属手少阳三焦，三焦水道不通，乃病支饮，目眩者，水饮上冒而眩暈不定也，起于心下由胸达胁，卫气上逆，喘不能卧，故曰支饮，下焦水道不通，肺藏吸入之气不能顺受而痛短气，故曰肺饮，仲师所出方治，皆用苓桂术甘汤者，则以饮邪初起，水气仅在三焦而不及水藏，故但扶脾藏以通阳气，使上焦气散，无吸水之力而水道自通，水道通而饮邪去矣，但苦短气之肺饮亦主以肾气丸者，或病在寒水之藏，不能纳气，如妇人杂病篇不得卧而反倚息之证，故同一利小便而方治固自不同也（按此二方，但可治痰饮之初病，若饮邪既盛，往往失效）

病者脉估，其人欲自利，利反快，虽利心下续坚满，此为留饮欲去故也，甘遂半夏汤主之

甘遂半夏汤方

甘遂(大者三枚，)半夏(十二枚以水一升煮取半升去滓，)芍药(五枚，)甘草(如指大一枚矣。)

上四味以水二升，煮取半升，去渣，以蜜半升，和药汁煎取八合，顿服之

卒病宿疾之不同，一辨于脉，一辨于证，如本条所云其人欲自利，利反快，此为留饮欲去，其与紧在太阴之暴烦下利，日十余行，脾家实，腐积当去者何异，然何以下利之太阴证，不治而自止。何以虽利而心下续坚满，且太阴自利之证，其脉浮缓，此证何以脉伏，要不可不辨也，尽湿本黏滞之物，太阳寒水与太阴寒湿并居，虽为痰饮所同，而太阳伤寒，内传太阴为日未久，其病根浅，故脉见浮缓，痰饮之病，以积日而后成，其病根深，故其脉见伏，伏之言沉也，病根浅者，但见下利，水湿已并入大肠，故不治而自愈，病根深者，当下利而水湿之留于膈上者，复僭心下，故心下续见坚满，而必待甘遂半夏汤以因势而利导之，方中甘遂三枚，半夏十二枚，炙甘草一枚，所以疏通血络而起沉伏之脉，尽脉浮者，水胜而血负也，药去滓而蜜者，欲其缓以留中，使药力无微不达，并取其润下之性，使内藏积垢易去也，此甘遂半夏汤之义也（陈修园谓甘遂与甘草相反，所以同用者，欲其交战于胃中，使病根剧除，未确）

脉浮而细滑，伤饮，脉弦数有寒饮，冬夏难治，脉沉而弦者，悬饮内痛，病悬饮者，十枣汤主之（十枣汤方，芫花熬，甘遂、大戟各等分，上三味，捣筛，以水一升五合，先煮肥大枣十枚，取八合，去滓，纳药末，强人服一钱匕，羸人服半钱匕，平旦温服之，不下者，明日更加半钱匕，得快利后，糜粥自养）

此节发明悬饮之积，渐欲学者明辨而施治也，其始由太阳传入太阴，故脉浮而并见细滑，滑者湿象也，太阳失表，汗液不泄，水气乃内陷胸膈，与湿并居，即为伤饮，水邪不去，由胸及齐，乃见弦胀，是为寒饮，饮邪内陷，阳气蛰伏，脉转弦数。寒饮则须温药，伏热尤须凉剂，二者不可兼故，冬夏难治，若夫脉沉而弦，沉则为水，弦则为痛，故悬饮而内痛，悬饮者，痰囊系于内藏，水饮蓄焉，故非破囊挾水，病必不愈此芫花甘遂大戟所以为救死之方治也。

病溢饮者当发其汗，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之（大青龙汤方，麻黄六两，桂枝、甘草各二两，生姜三两，杏仁四十个，大枣十二枚，石膏如雉子大一枚，上七味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗，沔多者，温粉扑之，小青龙汤方，麻黄去节，芍药，干姜，甘草炙，细辛、桂枝各三两，五味子、半夏各半升，上八味，以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

溢饮一证，以水气旁溢四肢而作识其病之所从来，便可知病之所由去，所谓解铃须问系铃人也，尽肺主皮毛，肺藏呼吸，即周身毛孔为之张弛，殆有登高一呼，群山皆应之之意，皮毛闭塞于外，即内藏之呼吸不灵，发为喘咳，皮毛一日不从汗解，即咳逆一日不平，水气流溢于四肢者，一日不去，此病溢饮者，所以宜大小青龙汤也，但大青龙汤方治，为表汗里热而设，即安在，尽脾主四肢，胃亦主四肢，中脘

有热，逼内藏之水旁溢四肢者，故主以大青龙汤，水饮太甚，内藏不能相容，自行流溢四肢者，故主以小青龙汤，要其为发汗则一也。

膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黎黑，其脉沉紧。得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之，虚者即愈，实者三日，复发，与不愈者宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之

木防己汤方

木防己、桂枝各三两，人参四两，石膏如雉子大二枚一本十二枚

上四味，以水六升，煮取二升，分温再服

木防己去石膏加茯苓芒硝汤方

木防己、桂枝各三两，茯苓四两，人参四两，芒硝三合

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，内芒硝，再微煎，分温再服，微利则愈。

饮邪留于膈间，支撑无已，肺气伤于水，太阳阳气不得外达，则喘，胸中阳痹，水液内停则满，由胸及于心下，则心下痞坚，寒湿在上，阻遏三阳之络，血色不荣于面，故其色黎黑，此与湿家身色如薰黄同，水盛于上，血分热度愈低，故其脉沉紧，得之数十日，病根渐深，医以为水在上也，而用瓜蒂散以吐之，吐之不愈，又民心下痞坚，而用泻心汤以下之，若仍不愈，医者之术穷也，不知寒湿久留，则生里热，胃热合胆火上抗，因病喘逆，饮邪留积不去，则上满而下痞坚，故宜苦寒之防己以泄下焦，甘寒体重之石膏以清胃热，又以心阳之不达也，用桂枝以通之，以津液之伤于吐下也，用人参以益之，此仲师用木防己汤意也，但此证，胃中无宿垢，但有胃热上冲，阻水饮下行之路而喘满痞坚者为虚，故但于方剂中用石膏以清胃热，中脘已无阻疑，尽即阳明虚热用白虎汤之义也，若胃中有宿垢，虽经石膏清热，上卫之气稍平，但一经复发，此方即无效力，故必去清虚热之石膏加茯苓利水道，芒硝以通腑滞，膈间支饮乃得由胃中下走小肠，大肠而一泄无余，即阳明实热用大承气汤之义也。此虚实之辨也。

心上有支饮，其人苦冒眩，泽泻汤主之

泽泻汤方

泽泻五两 白术二两

上二味，以水二升，煮取一升，分温再服

支饮胸满者，厚朴大黄汤主之

厚朴大黄汤方

厚朴一只，大黄六两，枳实四枚

上三味，以水五升，煮取二升，分温再服

此承上加茯苓芒硝而别出其方治也，水在心下，静则为心悸，动则为冒弦，欲遏水邪之上泛为木防己汤加茯苓所不能治。泽泻汤，所以挾泛滥之水而厚其堤防也，胃中燥热，逼水上逆，则病胸满，木防己汤加芒硝所不能治，仲师因别出厚朴大黄汤方，所以破中脘之阻隔，开水饮下行之路也，支饮不得息，葶苈大枣泻肺汤主之（葶苈大枣泻肺汤方见肺壅）

肺为主气之藏，为全身呼吸出入之门户，凡肺藏有所壅阻，而全体能张而不能驰也，是故风热伤其血络，则肺藏壅塞而气闭，湿痰阻其空窍则肺藏亦寒而气闭，是非立破其壅塞，则呼吸不调，尽无论肺病之喘不得卧及本条支饮不得息，莫不以葶苈大枣泻肺汤主之，要其作用只在扶去所壅令肺气能张能驰，初无分于血分水分也。

呕家本渴者，为欲解，今反不渴，心下有支饮，故也，小半夏汤主之。

小半夏汤方

半夏一升一本五钱 生姜半斤一本四钱

上二味，以水七升，煮取一升半，分温再服

本书之例，呕而不吐者为干呕，凡言呕皆兼吐言之，故吐水及痰涎，皆谓之呕，胃底胆汁不能容水，胆汁苦燥，与膈上水气相拒，则为呕吐，少阳所以善呕也，但既呕之后，胃中转燥，因而病渴，渴则水邪已去，故为欲解，今反不渴，则以心下支饮方盛，胃底胆火不炆，故以生半夏以去水，生姜以散寒，而心下之支饮当去，此证水停心下，阻其胃之上口，势必不能纳杀，呕吐啰下利篇云，诸呕吐，杀不得下者，小半夏汤主之，即此证也。

腹满，口舌干燥，此阳间有水气，已椒苈黄丸主之

已椒苈黄丸方

防己、椒目、葶苈、大黄各一两

上四味，末之蜜丸，如梧子大，先食饮服一丸，日三服，稍增，口中有津液，渴者加芒硝半两

腹满一证，以时减为太阴虚寒，不减为阳明实热，虚寒当温，实热当泻，此其易知者也，若绕脐剧痛之寒疝，当用大乌头煎者，已易与大实满之大承气证淆混，若夫水在肠间之腹满，抑又难为辨别，师但言腹满，口舌干燥，又不言脉之何似，几令人疑为阳明燥实，要知太阳水气，不能由肺外出皮毛，留于膈间，心下，久乃与太阴之湿混杂，湿本粘腻，与水相杂，遂变水痰，肺与大肠为表里，由表入里，水痰并走肠间，因病腹满，且腹未滿之时，肠中先漉漉有声，权其巅末，即可知口舌干燥，为里寒不能化气与液，其脉必见沉弦，仲师以己椒苈黄丸者，防己椒目以行水，葶苈、大黄兼泄肺与大肠也，所以先食饭而服者，则以水邪在下部故也。

卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，小半夏加茯苓汤主之

小半夏加茯苓汤方

半夏(一)生姜(半升)茯苓(四两)

上三味，以水七升，煮取一升五合，分温再服

假令瘦人脐下有悸，吐涎沫而颠眩，此水也，五苓散主之，（五苓散方，泽泻一两六钱，茯苓、白术各十八钱，桂枝半两，上五味为末，白饮服方寸匕，日三服，多服浆水，汗出愈）

痰饮之未成者，始于水，水因寒而停，则为饮，水与膏液混杂，则为痰，水盛则痰浮，而上阻胸膈，胆胃被樊，与水冲激则卒，然呕吐痰在膈间，则心下痞痛，水气冲脑，则眩，水气凌心则悸，生半夏能去至高之水，生姜能散膈上之寒，加茯苓能决排水道，此可知仲师出小半夏加茯苓方治，正所以抑在上之水以逆而折之也（茯苓和面为造，云产固不易得，浙产亦不出省，似不如改用猪苓）语云，肥人多痰，瘦人似不当有痰，为其肌肉皮毛中所含水分少也，水分多者，心下有水，则心下悸，水分少者，水在脐下，则脐下亦悸，水气微薄，虽不至卒然呕吐，然引动上焦亦必吐涎沫而头目眩晕，此可见仲师出五苓散方治，正所以泄在下之水以顺而导之也，此上下之辨也（同一心下悸，而发汗后之欲得按者，但用桂枝甘草汤，而不更用去水之生半夏，同一脐下悸，而发汗后之欲作奔豚，惟桂枝茯苓同五苓散，而重用大枣、甘草以实脾，皆为正虚邪轻而设，故病同而方异也）又见本篇

咳家其脉弦，为有水，十枣汤主之（十枣汤方见伤寒论太阳篇）

水为至强，体柔而性刚，滴石则石穿，冲堤则堤坏，故病水者，其脉多弦，弦者沉紧而搏指也，水胜则血负，血分热度日减则蒸化力弱，而卫阳虚澈，故仲师以弦为减，谓阳气减也，但水势下越，似不应上逆为咳，不知痰湿粘滞下游，水道不通，则高原泛滥日甚，是非破东南之壅塞，则西北之泽洞无归，此十枣汤一方所以尽扶排疏沦之能也。予每见病痰饮者，大小便往往不通，此即下游壅塞之明证，所以用十枣者，一因药力猛峻，恐伤脾胃，一因痰涎未易瀚濯，用甘味之十枣以缓芫花、大戟、甘遂之力，使如针皂之去油垢，在渐渍不在冲激也。

夫有支饮家，咳烦胸中痛者，不卒死，至一百日，或一岁宜以十枣汤

水气支撑胸膈，故名支饮，此证大便不通，上湿下燥，肠胃之热上攻，则咳而心烦，痰积胸中，故胸中痛，不卒死者，谓不猝然而死也，然死机已伏，故有百日而死者，有经一载而死者，当见大小便不通，气喘不得卧，卧即咳逆不得息，叠被而倚之，此一月十五日而死者也，亦有大小便时通，发时则三五日不通，咳则目睛突出，气出不续，过即如故，但膈间留饮，愈积愈厚，愈发愈勒，此一岁而死者也，知死之所由去，即知生之所从来，尽非猛峻之十枣汤，驱水入大肠，以扶荡肠中燥气，病不必治，予先慈邪太安人病支饮，有年矣，丙寅春，忽然昏迷，若癫状，延医诊治，皆曰危在旦夕，予不得已，制十枣汤进之，夜半而利，下痰算，明旦清醒如平人矣，后至上海恽禹九家，其孙祥官，同乡张尔常门人也，本无病，尔常以其累逃塾，使予诊其脉，左脉弦，问所苦，则曰胸中痛，予曰真病也，以十枣汤方付之，明旦大下痰涎，冷甚，以为愈矣，翌日来诊，脉如故，仍令服前方，下痰更多，继以姜辛五味而愈，不更病矣，丙辰冬无锡强鸿培病（此人开饭作）人皆目为肺劳，咳而上气，胸中满痛，无大小便，叠被而倚息，喘声达户外，予诊其脉，沉伏而弦急，因令服十枣汤，每服六分，日一服，每进一服，其痛渐移而下，服至四剂，卫气乃平，又能治小儿痰饮，俗称马脾风，七日见血即死，予当治其寿至时方三岁，又治潘姓小儿，名阿煦者，皆以泻痰得愈，沉石顽自治痰饮，每服药末一钱半，两服而瘥，可见猛峻之药，益人甚于参苓也。

久咳数岁，其脉弱者可治，实大数者死，其虚者，必苦冒，其人本有支饮在胸中故也，治属饮家。

痰饮为病，有咳烦胸中痛，或百日或一岁而死者，此期日之至促者也，至于咳数岁，庶几恒不死之贞疾矣，然水性至刚，病之进退，皆当决之于脉，脉弱不弦，则内藏水气未甚，故其病可治，实大而数，则水邪充于内藏，故其病当死，至如脉由弱而虚，则水气当微，然久咳不已，引动卫气，心若变冒，所以然者，则以病人久咳，胸中原有支饮也，按此证脉虚不弦，既非十枣汤证，脉不沉紧，又非木防己汤证方治之中，惟泽泻汤为近之，尽泽泻蠲饮，而白术补虚也。

咳逆倚息，不得卧，小青龙汤主之（小青龙汤方见伤寒论太阳篇，又见本篇）

咳逆则气邮不续，倚息不得卧，则终夜叠被而倚之，不得平卧也，寒气变于表，饮邪补遏，则激而上冲，固应解表温里，俾外寒与里水双解，此小青龙汤方治，所以为蠲饮之主方也。

青龙汤下气，多唾口燥，寸脉沉尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痛，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者，与茯苓桂枝五味甘草汤，治其气卫。

苓桂五味甘草汤方

桂枝、茯苓(各四两) 五味(半升)甘草(三两炙)

上四味，以水八升，煮取三升，去滓，分温三服

阳气张于上，则卫气动于下，小青龙汤发其阳气太甚，则口多浊唾而燥，寸脉沉为有水，尺脉微为阴虚，手足厥逆者，中阳痹也，气从小腹上冲胸咽者，以麻黄细辛之开泄太甚，少阴水气，被吸而上僭也，中阳既痹，故手足不仁，虚阳上浮，故其面翕热如醉状，且浮阳之上冒也，复下流，阴股而吸其水道，致小水不利，阳不归根，故时上冒颠顶，方用苓桂五味甘草汤，与伤寒太阳篇发汗后欲作奔豚之苓桂大枣甘草汤略同，但彼为阳因汗后而虚，不能厚中道之堤妨，故用大枣，此为肾气被热药牵引，不能摄下焦之浮阳，故用五味，要其为降卫逆则一也

卫逆即低，而反更咳，胸满者，用苓桂五味甘草汤去桂加干姜细辛，以治其咳满。

苓桂五味姜辛汤方

茯苓四两 甘草、干姜三两 细辛三两 五味子半升

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三服

降卫气而卫气低则上冒之浮阳，当息，而唯心论逆可止矣，而反实咳胸满，以前方失之太轻，是不然，尽前用小青龙汤，麻黄开泄太甚，迫其汗液，而阳气暴张，小腹之客气，因而上逆，中阳既痹，始则手足厥逆，继而手足痹，甚至上下颠倒，浮阳窜乱一似电光石火，闪烁无定，此时若以温药化饮，不免助浮阳外抗，于是不得已用苓桂五味甘草汤，以收散亡之阳，尽必卫气渐低，然后可进温药，师于是有苓甘五味姜辛汤方法，以发抒胸中阳气，而除其咳满，此先标后本之治也。

咳满即止，而卫气复发者，以细辛干姜为热药也，服之当遂渴，而渴反止者，为支饮也，支饮者，法当冒，冒者必呕，呕者复内半夏以去其水。

苓甘五味姜辛半夏汤方

茯苓四两，甘草二两，细辛二两，干姜二两，半夏半升，五味半升

上六味，以水八升，煮取二升，去滓，温服半升，日三服

此节更复渴三字，为衍文，以细辛干姜为热药句，为假设之词，当属下读，非承上卫气复发言之，若承上言，似但指卫气一层，服之当遂渴句，转类节外生枝，若原不更得泻渴三字，则下文当遂渴反不渴，俱不可通矣，此节大旨，谓咳满止后，上膈气机已疏，当不复病，然亦有咳满方止，卫气复发者，倘因干姜细辛为热药而发其卫气，服后当立见燥渴，乃本病燥渴，服干姜细辛而渴反止，则前此之渴，实为支饮，隔塞在胸，津液不得上承，喉舌而初非真燥，此证予寓小北门时，治宋姓妇人亲见之，病者平时常患口燥，所服方剂，大率不外生地，石斛、麦冬、玉竹、知母、花粉、西洋参之类，予见其咳吐涎沫，脉弦而体肥，决为痰饮，授以此方，服后终日不曾饮水，略无所苦，乃知仲师渴反止为支饮之说，信而有微也（此证后以咳逆不得卧，乳中胀育，用十枣汤加王不留行，大下水痰而愈）但支饮在胸膈间，中脘阳气被遏，必见变冒，冒者，胃底胆汁不能容水，卫激而上逆也，故仲师言冒家必呕，尽中阳与支饮相拒，轻则虚阳上浮，甚则卒然呕吐清水，痰涎，可知热药实为对病，故治法特于前方中加生半夏以去水，不更忘细辛干姜也。

水去呕止，其人形肿者，加杏仁主之，其证应内麻黄，以其人遂痹，故不内之，若逆而内之者，必厥，所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。

苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤方

茯苓四两，甘草、干姜、细辛各三两，五味、半夏、杏仁各半升

上七味，以水一斗，煮取二升，去滓，温服半升，日三服

前方内半夏以去水，则心下之水气当去，水邪去，则胆胃之火不复上行，而呕亦当止，但水方止贮中脘气不外散，一旦决而去之，未尽之水气不能从表汗外泄，或转留皮毛之里，变为形肿，按之气病，一身面目黄肿者，则越婢加术汤主之，一身悉肿，则越婢汤主之，此外水气甚而形肿，药剂中应纳麻黄之证也，但此证业经半夏去水，水气不甚，则形肿当属虚胀，水气篇又云，虚胀者为气水，发其汗即已，脉沉者宜麻黄附子甘草汤，此又水气不甚而形肿者，药剂中应纳麻黄之证也，故仲师既于前方中加杏仁以利肺气而泄皮毛，复申之曰，其证应内麻黄，以其人遂痹，故不内之，若逆而内之，必厥，所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也，夫此证之应内麻黄，仲师既言之矣，但何以见此证血虚，何以见形肿之为痹，何以见麻黄发汗之必厥，历来注释家，固未有能言其意者，尽水盛则血寒，中热度既低，则吸收

力薄，精液不能贫输，脉道而络脉益虚，水病所以血虚也，痹之言闭，血分热度不足，则水气之在表者，不能蒸化成汗，故毛孔闭塞，而形肿若用麻黄，强责其汗，太阳阳气一时张发于外，则里气益寒而手足见厥，此即衄家不可发汗，疮家不可发汗，失精家不可发汗之例也。

若面热如醉，此为胃热上冲熏其面，加大黄以利之

苓甘五味加姜辛夏杏大黄汤方

茯苓四两，甘草二两，干姜、细辛各三两，五味、半夏、杏仁各半升，大黄三两

上八味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服

水去呕止，有未尽之水气，因水方外散，痹于表分而形肿者，亦有水分已尽，胃中燥热上冒头面者，于是有面热如醉之形熊，尽累进温中泄水之剂，证情决非戴阳，故于前方加杏仁，外更加大黄以利之，所以然者，则以水邪去路不出于肺，必出大肠也。

先渴后呕为水停心下，此属饮家，小半夏加茯苓汤主之（见上）心下有水，脾精不得挟胃中杀气上溉肺藏而润喉舌，因而渴饮，但胃底含有苦燥之胆汁，胃中热如炽炭，不能容水，水在胃之上口，胃热出而相抗，乃病呕吐，此其所以先渴后呕也，按此节合上呕家本渴，即并见下呕吐哕下利篇，以其治属饮家，故本条独出方治也

消渴小便不利，淋病脉证治第十三

厥阴之为病，消渴，气上冲心，心中疼热，饮而不欲食，食则吐下之不肯止。

此与伤寒厥阴篇同，予向以为非一时并见之证，此特为厥阴本病言之耳，至于消渴，是殊不然，消渴所以起于厥阴者，始于肝藏血虚，血虚则内风生，胆寄肝叶之内，赖肝液为滋养，肝燥而胆不濡，则浮火易动，风与火相搏，于是肺液耗损，引水自救，水能胜有形之火不能胜无形之风，燥于是饮者自渴，此消渴所以起于厥阴也，风阳上薄，故气上撞心，热郁心房故心中疼热，风阳上逆，故饥不欲食，风阳吸于上，胃气逆行，故食即吐，若疑为宿食，而误下之，风性疏泄，脾湿随之下陷，乃至一下而不肯止，气上冲则肺燥，屡吐，则胃燥，下之不止，则肠亦燥，此为消渴所由成，推本穷原，则但清肝热，滋营血而阳自息，此证似宜黄连阿胶汤，合百合地黄汤，陈修园谓当于乌梅丸，诸方按证求之未的。

寸口脉浮而迟，浮即为虚，迟即为劳，虚则卫气不足，劳则气竭，趺阳脉浮而数，浮即为气，数即消杀而大坚，气盛则溲数，溲数则坚，坚数相搏，即为消渴。

男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便亦一斗，肾气丸主之（见妇人杂病）今之议病者，皆以寸口脉数浮为上消，趺阳脉浮为中消，男子消渴即为下消，此不知本之言也，惟黄坤载以阳明篇为消渴之原最得主要，素问别论云，二阳结，谓之消，黄氏引而申之曰，二阳者，阳明也，手阳明主燥化，燥在大肠则消，水而便坚，足阳明亦从燥化，在胃则消杀而溲数，太阴行气于三阴，脉候于寸口，阳明行气于三阳，脉候于趺阳，太阴主升，阴中之阳升于脉络，则经气盛，阳明主降，阳中之阴降于肠胃，则腑气和，太阴虚而经气衰，故寸口浮而迟，阳明盛而府气旺，故趺阳浮而数，虚劳其营卫，为发热作渴之原，燥热耗其精液，为消杀引饮之渐，胃热渗于大肠，故大便坚，水饮并入三焦，故小便多，经气虚而腑气实，所谓壮火食气也。

此黄坤载本内经以释仲师之旨，精义不可磨减者也，北齐道与造象记，附方有顿服乌麻油一升，神验，当即此证，予按黄氏此说，言阳明之燥，关于上渴下消，则甚当矣，特以上节厥阴为病核之，上下几成两橛，爰本黄说合上节而申言之，尽胃与肝同隶中部，肝居胃右而斜覆其半体，胆寄肝叶，资血液而后充，脾藏之胰液，合胆汁渗入胃中，为消杀之助，肝藏血液不足，胃底独存苦燥之胆汁而消食之力更猛，故营卫以虚劳而损，胃中之燥热益增，胆管之下注十二指肠者亦愈热，因是上下俱燥，大便坚而小便更数，少阴病自利清血色纯青之大承气证，亦即胆胃同病，此上渴下消之由，虽在胃与大肠之燥，实出爱莫能助地阴虚而胆汁生燥也，然则首条言饥不欲食，食即吐，此云消杀，又将何说，以处之，不知首节以病之，发端言之，营卫虚于上，是病风燥，胆胃上逆，是病呕吐，仲师虽未明言，而其味必苦，肝阴愈亏，胃底胆火愈炽，乃一变而为消杀，肠胃既燥，大便尽坚水气乃独行于肾膀，而饮一溲一亡证具矣，按此证仲师方治主以肾气丸，在妇人杂病篇为利小便之药

，此证小溲甚数，更服利水之药，小溲母乃太多，曰否，此方原为调摄肾气而设，肾为水道关键，肾寒水不化气，则水势下越而小溲数，肾阳不运则气闭，气闭则小溲不通，故病以相反而同治，尽消渴一证，原为肝脾阴虚而胆胃生燥，因致消杀便坚，不比阳明燥实，故用干地黄、山茱萸，以滋养肝脾，而胆胃燥气自平，又瞿其助湿也，故用泽泻、丹皮、茯苓以泄之，方中惟桂枝、附子二味最为主要，桂枝以通脾阳，胸中淋巴幹受之，所以疏上焦之水气，附子以通肾阳，输尿管受之，所以温下焦之水，使得化气而润燥，所以然者，则以小溲之多实由水寒无气故也。

脉浮小便不利，微热，消渴，宜利小便，发汗，五苓散主之（五苓散方见伤寒论太阳篇，又见痰饮）

此条见太阳篇发汗后条下，尽因大汗之后，浮阳在表，吸下焦水气不得输泄于膀胱，但用五苓散发汗利小便，俾水道下通，津液上承，而消渴自止，此与真消渴不同，因其相似而类及之（欲发汗，服散后多饮暖水，见伤寒论）

渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之]

此条见太阳篇中风发热条下，夫渴欲饮水，固有阳明实热少，少与之而愈者，乃入口而即吐，则是水停心下，津液不生，而渴饮初非燥热，故名水逆，为下流之壅塞，此与宿食未消不能纳谷者同，故必壅其下流，津液乃得上承于喉舌，要非人参白虎竹叶石膏诸方治，所当混投也。

渴欲饮水不止者，文蛤散主之（文蛤散方，文蛤五两，上一味杵为散，以沸汤五合，和服方寸匕）

此条见太阳篇病在阳，节下而微有不同，彼以太阳标热及水气为冷水所遏，太阳寒水与标热停顿心下，意欲饮水而反不渴者出其方治，特用针寒之文蛤，标本同治，使热随水泄而渴当止，此为渴欲饮水，水入渴不止者言之，尽以水能去阳明实热，不能去太阳标热，加以屡渴，屡饮，其水必停，标热薰灼，蕴成湿痰，水更粘滞，文蛤散用蛤壳杵细，开水和服，若今日砂漏，然隔其渣滓，使水清易利，又不独针寒，清热已也。

淋之为病，小便粟状，小腹弦急，痛引脐中

仲师于淋证未出方治，但以病情而论，则此证实为虚寒，发端便日小便如粟状者，阳气不达于宗筋而精道寒也，肝肾因虚生寒，则少腹为之弦急，肾虚而寒气上乘，故痛引脐中，虽以外证验之，未常非湿热之交阻，然有服龙胆草而加剧者，亦有服木通累斤而痿顿不起者，则以里阳不达，湿热无自而化也，吾谓治淋之法，病之初起，以疏达瘀滞为急，是犹湿热下利中有宿食而宜大承气者也，病之既久，宜温中

通阳，佐以泄水，是犹下利虚寒而宜四逆理中者也，独怪近世庸工，一遇淋证务清肝热而败脾阳，吾见其冥路之日近矣。

趺阳脉数，胃中有热即消谷引饮，大便必坚，小便则数

淋之为病，或小溲肿痛，或败精瘀塞，变为癃闭，病此者多懊农欲死，坐立不安，要未见消谷引饮，大便坚而小便数者，仲师于此节即不言淋证，而其义则与趺阳脉浮而数大致略同，故予决其为衍文，若夫大肠燥，小溲赤痛，迫精外泄者，阳明证间亦有之，非淋病也。

淋家不可发汗，发汗则便血

此条见太阳篇与衄家不可发汗同，血与汗为同体，衄家发其汗，则阳气张于上而目直视，淋家发其汗则阴液损于下而便血，其不从小溲出者，经津道本塞，欲出不得故也。

小便不利者，有水气，其人若渴，栝蒌瞿麦丸主之

栝蒌瞿麦丸方

薯蓣三两，茯苓三两，栝蒌根二两，附子一枚炮，瞿麦一两

上五味，末之炼蜜丸如梧子大，饮服二丸，日三服，不知增至七八丸，以小便利腹中温为知。

天时，阳热则生湿，土膏发于地云气上于天，然后雷雨作而沟渠通，阴寒则生燥，风霜日紧，潦水不降，于是蒸气消而溪涧塞，人但知苦热易于生燥，而不知苦寒之尤易生燥也，知此意者，然后可与论栝蒌瞿麦丸方治，证曰小便不利，有水气而渴，此水胜血负，水寒不能化气之证也，三焦水道以水为关键，肾寒则水停蓄于下而阳气不升，阳气不升则肺阴亏于上，而津液不降，方用栝蒌根以润肺而止渴，瞿麦以导膀胱而利小便，薯蓣、茯苓以扶脾阳而抑心下水气，要惟以炮附子一枚为方中主要，观小便利腹中温为知八字，其义自见，尽未服药时，腹中必然冷痛也。

小便不利，蒲灰散主之，滑石白鱼散，茯苓戎盐汤并主之

蒲灰散方

蒲灰半分，滑石三分

上二味，杵为散，饮服方寸匕，日三服

滑石白鱼散方

滑石、乱发（烧、）白鱼各二分

上三味杵为散，饮服方寸匕，日三服

茯苓戎盐汤方

茯苓半斤，白术三两，戎盐弹丸一枚

上三味先将茯苓、白术煎成，入戎盐再煎，分温三服

小便不利，证情不同，治法亦异，所谓蒲灰散主之者，湿胜热变之证也，肾藏当寒水下行之卫，水胜则肾阳被遏，由输尿管下结膀胱，而小便不利，用针寒泄水之蒲灰，合淡渗清热之滑石，则水去而热亦除矣，所谓滑石白鱼散，茯苓戎盐汤并主之者，滑石白鱼散为水与血并结膀胱之方治也，水以寒而易泄，故称太阳寒水，水蓄于下与胞中血海混杂，乃生里热，热变则水道不通，故渗之以滑石佐以善导血淋之发灰，白鱼俗名寿鱼，喜蚀书藉，窜伏破书中，不见阳光，虽性味不可知，大约与土龙子鼠妇相等，善于攻瘀而行血者，尽瘀与热俱去，而小便自通矣，茯苓戎盐汤为膏淋、血淋阻塞水道通治之方也，茯苓、白术以补中而抑水，戎盐以平血热泄瘀浊而小便乃无所窒疑矣，此又小便不利兼有淋证之治也。

渴欲饮水，口干燥者，白虎加人参汤主之（白虎加人参汤方见伤寒论阳明篇，又见喝病）

脉浮，发热，渴欲饮水，小便不利，猪苓汤主之（猪苓汤方，猪苓去皮，茯苓、阿胶、滑石、泽泻各一两，上五味，以水四升，先煮四味取二升，去滓，内胶烱消，温服七合，日三服）

此二条，并见伤寒阳明篇，为汗下温针救逆之方治，阳不外越，津液内伤，因病口干舌燥，浮热在表，水湿内蕴，因病渴欲饮水，小便不利，津液伤则以清热生津主治，方治宜白虎加人参者，为其热伤气血也，里水变故以导水邪清血热主治，方治宜猪苓汤，用阿胶者，为其湿伤血分也，此卫与营之辨也。

水气病，脉证并治第十四

师曰病有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗

风水其脉自浮，外证骨节疼痛恶风，皮水其脉亦浮，外证跗肿，按之没指，不恶风，其腹如鼓，不渴当发其汗，正水其脉沉迟，外证自喘，石水其脉自沉，外证腹满不喘，黄汗其脉沉迟，身发热，胸满四肢头面肿，久不愈，必致痈脓。

水与气相为消长，水温则气生，水寒则气夺，夺则卫阳痹于外，营阴痹于里，水即顿滞而不行其病，凡四有风水，皮水，正水，石水之别，黄汗则似水非水，风水之病起于中风，中风不愈，波士顿液凝于肌理，乃病风湿，风湿不愈，水气因寒凝聚，乃病风水，故脉浮恶风，与中风同，外证骨节疼痛与风湿同，尽湿不甚者为湿，湿胜者即为水，表阳一日不达，即里气一日不和，此水气之病，由于脾阳顿滞者也，皮水之病，或起于中蝎，痙湿蝎篇所谓身热疼重，夏月伤冷水，水行皮中所致者是也，或起于伤寒，痙湿蝎篇所谓伤寒，八九日风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，大便坚，小便自利者，服桂枝附子汤去桂加术，尽三服，如冒状，术附并走皮中，逐水气未得除者是也，尽人身五气一日不绝，外来之水断不能渍入毛也，惟水饮入胃，挟胸中阳气外泄之汗液外著，冷水及寒气乃留滞于皮中，病起于太阳，故脉浮，太阳之府为膀胱，部位最下，膀胱不行水从旁溢，故其病为跗肿，皮毛外闭，故不恶风，水湿在皮里而不入大肠，故其腹如鼓，而无洞泄下利之变，水不在中脘，不能隔绝上承之液，故不渴，病在表分，故当开皮毛而发汗，此水气之病由于卫阳被遏而肺阴不达者也，正水之病起于寒水之府藏，其证为下焦虚寒，寒水停蓄，水气胜而血热微也，水气胜，故脉沉，血热微故脉迟，肾寒不能纳气，故喘，此水气之病，关于本藏，而绝无外因者也，石水之病亦出于肾寒，其脉沉绝，石谓如石之沉于水底，非如他物之足以上泛，似石水之名特以阴寒凝固不可动摇之（双按淋浊一证，有砂淋、石淋，谓水与膏液凝结，坚硬而不可攻也）不知石水一证，亦当有膏液凝结如石在回肠之外，无疑于呼吸，故腹满不喘，此水气之病异于正水，而攻之不动，温之不化者也，陈修园乃以后文属少阴者当之，岂正水不属少阴乎。（近人有治石淋方用针寒软坚之银硝合利水之滑石调服，似可借用）黄汗之病，变于营分，久而后发，此与水气之变在卫分者不同，沉迟似正水脉，则其病不在皮毛，尽邪在卫，主皮毛而恶寒，邪在营即主肌肉而发热，水寒而血热也，胸为阳位，四肢为诸阳本，三阳之络，皆上头面，胸满而四肢头面肿，则湿胜而阳痹，所以久不愈必致痈脓者，营变而生热也，此水气黄汗之别也。

脉浮而洪，浮则为风，洪则为气，风气相搏，风强则为瘾疹，身体为痒，痒者为泄，风久为痼癩，气强则为水，难以俯仰，风气相系，身体洪肿，汗出乃愈，恶风则虚，此为风水，不恶风者小便通利，上焦有寒，其哆涎，此为黄汗。

水气一证，惟风水为轻，大要为外风束缚而汗出不澈，轻则为风湿，重即为风水，

覆杯水于坳堂，但觉其沾渍耳，累进而增益之，则泛而溢矣，病属太阳之表，故脉浮，骨节痠痛，恶风与风湿略相似，此积湿成水之明证，尽气与水相为变化，沔与湿相为虚实，水液由脾阳运输为胸中阳热蒸化，当由皮毛外泄成汗，故水之未成者为气，一受外邪，毛孔闭塞，其气即停阻不行，故气之渐寒者为水，但此证初起水气未甚，风薄于外，气抗于里，脉乃浮洪，风淫于外，毛孔之汗不泄，则结于皮外而成瘾疹，于是遍体痒不能忍，则搔以泄之，久而不愈遂成痲癩，与疥相类，此风甚湿轻之证，亦卫气微弱不能作水之证也，夫卫气微弱，中含水分不足，遇风气夺则为湿，卫气强盛，中含水分过多，遇风气夺则为水，湿则仅留表分为疹，为痒，水则流注皮中，内及胸腹肿胀喘满，难以仰，风邪一日不解，则水气一日不去，故曰汗出乃愈，但仲师所言汗出乃愈者合前证言之，非专指已成水病者言之也，虽然风水之体肿实与黄汗相似，风水属卫，宜解表固当用麻黄以发汗，黄汗属营，宜解肌，即不当用麻黄，辨此者，要以恶风不恶风为标准，风水起于外感，病原与中风同，故恶风，黄汗不由外感，病原与中风异，故不恶风，加以小便通利，上焦有寒，其哆涎，所以小便利者外无风邪以吸之，内无粘滞之湿以阻之也，所以上焦有寒，其口多涎者，黄汗始病，营热为寒水所变，胸膈无阳热之化也，此黄汗别风水之大略也。

寸口脉沉滑者，中有水气，面目肿大，有热，名曰风水，视人之目窠上微肿，如蟹新卧起状，其颈脉动，时时咳，按其手足上陷而不起者风水

风水之证，起于太阳，故其脉浮，洪为多，浮者风脉也，但风水所由成，积渐于太阴之湿，终成于少阴之寒，故其脉亦有时而沉滑，沉即为水，滑即为湿，水气留著皮毛之里，面目独见肿大者，风中于头也，所以有表热者，以病原之同于中风也，此证或目下有卧眦形，鲜明光泽，气冲咽喉，颈脉动而微，咳易与正水混淆，但其手足俱肿，按之下陷不起者，乃为风水确证，所以然者，尽以风之中入肌腠先受，而脾为之应，故伤寒论太阳阳明二篇，并谓之系在太阴，不独太阴本篇为然，所以载于太阳篇者，以风之中入，先痹肌腠言也，故桂枝汤之作用，曰解肌，所以载于阳明篇者，以太阳寒水不得外泄流入肠胃言之也。所以棣于太阳本篇者，则以病起于风，成于水，水气不得外泄，合脾藏之湿下陷，将成寒湿之证也，脾主四肢，故风水必流溢四肢，是以閼虐由于脾寒者，手足先冷，外风系在太阴者，手足自温，发汗之其中阳，手足见厥者，服干姜甘草汤而其厥当还，病理固无不同也。

太阳病，脉浮而紧，法当骨节疼痛，反不疼，身体反重而痠，其人不渴，汗出即愈，此为风水，恶寒者，此为极虚，发汗得之，渴而不恶寒者，此为皮水，身肿而冷，状如周痹，胸中窒，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，此为黄汗，痛在骨节，咳而喘，不渴者，此为肺胀，其状如肿，发汗则愈，然诸病此者，渴而不利，小便数者，皆不可发汗。

此一节举相类之下，出阴虚不可发汗之例，欲处方者，知所择也，风寒为病，起于

太阳，故其脉当浮，但缓则为气，紧则为寒，为水，由风湿寝成，风水外证，当见骨节疼痛，今不疼而反见体肿而竣者，尽湿将成水，则痛，湿已成水，即重而竣，此湿流关节，水伤肌肉之辨也，水气尚在肌肉，不在心下，不能阻隔中脘阳气，故不渴，此风水之宜于发汗者也，又有本太阳病，因发汗而恶寒者，此为表阳虚，太阳篇所谓发汗病不解反恶寒者，芍药甘草附子汤主之，即此证也。此同一太阳病，而不宜更发汗者也，前云皮水脉浮，跗肿不恶风，不渴者当发其汗，此云渴而不恶寒，此为皮水，按寒字当为风字之误为其异于风水也，四肢肿，水在皮腠中为皮水，甚则肢冷，故后文又有厥而皮水方治，此可见皮水为里寒水聚之证，何以前条言皮水不渴，当发其汗，本条反以渴而不恶风为皮水，几令辨证者茫无定据，不知当其汗，特为不渴者言之耳，皮水之证要以渴为标准，水气入里，肿见于外，水寒不能化气，滋溉不及咽喉，乃引温水以自救，皮水不渴，不由燥而由湿，灼然无可疑者，水不去则肿不消，寒不去则渴不止，此当利小便之治，异于始病之可以发汗者也，皮毛外闭，故不恶风，惟下文身肿而冷二句当属黄汗言，陈修园指为皮水者误也。

尽黄汗之始病，四肢头目皆肿，故曰如周痹，一身之气痹也，营热为水邪所系，故身肿而冷，惟其湿胜阳痹，故胸中窒（此与胸相类，胸中淋巴幹，不能发水液与气，故气不通）湿停中脘，容积不多，故不能食，水寒营系，络脉不通，故反聚痛，营气夜行于阳，故血分温度特高，不惟烦躁，抑当热发汗出，所以然者，营气尽系，暮则反抗也，此黄汗病在肌腠系热，异于皮毛之寒，当解肌以发汗者也，太阳寒水为表寒所遏，则一身尽疼，脉见浮紧，此太阳伤寒之所同，皮毛不开，肺气内闭，里热与水气相搏，搏因喘咳而病肺胀，所以不渴者，水气未入中脘不能阻阳气之上承也，所以其脉如肿者，水气系于皮毛也，证属暴感，宜越婢加半夏汤以开表清理而其喘自定，所谓发汗即愈也，但病在皮毛者，可以发汗，若水渗肠胃而下利，水入下焦而小便数，阳虚于上，湿流于下，必见燥渴，若发其汗，非惟重伤阴液，抑且不能愈病，所以然者，为水气不在腰以上也。

里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水，假令小便自利，此之津液故令渴，越婢加术汤主之（方见中风）

黄汗之始病，四肢面目皆肿，而其脉沉迟，里水则四肢面目皆肿，而其脉沉迟，里水则四肢面目黄肿，而其脉亦沉，所以别于黄汗者，特暮夜无盗汗耳，夫水气外泄为汗，下行为小便，今外既无汗，小便复不利，水乃系于皮毛之里而病黄肿，若小便自利，黄肿当减，乃黄肿如故，而反见渴者，以水湿隔寒于上，胃中津液不得上承也，此证胃中必有变热，观外证之黄肿自见，不见夫造酱面者乎，乘热而覆盖之水湿与热合并，蕴蒸不三日而发黄矣，仲师用越婢加术汤解表与清里同治，使水湿与热悉从汗解，则肿退而渴止矣。

趺阳脉当伏，今反紧，本自有寒疝瘕，腹中痛，医反下之，即胸满短气，趺阳脉当

伏，今反数，本自有热，消杀，小便数，今反不利，此欲作水。

此节向无的解，陈修园以为水病人别有宿疾，当从趺阳脉与其旧疾而兼顾之，不可风肿治肿，黄坤载则谓脉伏有寒热不同，寒伏当脉紧，此当有寒疝腹痛，医下之即胸满短气，热伏则脉数，此当有积热，消水杀而小便数，今反不利，此水杀水消，内原无热，欲作水也，二说俱非，尽水之将成，必有其因，水病多由肾阳虚寒，其脉本当沉伏，反见紧者，则以向有痰瘕，腹痛诸证，医反用寒下法，使外寒乘虚而入，肾气从之，因见胸满气短之象，此即后文以为留饮而大下之，又与葶苈丸下水之变也，趺阳之脉本因水病而沉伏，今反见数，设病者本自有热，当得消杀而小便数，今反不利，便可知客热不消水杀，结膀胱而蓄水也，此节下文数脉即止之义也（数为热结，止即水停蓄）

寸口脉浮而迟，浮脉则热，迟脉则潜，热潜相搏名曰沉，趺阳脉浮而数，浮脉即热，数脉即止，热止相搏，名曰伏，沉伏相搏，名曰水，沉则络脉虚，伏则小便难，虚难相搏，水走皮腠，即为水矣。

风水皮水，皆由肺气不达皮毛所致，故其诊多在手太阴动脉，而不及趺阳，惟正水则上下并见，而根原独成于下，故必兼诊趺阳，方能核实，但寸口脉明系浮迟，仲师乃名之曰沉，趺阳明系浮数，仲师反名之曰伏，后学殊难索解，虽徐忠可说量至为详尽，然可与中人以上言之，浅学者不能无疑也，吾直以为浮迟，浮数主脉象，言沉与伏主病情言两者，不当朦混沉伏相搏名曰水，即节专指病情之显著也，浮迟在寸口则营气下寒而不上应，营气下寒则水不化气，水就下，故名曰沉，浮数在趺阳则卫气下阻而不上行，卫气下阻则水道反为所吸而不得流通，故名曰伏，然则仲师言浮脉则热，迟脉则潜，热潜相搏者，以水气上闭，血寒不能蒸化为汗言之也，言池脉则热，数脉则止，热止相搏者，以热结膀胱小溲不利言之也，营气不上应，因见络脉之虚，络脉虚则身冷无汗，卫气不上行因见小便之难，小便难则瘀热苦水，于是一身上下阳气不通乃逆走皮腠而成水矣，此证仲师未有方治，陈修园消水圣愈汤，尚有古意附存之。

大乌头牡桂细辛，净麻黄，炙甘草，知母，防己，生姜，大枣，日夜三服，当汗出如虫行皮中即愈。

寸口脉弦紧，弦则卫气不行，即恶寒，水不沾流，走于肠间少阴脉紧而沉，紧则为痛，沉则为水，小便即难，正水前后，脉证不同，仲师虽不出方治，原其脉证所以不同者，而治法已存乎其中矣，正水已成，则水寒积于下，虚阳浮于上，故寸脉浮而迟，方在将成则阴寒锢其表阳，气停于内，故寸弦而紧，正水已成则水寒，无气阳变不通，故趺阳脉浮而数，方在初成阴寒内薄，气化不行，故寸口关后之脉沉而紧，水寒血凝故痛，卫气束于寒，不能作汗外散，则水不沾渍，下走肠（原作沾流，误也，尽水化气成汗，故沾渍，水寒重坠，故下陷也）营热息于内，则肾阳不通

而小便不利，此时寒水暴遏，表里阳气绝然消歇，故但见弦紧，沉紧之脉，予谓此直麻黄细辛附子汤证，麻黄以达表寒，附子以温里寒，细辛由里达表，从下而上，扶肾阳而疏表里，则大气运行，汗液泄而小便亦通矣，近人漫用五苓五皮以治水，舍此别无良法，抑独何欢。

脉得诸沉，当责有水，身体肿重，水病脉出者死。

水病脉当沉，沉非重按始得之，谓乃脉道不利，而寸口浮迟也，水气沉于下，清阳不能化气上行，络脉不得滋溉，因病空虚，络脉虚，故寸口应之而迟，沉者必伏，伏者水气在下，足背趺阳之脉反见浮数，水气不得由膀胱下泄，故脉沉者小便必难，表里上下不得气化，故水留于肌肉而身体肿重，若浮迟之寸口，反见洪大而数，少阴趺阳之脉反见微弱则是阴盛于下，阳脱于上，谓之脉出譬之，油灯垂涸忽然大明，其能久而不灭乎。

夫水病人，目下有卧替，面目鲜泽，脉伏，其人消渴病水，腹大，小便不利，其脉沉绝者，有水可下之。

内经云，诸有水气者，微肿先见于目下，予诊痰饮病亦往往见之，尽水与饮因同源而异病也，水困脾阳必见于所主之部分，曰胞及腹，皆足太阴所主，故目下有卧替，而腹大目鲜泽者水之标，小便不利者水之本，消渴者，水外浮而内竭，且水寒不能化气故也，脉沉固当有水，至于沉绝，则肾中阳气将亡，便当急下以存阳，譬犹伤寒少阴证之急下存阴，仲师于此条不出方治，予意当与大黄附子细辛汤，是即寒疝之脉状如弓弦不移，阳中有阴可下之例也，若陈修园所云用真武汤加木通防己椒目以温肾阳而利小便，虽亦言之成理，不知水气清者外可以发汗，内可以利小便，若水与痰涎糞秽胶结成瘀，则舍温下更无良法也，奈何利小便乎。

问曰，病下利后，渴饮水，小便不利腹满，因肿者，何也，答曰，时法当病水，若小便自利及汗出者自当愈。

下利之后，阴阳并虚，阴虚则渴，阳虚则水饮不消，小便不利，腹因肿满，引为暴蓄之水，初无胶因不解之痰浊与之混合，故但得汗出，小便利即当自愈，惟下后里阴先伤，阳气复顿，虽腹满而肿，不当从利小便，当用妇人转胞肾气丸治，阴阳两补，而水道自通，或用渴饮水之文蛤散，尽蛤杀针寒，上能止渴，下通小便，杵为细者，譬之滤水之砂漏，格其渣滓，水道以澄清而易通也。

心水者其身重而少气，不得卧，烦而燥，其人阴肿肝水者，其腹大不能自转侧，胁下腹痛，时时津液微生，小便续通，肺水者，其身肿，水便难，肿时鸭蹠，脾水者其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难，肾水者，其腹大脐肿腰痛不得溺，阴下湿如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。

水道行于三焦而出于膀胱，故六府有水，五藏不当有水，以五藏为真有水者妄也，然则仲师何以言五藏水，曰此以部分言之，以以气之受病言之也，水气凌心，则心阳受困，脾肺不能承受心阳，故身重而少气，心气不能降，故心肾不交而不得卧寐，心火系于上，则烦而躁，阳不下达，水气独留，故阴肿，此心水不关本藏者也，水胜则肝胆被袭不得疏泄，肝病传脾，故腹大不能转侧，厥阴脉络，结于国下，故胁下痛，但肝胆虽袭，亦有时而疏泄，故津液微生而小便续通，此肝水不关本藏者也，肺主清降，肺气为水邪所阻，则水邪不降而身为之肿，肺气不达皮毛，太阳标热下陷，膀胱热结，小便困难，肺与大肠为表里，肺病延至大肠，故时鸭溏，此肺水不关本藏者也，脾在中脘，部分在腹而外主四肢，脾为水困，故腹大而四肢苦重，脾寒不能化生津液，故津液与气俱少，脾为湿藏，水湿相搏，则浊痰粘滞，水道不清，故小便难，此脾水不关本藏者也，若夫肾则本为寒水之藏，上承中焦，下及膀胱，以全其为决渎之官，肾寒则决渎失司，滥于腹则腹大而脐肿，壅阻中下之关键，则腰痛而不得溺，寒水浸灌于下，故阴下湿如牛鼻下汗，肾阳不行，阴寒随少阴之脉下注，故其足逆冷，头为诸阳之会，水气作于池阴，阴不过阳，故肿不及面部而反瘦，此肾水虽关本藏，而肾藏要无蓄水之余地也。

师曰，诸有水者，腰以下肿，当利小便，腰以上肿当发汗乃愈，利小便人但知为五苓散，发汗人但知为麻黄汤，此泥于成方，不知水病者也，利小便之剂详消渴篇，发汗之剂详痰饮风湿二证，学者酌剂轻生而用之，皆当应插奏效，然亦有当利小便之证，必先行发汗而小便始通者，尽大气不运，则里气不疏，肺气不开，则肾气不降，故常有屡进利水之药，小便终不利者，职是故也，并有发汗之证，必兼利小便而始愈者，尽发汗则表疏在里之水气不能尽去，势必由下焦决渎运输而始畅，非因势利导，则余邪不表也，变而通之，存乎其人，当记吴县门人陈道南于戊辰八月，偕闻北贾姓小儿来诊，手足并肿，腹大如鼓，予用麻黄五钱，熟附子五钱，细辛三钱，小便微通而胀如故，道南用麻黄六钱，原方中加杏仁桔梗，一夕而小便大行，明旦肿已全消，周身微汗而病愈矣，可见开肺表疏，则一身之水不为大气所吸，不待猪苓泽泻自能顺其就下之性也，若夫仲师所言，要为示初学辨证用药法程，尽腰以上有温度淬与脾，能吸收小肠水气津液，由胸中发抒水气之统机关以散出皮毛为汗，腰以下由两肾泄水输入下焦，直达膀胱为小便，一部分有一部分之作用，则固不当混同也。

师曰，寸口脉沉而迟，沉则为水，迟则为寒，寒水相搏，趺阳脉伏水杀不化，脾气衰则鹜溏，胃气衰则身肿，少阳脉卑，少阴脉细，男子则小便不利，妇人则经水不通，经为血，血不利则为水，名曰血分。

水病所由成，起于阳衰阴盛，此固尽人知之矣，然不明水气消长之原，与水道通行之处，则仲师此节意旨，正未易明也。内经云，上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎，所谓上焦如雾者，肺为主气之藏，水杀入胃，化蒸气而上达于肺，肺窍吸入之天气较凉与蒸气相触乃化为水，则肺为发水之原，可知，饮入于胃，胃中至热不能容涓

滴之水，西人暴牛烈日中，饮以盆水，杀而验之，胃中固无水也，可见中焦固无水也，可风中焦如沤，正以所纳之水，悉受阳明燥化，散成水面国泡上出，则脾胃为行气之本，可知若肺肺化水下行，由肾藏出下焦，直达膀胱为小便，可见足少阴寒水之藏，为泄水之器，寸口为手太阴动脉，仲师言寸口沉而迟，寒水相搏者，谓肺塞而气不行于太阳之表，太阳寒水，相并而不陷也，言趺阳脉伏水杀不化者，为胃中原有之热，为寒水所夺而水将泛滥也，言少阳脉卑少阴脉细，男子则小便不利，妇人则经水不通者，谓手少阳三焦水道，与肾藏俱寒，水气遏于膀胱，胞中血海（在少腹两角）乃并为寒水所困，血凝成瘀，水道愈寒，故有水肿之病，无论何种利水猛药，水终不行者，职是故也，然则桃核承气、抵挡汤防洪、大黄蜚虫丸为万不可少矣（蜚虫即地鳖虫，今药肆所用硬杀黑虫，非是丸亦无效）但病机所在，起于肺藏之寒，而太阳寒水不行于表里，继乃延至中脘，而阳明燥化无权，恐从事攻瘀，卒不行则麻黄附子细辛合干姜，甘草参用抵挡丸尚矣，或曰此证阳虚血寒，正恐不胜重药，故但用泽兰，茺蔚已足，若施之后一证，犹为近是陈修园治蔡本谦水肿垂死用泽兰取效，其明验也，若此证阴寒太甚，概欲以轻剂取效得乎。

师曰，寸口脉沉而数，数则为出，沉则为入，出则为阳实，入则为阴结，趺阳脉微而弦，微则无胃气，弦则不得息，少阴脉沉而滑，沉则在里，滑则为实，沉滑相搏，血结胞门其痼不泻，经络不通，名曰血分。

上节言寸口脉沉而迟，此节言沉而数，脉得诸沉当责有水，仲师则既言之矣，然何以有迟数之别，尽寸为肺脉，太阳虚寒，肺气不能外达，脉即见迟，太阳标阳外浮，吸水不得下行，故脉见数，数则为出者为标阳外浮言之也，沉则为入者为本寒下陷言之也，阳实者，标阳外实也，阴结者，里阴凝结也，外有所吸，里有所凝，则寒伤卫而更伤营矣，上节言趺阳脉伏，此节言微而弦，夫水气为病，趺阳脉当伏，仲师又明言之矣，若微而弦，则胃气虚寒，则纳减，寒则少气，尽即上文当伏反紧之脉，此正与血分虚寒，先见痃痞腹痛，误下成水，胸满短气者，略相似也，尺部脉微，固属水胜血寒，当从少阳伤寒脉微细之例，若少阴沉滑，沉即为水，滑即为血，叔和脉经言滑为血有余，观妊娠停经之脉，每见滑象，足为旁证，此即血结胞中之大验，治法当以去痃为急，痃不去则水不利，然则寸脉沉而数，太阳标热，既吸于外而水不下行，趺阳脉微而弦，又于无阳之脉隐然见痃痞之象，参之少阴之沉滑，水寒血凝之象，益复显然近人但见水治水，见寒治寒，于血妥每多疏忽，此不读经方之过也。

问曰，病有血分，水分何也，师曰，经水前断后病水名曰血分，此病难治，先病水后经水断名曰水分，此病易治，何以故，去水其经自下。

仲师言经水前断后病水，名曰血分，此病难治，先病水后经水断名曰水分，此病易治，究其所以然，尽谓经水之断，或由肝郁，或由血亏，大抵虚寒为多，虽亦有出于二阳燥热者，此证必不病水，因水停经病，正在水血分之病，不过因水气太甚阻

其经隧，虚者难攻，实者易攻，妊娠有水气，用冬葵子茯苓散亦易治之明证也，设本非妊娠，则但去水而经自通矣。

问曰，病者苦水，面目身体四肢皆肿，小便不利，脉之不言水反言胸中痛，气上冲咽，状如炙肉，当微咳喘，审如师言，其脉何类。师曰，寸口脉沉而紧，沉为水，紧为寒，沉紧相搏，结在关元，始时尚微，年盛不觉，阳衰之后，营卫相干，阳损阴盛结寒微动，肾气上冲咽喉，塞噎胁下急痛，医以为留饮而大下之气紧不去，其病不除复重吐之，胃家虚烦，咽燥欲饮水小便不利，水谷不化，面目手足浮肿，又与葶苈丸下水，当时如小差，食饮过度，肿复如前，胸胁苦痛，象若奔豚，其水扬溢则咳喘逆，当先攻掣卫气令止，乃治咳，咳止其喘自差，先治新病，病当在后。

治病之法，当辨虚实缓急，始之不慎，乃有误治之变，救逆之法则当从先治客病后治本病之例，学者不可不知也，即如病者，苦水面目身体四肢皆肿，小便不利，此水气泛滥，乃本证也，然病人不言苦水，而反苦胸中痛乃气上冲咽，状如炙肉，微喘咳，似非水气本病，而与痰饮之卫气上逆者略相似，仲师所谓脉沉而紧者，尽此证本属虚寒蓄水，沉紧为在里之象，故本病结在关元者，少阴之穴在脐下一寸，年盛不觉迨阳衰阴盛，水气漫延，先病卫分而后乃于营分，寒气溜于肾，则肾气上冲咽喉而胁下急痛，胁下本肾藏所居，为水道下通之门户，悬饮内痛，正在胁下，故医者误以为留饮用十枣汤大下之，水去而寒气独留，胁下之痛如故，又疑痰阻上隔，用瓜蒂散吐之，于是胃中虚热上浮，而咽燥渴饮矣，渴饮无度，肾寒不能制水，小便不利矣，脾阳吐后益虚而水杀不化矣，寒水泛滥逆行，而面目手中浮肿矣，医者至此尚不觉悟，泥于葶苈止胀之说，更用葶苈丸以下水，非不小差也，食饮过度，肿复如前，所以然者，胃阳虚而不能消杀，肾阳虚而不能消水也，所以胸胁苦痛，状若奔豚者，胸为上焦所自起（西医谓之淋巴幹）胁为中下二焦水道所从出（水道由肾走膀胱）屡经误治，阳气益虚，阴寒乃乘虚而上僭，水气冲激于肺，肺不能受，故咳而喘逆，然则治之之法奈何，曰此当先治卫气喘咳，为误治后之新病，痰饮篇治卫气之桂苓五味甘草汤，当可借用，卫气既抵，而咳如故，又当用苓甘五味姜辛汤以治咳而喘自止，由是治其本病，而防已茯苓汤，麻黄附子甘草汤，栝蒌瞿麦汤，茯苓戎盐汤，滑石白鱼散俱可随证酌用矣。

风水脉浮身重，汗出恶风者，防已黄芪汤主之，腹痛者加芍药（防已黄芪汤方风湿病）

按此条与风湿同脉浮为风，身重为湿，湿甚即为水，汗出恶风，表虚而汗泄不畅也，按此亦卫不与营和之证，防已以利水，黄芪固表而托汗外出，白术炙甘草补中以抑水，而风水可愈矣，所以腹痛加芍药者，芍药味甘微苦，其性疏泄，能通血分之瘀，伤寒桂枝汤用之以发脾藏之汗，而达肌理者也，脾为统血之藏，腹为足太阴部分，腹痛则其气变于脾之大络，故加芍药以泄之，妇人腹痛用当归芍药散，亦正以血分凝瘀而取其疏泄，若以为酸寒敛阴，则大误矣。

风水恶风一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热越婢汤主之

越婢汤方

麻黄六两 石膏半斤，生姜三两，甘草二两，大枣十二枚

上五味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服，恶风加附子一枚，风水加术四两

犹是风水之证，恶风脉浮与前证同，惟身重则病在肌肉，一身悉肿，则病在皮毛不渴，则胃中无热，续自汗出者，风主疏泄故也，但风为阳邪，当得发热，观中风证便知今病者无大热而但有微热，则皮毛不开，阳气不得发越之象，故用越婢汤，内扶脾阳，外开皮毛肌腠，使风随汗液外解，而其肿自消，所谓因势利导也。

皮水为病，四肢肿，水气在皮腠中，四肢聂聂动者，防已茯苓汤主之

防已茯苓汤方

防已，黄芪，桂枝各三两，茯苓六两，甘草二两

上五味，以水六升，煮取二升，分温三服

肺主皮毛，皮水之为肺病，此固不言可知，按本篇提纲曰其脉亦浮，外证跗肿，按之没指，不恶风，其腹如鼓不渴，当发其汗，其为越婢加术汤证，无可疑者，然何以有防已茯苓汤证，曰此为渴者言之也，寒水在下，不受阳热之化，则津液不得上承而咽喉为燥，自非利小便以排水，则渴将不止，防已茯苓汤。此固利小便之方治也，太阳水气，本当作汗外泄，为表寒所遏，则皮毛之气悉化为水，而水气在皮腠中，所以在皮腠中者由皮毛而渐渍肌肉也，水渍肌肉则脾阳不达四肢，而四肢肿，肿之不已，阳气被袭，因见筋脉跳荡肌肉，寒颤如风前水叶聂聂动摇，故方中用黄芪以达皮毛，桂枝以解肌使皮毛肌肉舒畅，不至吸下行之水，更加甘草以和脾，合桂枝之温使脾阳得旁达四肢，但得脾精稍舒，而肢肿当消，所以用黄芪不用麻黄者，此亦痰饮病形肿，以其人遂痹，故不内之之例也。

里水越婢加术汤主之，甘草麻黄汤亦主之（越婢加术汤见上）

甘草麻黄汤方

甘草二两，麻黄四两。

上二味，以水五升，先煮麻黄，去上沫，内甘草，煮取三升，温服一升，重覆汗出，不汗再服，慎风寒

里水一证，用越婢加术，使水湿与里热悉从汗解，前文已详言之矣，此节特补出甘草麻黄汤方治，用麻黄汤之半以发表汗为急务，尽专为无里热者设也。

水之为病，其脉沉小属少阴，浮者为风，无水虚胀者为气，水发其汗即已，脉沉者宜麻黄附子汤，浮者宜杏子汤

麻黄附子汤方

麻黄三两，附子一枚，甘草二两

上三味，以水七升，先煮麻黄去上沫，内诸药，煮取二升半，温服八合，日三服

杏子汤方（阙，陈修园曰，恐是麻黄杏仁甘草石膏汤）水病始于太阳，而终于少阴，太阳当得浮脉，少脉即见沉脉，按太阳伤寒未经发汗，水气由三焦下注寒之藏，即为少阴始病，少阴病其脉当沉，为其在里也，小即微细之渐，伤寒少阴篇所谓脉微细者，指阴寒太甚者言之也，此时水邪未经泛滥，溢入回肠而下利，故见脉小而不见微细，水邪虽陷，与表气未曾隔绝，寒水下陷，要为中阳之虚，方治特于麻黄附子汤内加炙甘草以益中气，使中气略舒便当外达皮毛肌腠，变为汗液，而水病自除，若夫脉浮为风，与太阳中风之脉浮同，此证尚属风湿，而未成为水，水气壅在皮毛而发为虚胀，故曰气水，气水者汗液欲出不出，表气不能开泄之谓。发其其水还化气成汗，故其胀即消，杏子汤方，阙寓意可用风湿证之麻杏甘薏汤，要以发汗为一定之标准也。

厥而皮水者，蒲灰散主之（蒲灰散方见消渴）

蒲灰散一方，今人不用久矣，世皆论蒲灰为蒲黄，其实不然，而钱太医以厥而皮水之厥为皮水溃烂，以水伤阳气而厥冷，尤为背谬，此厥字即上文身肿而冷之冷，伤寒金匮中从未有以厥为溃烂者，此陈修园之盲从，不可为训者也，蒲灰即溪间有大叶菖蒲，味针，能降，味辛能开，王一仁在广益医院治病，有钱姓男子，腹如故，股大如五斗雍，臂如车轴之心，头面皆肿，遍体如冰，气咻咻不续见者皆曰必死，一仁商于刘仲华，取药房中干菖蒲一巨捆，炽炭焚之，得灰半斤，随用滑石和研，用麻油调涂益厚，涂之，改服二钱，日三服，三日而肿全消，饮食谈笑如常人，乃知经方之妙不可思议也，前数年予在家乡治谢姓小儿茎及睾丸，明若水碧，掣而服之，一夕得小便甚多，其肿即消，惟腹满不减，继以姜辛术附，后以急于汭，不复知其究意，甲戌十一月，闻此儿已十四岁已，庚午秋，治海潮寺路宋姓小儿，水肿亦用之。但其人手足不冷，小便消，内服麻黄附子细辛汤，佐以五苓冬葵子，车前

子，外敷蒲灰散，夜调服一钱，五日而肿全消，每一日夜，小溲十七八，次云

问曰，黄汗之为病，身体肿，发热汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄如柏汁，脉自沉，何从得之，师曰，以汗出入水中浴，水从汗孔入得之，宜芪芍桂酒汤主之

黄芪芍药桂枝苦酒汤方

黄芪五两，芍药，桂枝各三两

上三味，以苦酒一升，水七升，相合，煮取三升，温服一升，当心烦服至六七日，乃解，若心烦不止者，以苦酒阻故也

黄汗之为病，变于营分日久而后发，此与水气变于卫分者不同，方其蛰伏未久，营热不甚，故身肿而冷，状如周痹，至于身体肿，发热汗出，而渴，营热始炽矣，汗沾衣，上色黄如柏汁者，血中之液乃出黄水，即此而推之，便可知黄汗之由，实起于营分郁热，所以如柏汁者，以营热所蒸益加浓厚，非如黄阐之黄，由胃底胆汁而成也，然不辨明致此之由，则治法何从下手，将清营热乎，何以处在表之湿，将疏表气乎，何以处营之热，仲师申明汗出而浴水入汗孔得之，而治法乃定矣，以表虚也，故君黄芪以营郁之当实也，故用芍药桂枝，又惧药力之不胜病气也，故煎以具挥发性通调血分之苦酒，而营分之变热始解，今人用醋和面涂伤能去瘀血，其明证也，妇人肝郁不调内痛，用醋炒柴胡，醋磨青皮白芍，其痛立解，当亦以其能达血郁之故，则苦酒之作用可知矣，庸工动称能敛肝阴，岂仲师用苦酒之旨乎，所以六七日乃解者，以久郁之邪未易载胜也，所以心烦者，营分久郁，而主血之藏虚，一时不胜药力也，

黄汗之病，两胫自冷，假令发热，此属历节，食已汗出，又身常暮盗汗出者，此营气气，若汗出已，反发热者，久久其身必甲错，发热不止者，必生恶疮，若身重汗出已，辄轻者久久必身润，润即胸中痛，又从腰以上汗出，下无汗，腰宽弛痛如有物在皮中，状剧者，不能食疼重烦燥，小便不利，此为黄汗，桂枝加黄芪汤主之

桂枝加黄芪汤方

桂枝，芍药各三两，甘草，黄芪各二两，生姜三两，大枣十二枚

上六味，以水八升，煮取三升，温服一升，须臾啜热稀粥一升，余以助药力，温覆取微汗，若不汗更服。

中风之证，受病于肌腠，内困于脾阳，则用桂枝汤助脾阳，以解肌，使汗从腠理外泄，脾流血而主肌肉，为血络凝聚之处，故风变肌理者，宜桂枝汤，所以达营变也

，风从皮毛入，邪薄肌肉，遏其营分，是生表热，惟黄汗一证，所以异于中风者，足胫必冷，所以然者，提变于上而下通也，中风证有汗，黄汗证亦有汗，或食已汗出，或暮夜盗汗，皆为营热外达，或汗出解，反至发热，则营分热度更高，久必腠甲错而生恶疮，试观壅病外证，先病热与肿为血郁，增热继则剧痛为热甚血败，入即脓成，待医者决去其脓，其痛始定，此即营分变热必致壅脓之明证也，或身重而汗已辄，轻者湿将与汗俱去也，然汗出阳伤，久必身润，润者如目光之旋转，闪灼不定，彼此互相跳动也，浮阳张于外，牵制胸中，胸中阴液已亏，不能外应，故润，见于外而痛应于里，若腰以上汗出而不及腰以下，则汗湿在下而腰宽弛痛，少阳三焦道路由肾而下，属膀胱不下通，故腰以下多所牵制如有物在皮中状，又其甚者，胸中发抒水气之枢机，一时停顿脾阳不能作汗外泄，故湿阻胃之上口而不能食，湿在肌肉，故身疼重，防阳被变，故烦躁，阳气在上，吸水不得下行，故小便不利，究其所以，然实由水湿变其营血所致，要知黄汗一证，肌表以久汗而虚，不同中风之为卒病，此桂枝汤所以加固表之黄芪也。

师曰，寸口脉迟而涩，迟则为寒，涩则为血不足，趺阳脉微而迟，微则为气，迟则为寒，寒气不足，即手足逆冷，手足逆冷，则营卫不利，营卫不利，则腹满胁鸣，相逐气转，膀胱营卫俱劳，阳气不通，即身冷，阴气不通，即骨疼，阳前通则恶寒，阴前通则痹不仁，阴阳相得其气乃行，大气一转，其气乃散，实则矢气，虚则遗溺，名曰气分。

气分心下坚大如磐，边如旋磐，桂甘姜枣麻辛附子汤主之

桂甘姜枣麻辛附子汤方

桂枝，生姜各三两，细辛，甘草，麻黄各二两，附子一枚炮，大枣十二枚

上七味，以水七升，先煮麻黄去上沫，内诸药，煮取二升，分温三服，当汗出如中心行皮中即愈。

仲师即明水气证治而终以血分，既明黄汗证治而终以气分欲人于同中求异而明治法也，尽水之甚者为水，水不甚即为黄汗，气之外泄而遇寒为水，水气之在里，不遇寒则仍愈为气，水可攻而气不可攻，要其证则为表里上下俱寒，如冬令雨雪坚水，阳气变伏天动，不似春夏之易散，故仲师举寸口之脉迟而涩，便可知外不达于皮毛，而太阳之阳气先虚，举趺阳之脉微而迟，醒可知里气虚寒，四肢不得禀中阳之气，中脘虚寒不能发抒营卫二气，于是太阴之腹部，厥阴少阴之胁下，悉为客寒所据，而太阳水气，不行于膀胱中脘，脾阳不通于肌腠，因而身冷里阴不濡于骨髓，因而骨痛，由是太阳之气通于前，而肾阳不与俱行，则小便已而涩涩恶寒，少阳之气通于前，而三焦之火不与俱至，则少腹满而外证不仁，故必先去其固阴逆寒，使血海之营气得温而上行，肺藏之卫气清寒而下降，然后蛰伏之气从而消释，大气者，

阳气也，转则阴寒散矣，由是寒气之乘里虚者，以遗溺解而腹满胁鸣止，表里和而手足不复逆冷矣，此桂甘姜枣麻辛附子汤，所以治心下坚大如磐，边如旋杯，凝固不解之阴寒，而效如浮鼓也。

心下坚大如磐边如旋磐，水饮所作，枳术汤主之

枳术汤方

枳实七枚，白术二两

上二味，以水五升，煮取三升，分温三服，腹中软即当散也

疹病之法惟外证同而虚实异治者，为不易辨也，同一心下坚大如磐边如旋杯之证（旋杯，按之硬，若杯之旋转而高出）何一则宜上下表里通行温散，汗出如虫行皮中而愈，一则用攻坚燥湿，三服后腹中软而愈，尽气分之脉，必兼迟啬，水饮之脉必见沉弦，此脉之易辨者也，气分则见窒塞，水饮必将内痛，此证情之易辨者也，气为寒，约则温，以散之寒因水实则攻而和之，仲师所以称医圣也。

黄疸病证并治第十五

寸口脉浮而缓，则为风，缓则为痹，非中风，四肢苦烦，脾色必黄，瘀热以行，趺阳脉紧而数，数则为热，热则消杀，紧则为寒，食即为满，尺脉浮为伤肾，趺阳脉紧为伤脾，风寒相搏，食杀即眩，杀气不消，胃中苦浊，浊气下流，小便不通，阴被其寒热流膀胱，身体尽黄，名曰杀瘵。

湿与热并乃生黄色苴荣在壅酱面，在愈其明证也，故论黄瘵所由成，必先论脾藏之湿，脾主肌肉，而汗泄于肌理，气达于四肢，则湿无停阻之患，惟风中肌肉则脾阳必顿，顿则腠理闭塞而肌肉为痹。四肢为脾所主，湿热留于脾藏，故四肢苦烦，风脉本浮，湿痹肌肉则缓，寸口见浮缓之脉，脾中瘀热行周身，而面目爪甲俱黄矣，此一因也，一系胃中之热。胃热固能消谷，而肌肉外受风寒，内困脾阳，即宿食为之停阻，水杀停于中脘，湿热以日久而增，故趺阳见紧数之脉，便可决为发黄之渐，此二因也。一系风邪由肌腠入里，循三焦而下及于胃，肾为寒水之藏，下有二管，直接膀胱，为水道所从出，风阳吸于肾，则水道不行，寒邪由肌腠犯脾藏，则脾以虚寒而留湿，食谷即眩者，湿与热混杂而浊气上冒于颠也，寒入足太阴，脾不能为胃输津液作汗，湿热反致内陷，小便不通，胃中浊热无外出之路，乃由胃而流入膀胱，故于尺部少阴脉浮见肾水不流，足背趺阳脉紧风脾阳不运，皆足蕴蒸发，此三因也，名曰杀瘵。

额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳瘵，腹如水状不治。

女劳瘵证状有六，一曰额上黑，额上为颅骨覆脑处，肾虚者脑气必亏，故精气不荣于额上而见晦滞之色，陈修园以额上为心部，肾邪重而水色见于火部，直瞽说耳，二曰微汗出，微汗出似不足为病，而女劳瘵独否，尽用力入房皮毛开而汗液屡泄，泄之不已，皮毛从此不收，津液即随时漏泄，三曰手足中热，则由以欲竭精之时，手足用力太猛，少阳胆火乃乘少阴之虚流溢于劳宫涌泉二穴，四曰薄暮即发，薄暮阳衰之候，寒湿下动，乃反迫真阳而外出，五曰膀胱急，寡欲者肾阳充，充则下焦水道布气于少腹，膀胱以温和而缓，多欲者肾阳虚，虚则阳气不及州都，膀胱以虚寒而急，此证与脉紧为寒同义，可见陈修园谓肾虚累及外府，犹为未达一间也，六曰小便自利，自利者不自知而利也，肾关不固，则小溲不禁，黄坤成载谓火败水寒，蛰藏失政，尽略近之，若夫脾肾两败，腹如水状，即为不治之证，尽腹为足太阴部分，肾即在腹之两旁，肾藏无火，不能蒸化脾阳，由是脾藏虚寒，湿邪凝互从而腹满，然苟用四逆加茵陈蒿以治之，何尝不可挽救一二，昔金子久患此证，自服茵陈蒿汤，不愈乃就丁君甘仁，授以附子汤加茵陈，但熟附子仅用钱半，服二剂不效，乃仍用茵陈蒿汤，以致脾气虚寒，大便色白而死为可惜也，但金本时医，即授以大剂四逆汤，彼亦终不敢服，则是有方与无方同，有药与无药同，经方见畏于世，若此可慨矣。

心中懊农而热，不能食，时欲吐，名曰酒瘴

酒者，水与杀蕴蒸而后成，随体气强弱以为量，体气强则从三焦水道下走膀胱，体气弱则留于中脘，而成湿热之媒介，胃络上通于心，胃中酒气上薰于心，故心中懊农而热，酒已变而成热，胃气大伤，故不能食，酒性上泛，故时欲吐，得甘味则益剧，此酒瘴之渐也。

阳明病迟，食难用饱，饱则发烦，头眩小便必难，此欲作杀瘴，虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也，阳明病，胃病也。脉迟胃寒也，赛是不能消谷，故饱食即发烦，所以发烦者，蕴积不消而生热也，胃中生热必冲脑部之明证隔壁，但彼为实热，实热则生燥，此为虚热，虚热则生湿，湿邪垢腻，流入三焦，故小便必难，胃中谷食不消，湿热相搏，于是欲作谷瘴，且阳明实热下之则腹满，除阳明虚热，虽下之而腹满如故，所以然者，则以胃虚脉迟，中阳不运，非如滑大之脉便于峻攻也，余详伤寒，发微阳明篇不赘。

夫病酒黄瘴必小便不利，其后心中热，足下热，是其证也。

酒黄瘴者，或无热，靖言了了，腹满欲吐，鼻燥，其脉浮者先吐之，沉弦者先下之，酒瘴心中热，欲吐者吐之愈。

酒瘴下之，久久为黑瘴，目青面黑，心中如瞰蒜齐状，大便正黑，皮腠爪之不仁，其脉浮弱，虽黑微黄，故知之。

酒瘴之病，有相因而存至者，体虚之人，不胜酒力，故湿热渗下焦而小便不利，惟酒气上薰而心中热且酒气下移而足下热，此为酒瘴之垂成，亦有酒气不冒于心而肺独受其薰灼者，则心不热，心不热故神色安靖，出言了了，而鼻中燥热者，亦为将成之酒瘴，此时病在心肺，或为心中热，或为鼻中燥以及胃气上泛欲吐者，皆可用瓜蒂散吐之，湿热泄于上，酒瘴可以不作，若小便不利，足下热即为湿热下注，但需茵陈栀子大黄汤下之以泄其热，酒瘴亦可以不作，然必审其脉浮，而后吐，倘属沉弦，即当先下，此即在高者引而越之，在下者引而竭之之例也，若心中热而误下之，则在上之热未除，在下之阴先竭，积久遂成黑瘴，伤其血委，故目青，跌打损伤肌腠见青色者，伤血故也，湿热不除，面色薰黄，此与湿家身色如薰黄同，但彼为黄中见黑，此为黑中见黄，为小异耳，心热仍在，懊农欲死故如瞰蒜状，犹谬所谓猢猻吃辣椒也，酒少饮则能生血，多饮反能伤血，热瘀在下，薰灼胞中血海，热血上行，则瘀积肠中，故大便色黑，血不荣于肌表，故皮腠爬搔而不知痛痒，酒气在上，故脉仍见浮，特因误下而见弱耳。

面色黑而微黄，故知非女劳之比寓意，此证黄连阿胶汤或可疗治，或借用百合病之百合地黄汤以清血热，而滋肺阴附存管见，俟海内明眼人研核之。

师曰病黄瘧发热烦渴，胸满口燥者，病发时火劫其汗，两热相搏得然黄家所得，从湿得之，一身尽发热而黄，肚热，热在里当下之。

黄瘧所由成胃热与脾湿相参杂者为多，独有发热烦渴胸满口燥之证为亢热而无湿，推原其故，则以方遇他病时，证属阳热复以火劫发汗，两热相得，便与湿热参杂之证，判若天渊概云从湿得之可乎，一身尽发热面黄，肚热，仲师既明示人以瘧热在里，直可决为独阳无阴之在黄硝石汤证，伤寒阳明病之但恶热不恶寒，宜大承气汤者，即其例也。请更据伤寒发黄证而推求之，太阳魄汗未尽，瘧湿生热亦必发黄，此时湿尚未去，要不在当下之例，故有阳明病无汗小便不利心中懊农者，身必发黄，阳明病被火额上微汗出，小便不利者，必发黄，但头汗出，剂颈而还，小便不利，渴饮水浆者，此为瘧热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之，何同一阳明病，仲师于前二证不出方治，非以其从湿得之，湿未尽者，不当下乎，本条热在里与伤寒之瘧热在里同，法在可下。况本条一身尽发热而黄，肚热，阳明府实显然，予故曰宜大黄硝石汤也。

脉沉渴欲饮水，小便不利者，皆发黄

腹满，舌痿黄，躁不得眠属黄家

黄瘧将成，起于蕴湿生热，此固尽人知之矣，然其所以致此歧之由，则由于辨之不早，即如仲师所述脉沉渴欲饮水，小便不利者，皆发黄，夫消渴，小便不利，脉浮者，宜利小便发汗，则仲师方治明有五苓散矣，小便不利而渴，果为肾寒，不能化气行水，则用栝蒌瞿麦丸亦足矣，何必待发黄而始治，又如腹满舌痿黄，躁不得睡，属黄家，夫腹为足太阴部分，舌苔黄腻属湿，则湿在脾藏可知，阳明病多不寐证，录胃中燥实不和也，此云躁不得睡，其为胃热无疑，此证治湿则增燥，润燥则滋湿，如欲两全，但用白虎汤加苍术可矣，果其胃中有燥矢，用茵陈蒿汤亦足矣，曲突从薪此为上策，何必焦头烂额，乃为上客乎。

黄瘧之病，当以十八日为期，十日以上瘥，反剧为难治，病气之衰不跗三候，伤寒太阳证，发于阴者，以七日为一候，仲师言黄家从湿得之，湿郁生热乃传阳明发于阳者，以六日为一候，伤寒输发于阴，七日愈发于阳六日愈之文谓一候也，玩太阳病七日以上自愈之条足为明证，阳明篇云，伤寒三日，阳明脉大，谓本太阳之病，过三候而反剧也，然则黄瘧以十八日为期，即属阳明篇，三日之例，阴以七为候，则伤寒三日为二十一日，阳以六为候，故黄瘧三候为十八日，所以然者，始病十八日内可发汗及利小便，可清热而去湿，正犹太阳伤寒一汗病已，更无余病，若过十八日，湿尽化热，欲攻不得，故仲师言反剧为难治也。

瘧而渴者，其瘧难治，瘧而不渴者，其瘧可治，发于阴部其人必呕，阳部，其人振寒而发热也。

非渴之难，渴而饮水之难，黄瘧之病，既从湿得之，则肠胃之中，必多粘滞宿垢，妨其水道，小便不利，湿乃日增则其证益剧，此其所以难治也，若夫不渴之证，脾阳犹能化气输津，即不治亦当渐愈，此其所以可治也，但同一黄瘧，不惟渴与不渴之异，即所发之部分，要自不同，故有脾阳不振，湿留中脘，胃底汨汁不容，势力亢而上逆，故呕，下文云诸黄腹痛非凡呕者，宜柴胡汤，即此证也，发于太阴故称阴部，太阳寒水不行于膀胱，即出于皮毛，表虚不达加以外寒，水气遇寒即病振怵，营热内抗，即生表热，后文所云诸病黄家当利小便，脉浮者当以汗解，桂枝加黄芪汤主之，即此证也，发于太阳故称阳部，阳部以太阴寒水言之，阴部以太阴湿土言之，要知黄瘧病源，以水与湿为主要，而成于胆汁之掺要，胆火炎上，不能容水与湿，乃合并而溢出皮外，此为黄瘧所由成，胆汁色黄，故其汁亦如柏汁之染物，可见太阳病由汗出不澈而有发黄之变者，皆胆汁与湿热混杂为之也。

谷瘧之病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄为谷瘧，茵陈蒿汤主之（茵陈蒿汤方，茵陈蒿六两，栀子十四枚，大黄二两，上三味，以水一斗，先煮茵陈，减六升，纳二味煮取三升，去滓分温三服，小便当利，尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也）谷瘧之病起于太阴之湿，成于阳明之热，太阴寒湿，与阳明之热交争，则生寒热，寒热作时。胃中饱满不食，有时思食，谷气引动胃热，上冲脑部，即病头眩，心胸不安者，胃热合胆汁上攻，胸中之湿变而生热也，湿热与胆汁混合，上于头目，则头目黄，发于皮外，则一身之皮腠黄，于是遂成谷瘧，所以用茵陈蒿汤者，用苦平之茵陈以去湿，苦寒清热之栀子以降肺胃之浊，制大黄走前阴，疏谷气之瘀，俾湿热从小溲下泄，则腹胀平而黄自去矣，按此节后仲师言分温三服，小便当利，尿如皂角汁状，鄙意大黄当走大肠，惟制大黄走小便，服制大黄者，小便多黄，而其色极深，以意会之，当是脱去制字，然既成谷瘧，大便行后，继以黄浊之小便，亦未可知也。

黄家，日晡所发热而反恶寒，此为女劳得之，膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑足下热，因作黑瘧，其腹胀如水状，大便必黑，时溲，此女劳之病，非水病也，腹满者难治，硝石，攀石散主之

硝石攀石散方

硝石熬黄，攀石烧等分

上二味为散，大麦粥汁和服方寸匕，日三服，病随大小便去，小便正黄，大便下黑，是其候也。

硝石即芒硝之成块者，攀石即皂攀能化粪为水，女劳用此方治，此亦急下存阴之义，为上文腹如水状言之也（皮水其腹如鼓，外浮而中空）

日晡所发热证情以属阳明，阳明当不恶寒，而反恶寒者，则以肾阴亏则阳明更燥，（观少阴之急下证可知）相火败也（观虚劳证，手足逆寒可知）燥则发热，虚则恶寒，仲师所谓女劳得之者，为其阴虚而阳越也，膀胱不得温和之气，故急，虚气膨于少腹故满，肾亏则脑虚，故脑气不荣额上而见薰色，胆胃之火下陷涌泉，故足下热，伤

所谓谷气不流也，伤及血海，故便血，大便色黑者，瘀血之象也，脾肾俱虚，故湿陷大肠而时溏，方用硝石以去垢，攀石以化燥屎，和以大麦粥汁以调胃而疏肝，使病从大小便去，此亦在下者，引而竭之之例也。

酒疸心中懊农，或热痛，梔子大黄汤主之

梔子大黄汤方

梔子十四枚，大黄三两，枳实五枚，豉一升

上四味，以水六升，煮取二升，分温三服

酒气留于心下，上逆心藏，则心气亢而不下，往往有虚烦失眠之证，于是心阳不敛，转为懊农，酒之标气为热，从胃系上迫于心，故热痛，方用梔豉，与伤寒太阳篇治心中懊农同，加枳实则与梔子厚朴汤同，必用大黄者，盖酒疸胃热独甚也，但使胃热一去，则黄从大便去，心下诸病将不治自愈矣。

诸病黄家，但利其小便，假令脉浮，当以汗解之，宜桂枝加黄芪汤主之（方见水气）

黄疸之病起于湿，成于水，利小便发汗，仲师既出茵陈五苓散及桂枝加黄芪汤方治矣，食古而不化，此笨材也，徐忠可言当治一垂死之证，令服鲜射干至数斤而愈，又有偏于阴者，令服鲜益母草至数斤而愈，由前之说，则鼻燥头眩心中热痛，懊农欲死之证也，由后之说，则大便必黑之证也。其有不系酒疸、谷疸女劳疸者，但以小便不利，湿郁发黄，服鲜车前根叶自然汁，当无不效，此又易利小便之变法也。

诸黄，猪膏发煎主之

猪膏发煎方

猪膏半斤，乱发如雉子大三枚

上三味，和膏煎之，发消药成，分再服，病从小便出

方用猪油半斤熬去渣，加乱发发雉子大三团入煎，发消药成，分三服，病从小便出，仲师方治如此，然但言诸黄而不言所治何证，予谓此酒瘕、谷瘕、女劳瘕通治之方也，按妇人杂病篇云，胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也，猪膏发煎主之，谷气实非谷瘕之渐乎，校千金云，太医校尉史脱家婢黄病，服此下燥粪而瘕神验，徐忠可治骆天游黄瘕，用猪膏四两，发灰四两，煎服一剂而瘕，皆其明证，至如女劳一证，相火熏灼，血分必燥，酒气伤血，血分亦燥，故二证大便皆黑，猪膏以润燥，发灰为血馐，取其入血分而和血，凡大便色黑，肌腠甲错者皆宜之，故不指定为何证也。

黄瘕病，茵陈五苓散主之

茵陈五苓散方

茵陈十分末，五苓散五分

上二味和，先食饮服方寸匕，日三服

黄瘕从湿得之，此固尽人知之，治湿不利小便非其治，此亦尽人知之，五苓散可利寻常之湿，不能治湿热交阻之黄瘕，倍茵陈则湿热俱去矣，先食饮服者，恐药力为食饮所阻故也。

黄瘕腹满，小便不利而赤，自汗出，此为表和里实，当下之，宜大黄硝石汤

大黄硝石汤方

大黄、黄柏，硝石各四两，梔子十五枚

上四味以水六升，煮取二升，去滓，内硝更煮取一升，顿服

凡热邪内壅阳明，小便必短赤，甚而宗筋内痛，时出白物，又甚则筋牵右髀而痛，此固审为大承气证矣，腹满小便不利而赤，虽证属黄瘕其为阳明里实，则因同于伤寒，自汗出则为表和，病气不涉太阳，故宜大黄硝石汤，以攻下为主，瘕病多由胃热上薰，故用苦降之梔子（此味宜生用）湿热阻塞肾膀，故加苦寒之黄柏，或云梔子黄柏染布皆作黄色，仲师用此，欲其以黄治黄是说也，予示之信。

黄瘕病，小便色不变，欲自利腹满，而喘不可除热，热除必嘔，嘔者小半夏汤主之（方见痰饮）

小半夏汤一方，以生半夏合生姜为寒，上逆者用之也，岂可以治黄瘕，故陈修园于

本条下极称理中汤加茵陈之妙，然玩仲师本文特为误下成哕者言之，非以治瘧也，小便色不变，则肾膀无热，欲自利，则肠中无热，腹满而喘，便可决为太阴虚寒，若再事攻下，则热除而转哕，哕者虚寒上逆之变证，与欲呕之病正同，用特借之以救逆尽此证当不能食，不能食则胃中本自虚冷，客热不能消谷，伤寒阳明篇云，阳明病不能食，攻其热必哕，所以然者，胃中虚冷故也，然则此证不经误治，原宜四逆理中，予故谓用小半夏汤为误治成哕言之也。

诸黄肿痛而呕者，宜柴胡汤（柴胡汤方即小柴胡汤，见伤寒太阳篇，又见呕吐，按本方加减法，腹痛去黄芩加芍药）

黄瘧之病始于湿中于水，成于燥，予读杂病论至痛而呕者宜柴胡汤，恍然于胆火之为病也，未湿胜则腹满，水胜则小便不利，燥胜则胃热上攻而心中热疼，或上薰于肺而鼻燥，或食入胃热上浮而头眩，原其所以病黄瘧之由，则由胃底原不之胆汁不能容水与湿，水湿混入于胃，胆汁出而相抗，乃随水湿溢出皮毛，手足头目而成黄色，腹为足太阴部分，胆邪乘脾，乃病腹痛，伤寒太阳篇云，脉弦紧者，腹中剧痛，先与小建中汤，不差，与小柴胡汤，此即胆邪乘脾之治也，呕因少阳本病，此可证柴胡汤统治诸黄之旨矣。

男子黄，小便自利，当与虚劳小建中汤

此亦肝胆乘脾之方治也，首篇云，知肝传脾必先实脾，男子黄小便自利，则脾藏之湿欲去，而本藏先虚，脾虚而胆邪乘之，必有前条腹痛而呕之变，用甘味之小建中汤，此正因脾藏之虚而先行实脾，历来注家不知仲师立方之意，专为胃底胆汁发燥，内乘脾藏而设，故所言多如梦呓也。

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证第十六

寸口脉动而弱，动即为惊，弱则为悸

此寸口当以手太阴之第一部言，非以全部分言也，寸口之脉世称左心而右肺，其实心寄肺藏之内，原不必强分左右也，寸口之脉暴按则动，细按则弱，尽仓卒之间，暴受惊怖则心为之跳荡不宁，而寸口之动应之，故动则为惊，既受惊怖，气馁而惕息，寸口之弱应之，故弱则为悸，此证不得卧寐，终合目则惊叫，又复多疑，予当治赵姓妇人一证，颇类此，中夜比邻王姓失火，梦中惊觉，人声鼎沸，急从楼梯奔下，未及地而仆，虽未波及而心中当震荡不宁，予用炙甘草汤加枣仁辰砂，五剂而卧寐渐安，不复叫呼矣。

师曰，尺脉浮，目睛晕黄，衄未止，晕黄去，目睛慧了，知衄今止。

大凡人体中浊阴下坠，则动急之脉上出鱼际，妇人临产脉出指端，妇人经来，脉浮鱼际，此血下出而脉形变于上也，浮阳上冲，则尺部浮动而数急，虚劳吐血，则尺脉浮大，阳热上冒鼻中，衄血则尺部亦浮大，此血上逆而脉形见于下也，本条以尺部脉浮而知衄血，然必合目睛晕黄，始可定为衄血，所以然者，衄为浮阳上冲脑部之证，尽目系内接及脑部，无论阳明实热，太阳标热，一犯脑部，则颅骨缝开，血从额上下走鼻孔，衄血多日，则溢入目睛而见黄色，此与太阳温病津液索亏，误发汗而微见黄色者同例，皆为血色发黄之明证，故医考试诊脉辨色，既于尺部得浮脉，更据目睛之黄与不黄，便可决衄之止与不止也。

又曰，从冬至春，衄者太阳，从夏至秋，衄者阳明，（原本误，今校正）

太阳表实无汗之证，血热内抗，外不得泄，则上冲于脑而为衄，阳明寒热，不得大便，则亦上冲于脑而为衄，此太阳阳明之脉，因于证不因于时也，然则仲师何以言从春至夏，衄者太阳，从秋至冬，衄者阳明，曰此传写之误也，太阳伤寒，见于冬令为多，太阳中风见于春令为多，则原文当云，从冬至春衄者太阳，自夏往秋，天气炎热，肠胃易于化燥，阳明内实为多，则原文当云从夏至秋衄者，阳明，陈修园亦知其说不可据，不敢订正。其失而谓四时当活看，犹为未达一开。

衄家不可汗，汗出必颧上陷，脉紧急，直视不能，睡不得眠

此条见伤寒论，前释额上陷，既订正为额旁陷矣，然犹未甚精确也，人之头颅，惟两太阳穴最为空虚，液少则瘦而下陷，部位在颧以上，则本条当云颧上陷，所以然者，衄家热冲脑，更复发汗，则阳热益张，阴液枯燥，颧上太阳穴因瘦而陷，脉紧急，目直视不能眴，不得眠，皆阳热外张，阴液内竭之象也。余详伤寒发微不赘。

病人面无色，无寒热，脉沉弦者，衄脉浮弱，手按之绝者下血，烦咳者必吐血。

文曰，病人面无色，初未明言何病，然面无色则气弱血虚之象也（虚劳篇男子面色薄为亡血）加以无寒热，则病不在表而在里，脉见沉弦者，水胜血负，阴寒内据而阳上亢也，阳气冲脑则颅骨缝天，血从脑出而为衄，此证既无寒热，即为里虚，与上脉浮之衄不同，脉浮而弱，弱为血虚，浮即为阴不抱阳，若手按之而不能应指，则阳上浮而气不脱矣，大男子为便血，在妇人为崩漏，至于浮弱之脉，加之以烦咳，则血被冲激而上出于口，三证不同而血分之热度皆低，若误浮阳为实热，投以寒凉，必致上冒之浮阳益急，而见发热，病乃不可治矣。

夫吐血，咳逆上气，其脉数而间有热，不得卧者死

吐血咳逆上气，此即上烦咳吐血之证，但脉本浮弱，何以反数，本无寒热，何以间有表热，则凉药误之也，当见丹徒赵朴庵在四明医院吐血，表有微热，既返丹徒，医家投以凉药数十剂，表热日甚一日，至于累夜失眠，以至于死可哀也（此证误于凉药，压之不平，发之益炽，至于血热消之，而其人已死矣）

夫酒客咳者，必致吐血，此因极欲过度所致也。

酒标热而本寒，标热伤肺，因病咳嗽，本寒伤脾，因病多痰，痰不尽则咳不止，肺络激破，因病吐血，此非外感，皆贪杯者所自取，仲师洵不出方治，常清湿热，要无可疑，陈修园谓五苓去桂加知母石膏竹茹多效，尽近之矣。

寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革，妇人则半产漏下，男子则亡血失精。

此节互见虚劳篇，说解已详兹不赘

亡血不可发其表，汗出即寒怱而振

亡血一证，血分之热度本低，发其表则热度益低，血热损于前，表阳虚于后，有不病寒怱而振乎，亡友丁甘仁当啻尝言

予治失血证，验其血热亏耗者，每以附子理中取效，真至言也（说解详伤寒太阳篇，并补方治）

病人胸满唇痿，舌青口燥，但欲漱水，不欲咽，无寒热，脉微大来迟，腹不满，其人言我满，为有瘀血。

病人胸满为气滞不通，其为有湿痰与否，尚未可定，血之色见于唇，亡血者唇白，血热重则唇黑，至于唇干黑而痿，其为瘀血无疑，舌青者死，血之色见于上也，血干则口燥，然燥而渴饮，犹恐为阳明之热，若但欲漱水不欲咽，则燥，气不在肠胃可知无寒热，则决非表病，脉微大来迟，血停于下而脉不应也，腹不满，无宿食也，病者自言满其为蓄血无疑，轻则桃核承气，重则抵当汤丸，视病之轻重而酌剂可也。

病者如有热，状烦满，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴伏是瘀血也，当下之

病者如有热状，于何见之，一见于心烦胸满，一见于口干燥而渴，尽蓄血一证，原自有合阳明燥实者，内经二阳之病发心脾，女子不月是也，然按其脉有时与证情不同，此又何说，尽阴血内伏则脉不夺奋，与是当以桃核承气合抵当汤下之，瘀血行则烦满燥渴止矣。

火邪者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之（桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方，桂枝三两去皮，甘草二两炙，龙骨四两，牡蛎五两，生姜三两，大枣十二枚，蜀漆三两洗去腥，上为末，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升）

此条大旨，与火劫发汗同，火劫发汗或为惊狂，或圉血吐血，要以惊狂为最剧，故伤寒太阳篇于火劫亡阳一证，出救逆汤方治，方用龙牡以收上浮之阳，加蜀漆以去痰，按火邪之为病，因炎薰灼毛孔汗液外泄，卫气太强，肌肉之营气不与卫各，故用桂枝姜枣扶脾阳外达，使与在表之卫气融洽一片，外浮之阳气乃与里气相接，所以去芍药

心下悸者，半夏麻黄丸主之

半夏麻黄丸方

半夏，麻黄各等分

上二味，末之，炼蜜和丸，小豆大，饮服三丸，日三服

太阳寒水内陷，水气凌心，则心下悸，此非可漫以镇心之治治矣，皮毛不开，则水气之在表者不去浊，阴失降，则水气之在里者不除，半夏麻黄丸，用生半夏以去水，生麻黄以发汗，不治悸而悸当自定，所以用丸者，欲其缓以攻之，尽因水气日久化为粘滞之湿痰，非如暴感之证，水气尚清，易于达毛孔而为汗也。

吐血不止者，柏叶汤主之

柏叶汤方

柏叶，干姜各三两，艾三把

上三味，以水五升，取马通汁一升，合煮取一升，分温再服，千金加阿胶三两亦佳。

吐血无止法，强止之则积为瘀血，而病变不测，当见四明某患吐血，西医用止血针止之，遂至瘀结大肠，大便不通，后用猪胆汁导下其燥粪，投之水中，化为血色，又有用鲜生地，地骨皮止之者，其人腹中常痛，故虽吐而不止，断无强止之理，柏叶汤方治用苦啻微寒清血分之侧柏叶，以除肺藏之热，又恐其血之凝滞也，用温脾之干姜以和之，更用逐寒湿理气血之艾叶以调之，惟与通汁不易制，陈修园谓无马通汁可用童便代之，引上逆之血而导之下行，则不止血，而血自止矣

下血，先便后血，此速血也，黄土汤主之

黄土汤方（亦主吐衄）

甘草，干地黄、白术、附子各三两炮，阿胶三两，黄芩三两，窠中黄土半斤

上七味，以水八升，煮取三升，分温三服

脾寒不能统血，则下陷而便血，尤在泾谓脾去肛门远，故曰远血是也，黄土汤方法，温凉并进，以血之下泄，久久必生燥热也，故用地黄，黄芩，阿胶以润而清之，以脾藏之虚寒下陷也，故用甘草，白术以补虚，炮附子以散寒，更用窠中黄土以去湿而其血当止，辛未八月，曾治强姓饭作同事下利证，所下之血如水，昼夜不食，几死矣，方用窠中黄土四两，炮附子五钱，干姜四钱，五剂后利止，能食尽即黄土汤之意也

下血，先血后便，此近血也，赤豆当归散主之（赤豆当归散方见狐惑篇）

先血后便，此即西医所谓肠出血之证也，按本书百合狐惑篇丙者，脉数，节实为肠痈证，欲知有脓节脱文而赤小豆当归散，要为肠痈正治，语详本条下兹不赘述，赤小豆以去湿，当归以和血，欲使脓去而新血不伤也，由此观之。

本条之近血，证情必与肠壅为近，故方治同也

心气不足，吐血衄血，泻心汤主之

泻心汤方

大黄二两，黄连、黄芩各一两

上三味，以水三升，煮取一升，顿服之

太阳标阳下陷，则心气以下不足而虚，气结成痞，与阳明燥气相合，则大便不行，燥气上迫于心。，是心气愈形不足，燥热上冲于脑，则病衄血，大肠燥热挟血海之血上出于口，则病吐血，方用芩连大黄引热下泄，则心藏以不受薰灼而自舒矣，当见同乡韩筠谷治红木作吐血，证用此方，一下而吐血立止，尽亦釜底抽薪之旨也。

呕吐啰下利，病脉证治第十七

夫呕家痈脓，不可治呕，脓尽自愈。

此为热变伤络之证，与寻常呕吐不同，师但言呕家有痈脓，正不知其在肺在胃，伤寒太阳篇云，凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也，按肺痈之为病。始萌可救，脓成则死，则此节所谓不可治呕，脓尽自愈者，必非肺痈可知，寓意凡遇此证，可意用外科犀黄丸以止痛而消毒，千金苇茎汤，桂梗甘草汤并可用之，当归赤小豆散排脓散，尤为主要，尽血腐成脓，利用挾排若外体之溃疡，然毒未尽者，不当急于生肌也（此条见伤寒厥阴篇）

先呕却渴者，此为欲解，先渴却呕者，为水停心下，此属饮家，呕家本渴，今不渴者，心下有支饮故也，此属支饮。

水气湿痰，阻于上隔，胆胃上逆，则一时倾吐而出，及水气湿痰既尽，独存胆胃之火，乃一转而为燥渴，此即欲饮水者少，少与之即愈之证也，故渴为欲解，若水停心下，津液不能上润喉舌而渴妨胃邪充溢，渗入胃之上口，渴底胆火不能相容，乃至冲激而呕，此饮家所以先渴却呕也，若夫呕而不渴，则心下支饮方盛，胃中胆火不扬，此在痰饮篇为小半夏汤证，说详呕家本渴条下不赘。

问曰，病人脉数，数为热当消谷，引饮，而反吐者何也，师曰，以发其汗，令阳微膈气虚，脉乃数，数为胃热，不能消谷，胃中虚冷故也，脉弦者虚也，胃气无余，朝食暮吐，变为胃反，寒在于上，医反下之，令脉反弦，故名曰虚。

此经医者误治伤及中气之病脉证也，风寒袭表，皮毛间水气凝互，则病形寒，中阳不振，不能旁达四肢，则亦病寒（忍饥之人，多恶积畏寒，可为明证）恶寒同而所以恶寒者不同，设于中阳不振之恶寒，误认为麻黄汤证而居发其汗，则胃中阳气益虚，而脉反见数，脉数者汗后阳气挟营阴而外张，内藏之阳气将一泄无余，尽其脉虽数，要与脉迟不胜谷食者，同为胃中虚冷，故饮食入胃而反吐，为其一去不还，故为客热，膈气因寒而虚，故其气上逆，吸入胃之饮食，倾吐而出也。此胃气因误汗而虚冷者也，此条见太阳篇，阳热之证，肠胃燥实则病不能食，寒湿阻滞。胃气不降，则亦病不能食，不能食同，所以不能食者不同，设于寒湿阻滞之不能食，误认为大承气汤证而居下之，则膈上之寒湿并入胃中，而消化之力益微，脉乃转弦，弦为阴脉故痰饮水气谵证多有之水饮入胃，胃底胆汁不能相容，则病呕逆（痰饮卫证多呕皆不湿痰，而其脉俱弦，可知弦为胃中湿痰所致）尽胃中胰液饶涎，皆能消食，自误下之后，膈上寒痰入胃，与胃中原不之津液化而为一，中气既寒，消化之力愈薄，故食入停贮胃中，历一周时胃中胆汁抗行，因至朝食暮吐，所以变为胃反者胃中阳气既虚。他种津液与胆汁不和故也，此胃气因误下而冷者也。

寸口脉微，微则无气，无气则营虚，营虚则血不足，血不足则胸中冷。

玩此节原文，首句言寸口脉微而数，后文但言脉微，则而数二字当为衍文，尽人一身之血热度合华氏寒暑表九十五度，为血之中数，其应于动脉者，即为平脉，若热度渐低，营气不能上应，则其脉当迟，当弱至于两手动脉见微，则营气不足以应，而脉管血少，心藏主脉与血，部位正在胸中，血不足而脉道微，故胸中冷，营虚而血少，则太阳寒水，不得阳热蒸化，而卫阳不达于皮毛，脾阳不达于四肢，少阴病脉必微细者，水胜而血负也，水寒则胃败，故趺阳负少阴为不顺近人以呕吐清水为胃寒，其说要非无据，尤在泾乃谓胸中冷非真冷，不可以热治之，然则少阴病之脉微细，何以用四逆汤耶，要知用药之法，无问寒热，补泻，只在以偏救偏，但中病即止，而不当太过耳，尤在泾持论如此，无怪其偏信丹溪，不能入仲景之室也。

趺阳脉浮而嗇，浮则为虚，嗇则伤脾，脾伤则不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿杀不化，名曰胃反，脉紧而嗇其病难治。

趺阳脉为胃脉之根，当以冲和为正脉，若轻取见浮，重按见嗇，则胃气不降，宿食不下小肠，脾阳不升，不能吸收小肠津液上承心肺而为血，尽食入于胃，食气与脾气化合，上下相引乃掣制胃之全体，磨擦新食成浆，然后下渗十二指肠，无病之人所以知饥也，若脾阳顿滞，不能牵制胃之全体，上下磨擦则胃中所受之杀食不能消融成糜，以下渗十二指肠，胃底胆汁上抗遂至朝食暮吐，暮食朝吐，病名胃反（方治在后条）尽此证水饮入口即上泛，谷食入胃又以消化力薄，始则停蓄，继即倾吐，大肠宿垢积欠不行，一似阴干者，然大肠干涩不通，则胃浊愈加上泛，故脉紧而嗇，急则治标，要惟有于他方治中加大黄利之之法较为近似，否则胃浊不降。加以肠中否塞，其病乃益不可治也（牛硫丸似亦可用）

病人欲吐者不可下之，湿痰阻于胸膈则上泛而欲吐，致太阳将传阳明，则上湿下燥，固有当用瓜蒂散吐之者，尽湿邪粘滞非一下所能尽，或恐留滞肠胃，转为他病，为其病在上膈也，当见病呕逆之人，自用吴茱萸以止之者，腹中胀满欲死寝成里热，以致匝月昏愤，几于不救，由此观之，病人欲吐者，不惟不可下，并不可止为胸中自有湿痰也，内经不云在高者引而越之乎。

哕而腹满，视其前后知何部不利，利之愈。

寒热二气相冲激，则病哕逆，若阴阳电相触者，然故哕有寒热之别，湿痰留于上膈，真阳补变，有时冲激而上，不能相胜，则为寒哕，变热在下，鼻中吸入之清气与之冲激而上，则为热哕，然者哕而腹满者，究为何病，尽热结膀胱三焦水道不通，则由蓄水而肿满，是为五苓散证，热结大肠，腑气不通，则由燥屎而腹满是为大承气证，所谓知其何部不利，利之而愈也，释义详伤寒发微厥阴篇兹不赘（按此证大便不行者，下后呃止则愈，呃不止则死，予亲见之）

呕而胸满者，吴茱萸汤主之（吴茱萸汤方，吴茱萸一升，人参三两，生姜六两，大枣十二枚，上四味，以水五升，煮取三升，温服七合，日三服）

胃浊不降，脾阳不升，则气机否塞，呕而胸满者，脾虚生湿，中气寒而胃浊上泛也，尽脾藏吸收小肠津液上出胸中，胸中阳气充足则清者散为汗液，膏者上达心肺二藏，化而为血（西医谓之淋巴液）至不得噫暖，则胀满欲死，此其所以呕而胸满也，吴茱萸汤，吴茱萸以降逆散寒，人参姜枣以和胃扶脾，但使膈间阳气渐舒，咽中时得噫暖，或呵欠，或吐出痰涎，则胸满去而呕逆亦止，尽仲师虽言呕而胸满，其实由胸满而呕也。

干呕吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之

脾虚则生湿，胃寒则易泛，胃中无宿食则为干呕，胃中饶涎与胃底胆汁化合，并能助消化之力，胆汁太多，热乃上泛而吐苦水，饶涎太多，寒乃上泛而吐涎沫，干呕不已，胃中浊气上冲，因病头痛，故仲师但用吴茱萸汤，与上节呕而胸满同法，但使浊阴下降，头即不痛，此亦不治之治也（此条见伤寒论厥阴篇）

呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之，（半夏泻心汤方，半夏半升洗，黄芩、干姜、人参、甘草各三两炙，黄莲一两，大枣十二枚，上七味，以水一斗煮取六升，去滓再煮取三升，温服一升，日三服）

上膈寒湿，下陷于胃，胃底胆汁不能相容，则病呕逆，此属寒，宜用吴茱萸者也，胃中浊热合胆火上奔，则亦病呕逆，此属热，宜用黄莲者也，二证寒热不同，故降逆之药品亦因之而异，（近人不辨寒热，合黄莲用之，模棱之见耳）此节证象为呕而肠鸣，为心下痞变热在上，寒水在下，与伤寒胸中有热，胃中有邪，腹中痛欲呕吐之黄莲汤证略同，故半夏泻心汤方治，所用半夏、干姜、甘草、人参、黄莲、大枣皆与黄莲汤同，唯彼以寒变太阴而腹痛，用桂枝以达变，此为气痞在心下，热邪伤及肺阴，兼用黄芩以清水之上源，为不同耳，又按伤寒太阳篇云，但满而不痛者，此为痞，柴胡汤不中与之，宜半夏泻心汤，知此方原为治痞主方，所以不与腹中雷鸣下利之证同用，生姜泻心汤者，亦以水气不甚，不用生姜以散寒也。

诸呕吐，谷不得下者，小半夏汤主方（方见痰饮）

呕吐而不能食，为胃中虚寒，是宜吴茱萸汤者也，仲师乃曰诸呕吐谷不得下者，小半夏汤主之，然予当如法用之，往往失效，岂仲师之误耶，是不然，古人用小半夏多生者，但洗去泥耳，近来药肆所用，先以水浸七日，去膏液而留渣滓，去水之本性全失，再用生姜汁拌炒半熟欲其立止呕吐，岂可得哉，按呕吐一证，心下水气不甚，胃中虚寒者，则宜吴茱萸汤，水气太甚，时时泛滥而呕吐清水者，则宜生半夏生姜汤，仲师所谓纳半夏以去其水也。

呕吐而病在膈上，后思水者，解急与之思水者，猪苓散主之

猪苓散方

猪苓、茯苓、白术各等分

上三味，杵为散，饮服方寸匕，日三服

水气在心下则甚，在膈上则微，呕吐而病在膈上，则倾吐易尽，设渴而思饮，则水气已尽，其病当解，急与水以滋其燥而此外更无余病，伤寒论所谓少少与之愈也，若水气在心下而呕吐思水者，则当通下焦，特于五苓散中去桂枝泽泻以利小便，使下焦通，而在上之水气得以下行，上承之津液乃不为所阻，而渴饮自止矣，此亦伤寒太阳篇渴者宜五苓散之意也。

呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者，难治，四逆汤主之，（四逆汤方，附子一枚生用，生姜一两半，甘草二两炙，上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服，强人可大附子一枚，干姜三两）呕而脉弱，水胜而血负也，惟其水胜，则下焦必寒，故小便复利，（按此证，小便必色白不黄）浮阳外出而中无实热，故身热微手足见厥者，中阳虚而不达四肢也，此证纯阴无阳，自半夏泻心汤以下诸方，俱不全用，故难治，难治非不治也，尽舍四逆汤大温中下之剂，病必不愈，观方后列强人可大附子一枚，干姜三两，可以识难治之旨矣。

呕而发热者，小柴胡汤主之（小柴胡汤方，柴胡半斤，半夏半升，黄芩、人参、甘草、生姜各三两，大枣十二枚，上七味，以水一斗，煮取六升，去滓再煮取三升，温服一升，日三服）

凡疟病多呕，其脉必弦，所以多呕者，胆胃之气上逆也，故疟病用小柴胡汤，往往取效，然则呕而发热者，仲师虽不言脉寓意脉亦见弦，故亦宜小柴胡汤，柴胡以发汗，黄芩以清胆，参草姜枣以和胃，汗出而外解，则表热不吸引胆火，中气不至上逆而无呕吐之弊，此呕而发热所以与疟同法也。

胃反呕吐者，大半夏汤主之

大半夏汤方

半夏二升，人参三两，白蜜一升

上三味，以水一斗二升，各蜜扬之二百四十遍，煮药取二升半，温服一升，余分再服

反胃之证，大便如羊矢，艰涩而不下，类阳明燥矢，可用大承气汤以下之，况水气太甚，渗入于胃，胃底胆汁不受，因而呕吐，呕吐伤及胃阴，时时上泛，胃因不和，水气所以不降者，又因大肠干涸之故（胃中谷食，久不下十二指肠，肠中粪积一似阴干者然）故大半夏汤方治，生半夏以去水，人参以益胃汁，白蜜以润肠，使渣滓不通，水乃得降而胃成之病愈矣，（按世俗相传朝食暮吐，暮食朝吐方治，为熟地二两，山茱萸三两，牡桂一钱，又有脾胃虚弱食不消化方为秫米粉作汤圆子，每服煮食十粒，加醋吞服，一重用山茱肉，一用醋，皆能令干涸之粪发酵易化，附存之，癸酉闰五月十四日，裴德炎妻病此，予用姜半夏四钱，潞薰参一两，白蜜四两，三剂即便通能食呕止。

食已即吐者，大黄甘草汤主之

大黄甘草汤方

大黄二两，甘草一两

上二味以水三升，煮取一升，分温再服

食已即吐，所吐者为谷食，非饮水即吐之比，胃底法汁不能合胰液而消谷，反逆行而冲激于上，故食已即吐，但吐之太暴，虽有胆火上逆，要亦因大肠之壅塞，故方用甘草以和胃，大黄以通肠，肠胃通而胆火降，谷食乃得以顺受焉，此大黄甘草汤之旨也。

胃反，吐而渴，欲饮水者，茯苓泽泻汤主之

茯苓泽泻汤方

茯苓半斛，泽泻四两，甘草、桂枝各二两，白术三两，生姜四两

上六味，以水一斗，煮取三升，内泽泻再煮取二升半，温服八合，日三服

此证与病在膈上节略同，方治以利水为主，亦与思水之猪苓散相似，茯苓泽泻方治，于五苓中去猪苓以泄水，可知渴欲饮水，为水气阻于心下，津液不能上达喉舌，而初非真渴，所以加生姜甘草者，亦以水邪郁于胃之上口，辛甘发散以调之也，所以后纳泽泻者，亦以其气味俱薄不任多煎也。

吐后渴欲得水而食饮者，文蛤汤主之，兼主微风，脉紧头痛

文蛤汤方

麻黄三两，杏仁五十枚，大枣十二枚，甘草，石膏，文蛤各五两，生姜三两

上七味，以水六升，煮取二升，温服一升，汗出即愈。

吐后渴欲得水而食饮，似与前证吐而渴欲饮水者无别，何以前证用茯苓泽泻汤，此证独宜文蛤汤，此不可以不辨也，尽吐而渴欲饮水，为随吐随渴，随饮随吐，水气溜胃之上口而里无热之证，吐后渴欲得水而贪饮，为吐后之渴，水气出上膈而里有热之证，惟其无里热，故但疏阳气通小便，使水热自下焦泄之，惟其有里热，故上发汗而下泄热，使水气从上下二焦分泄之，夫各有所当也。

干呕吐逆，吐涎沫，半夏干姜散主之

半夏干姜散方

半夏，干姜各等分

上二味，杵为散，取方寸匕，浆水一升半，煮取七合，顿服之

始而干呕（俗名胃泛）继而吐逆（俗名胃寒，所吐清水）是水气从胃之上口渗入，胃不纳而上泛之证也，加之以吐涎沫，心下必有微饮，其所以异于头痛一证者，彼但为胃中浊气不泛，初无水气，故但用吴茱萸汤以降逆，此证吐逆，为膈上有水气，为胃中有寒，故用半夏干姜散以降逆而温中，徐忠可反以头痛者为重，此证为轻，殆不然也。

病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，澈心中愤愤无奈者，生姜半夏汤主之

生姜半夏汤方

半夏半升，生姜汁一升

上二味，以水三升，煮半夏取二升，内生姜汁煮取一升半，小冷分四服，日三准备一呕止，停后服

胸中为上焦升发水液之区，西医谓之淋能上能下斡，气与水由细管中散出，胸中之气乃得舒畅，否则乳糜顿滞，即化为湿痰，阻其上出之气，肺气欲纳而不能受胃气欲抗而不能伸，于是似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，肺气不达，胃气不通，上下得为噫暖，下不能转矢气，以致澈心中愤愤无奈，究其所以致此者，为其湿痰阻塞膈上，阳气被遏而不宣也。方用生姜汁以宣阳气之变，用生半夏以去水气之停，但使阳气通于上，湿痰降于下，胸中气机乃通达无所窒疑，而诸恙自愈矣。

干呕哕若手足厥者，橘皮汤主之

橘皮汤方

橘皮四两，生姜半斛

上二味，以水七升，煮取三升，温服一升，下咽即愈。

干呕及哕，皆出于胃气不和，但病之来源不同，故治法亦异，胃主四肢。胃气阻塞不能旁达四肢，故手足厥，要其所以致此者，不可以不辨也，水胜血寒，阳气不达四肢者，手足必厥，但必有兼证或为吐利交作，或为下利，其脉必细弱无力，此宜四逆理中者也，或湿痰与宿食交阻中脘，阳气不达于四肢，则手足亦厥，其人或咳或悸或小便不利，或腹中痛而泄利下重，此宜四逆散者也，若但见干呕哕之证，其脉必不微细，亦必无泄利下重之变，胃中阳气所以不达四肢者，要不过气机阻塞耳，故但用生姜以散上膈之变，橘皮以发胃气之闭，温服一升，而下咽即愈矣

哕逆者，橘皮竹茹汤主之

橘皮竹茹汤方

橘皮二斛，竹茹二升，大枣三十枚，生枳半斛，甘草五两，人参三两

上六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服

哕有寒热之别，哕而腹满，条及前条，已详言之矣，若但哕逆而别无兼证，在上无干呕，手足厥之变，在下无腹满之变，则但为中气之虚而微见胆火上逆，中气虚则阳气不能外散，而阻于膈上兼之胆火内变，于是吸入之清气与之相触，遂病哕逆，方以橘皮竹茹为名者，橘皮以疏膈上停阻之气，竹茹以疏久变之胆火，而哕逆可止矣，然哕逆之由起于上膈不散之气，胆火上冲，亦为此不散之气所变而气之所以不得外散者，实因中气之虚，故知皮方橘皮竹茹汤治标，大枣生姜甘草人参为治本，不然，但用橘皮竹茹亦足治哕矣，既愈之后得保其不得哕耶。

夫六腑气绝于外者，手足寒，上气肢缩，五藏气绝于内者，利不禁，下甚者，手足不仁。

气之行于六府者，水分之寒得血分之温，蒸化外出者为卫，血分温度不高，则水分不能化气达于皮毛之外而手足寒，水气留著上膈，里气阻而不出，外气吸而不纳，则为上气病，属太阳，肠胃燥热，大便不通薰灼阳明，支脉股下牵制右膝外兼屈而不伸，病属阳明，脾湿下陷，肾阳虚而不能泄水，溢入回肠，则利不禁是为阴气内

绝，脾主四肢，脾湿下陷，阳气不达，故手足不仁，甚则逆冷，仲师不言者尽即在不仁之内也，病属三阴，沉自南说不精，以肢缩为阳虚生寒，尤谬。

下利脉沉弦者，下重，脉大者为未止，脉微弱数者为欲自止，虽发热不死

脉沉弦为有水，此伤寒金匮之通例也，水与湿并，乃病下利，水流动而湿粘滞，故利而下重，此为四逆汤证为其寒湿下陷也，予治此证见脓血者，或用附子理中汤加柴胡升麻，所以疏变而消毒也，痛甚则加乳香没药，所以止痛也，此厥阴下利，虽下重而不宜凉剂者也，若夫寒尽阳回，则阳明脉大，是其始病寒湿而利不止，继乃寒湿变为燥热而利仍未止，是即后文下乃愈之证，宜用大承气汤者也，惟邪尽正虚，脉乃微弱，邪尽则利欲自止，阴尽阳回，脉乃微弱而兼数，则尤可决其利将自止也，此证虽脉数而渴，甚至发热圉脓血，但用清热去湿之白头翁汤，一二剂可愈故曰虽发热不死，不似肢冷，脉伏治以湿药而厥不还者，为必无生理也（此条见伤寒论厥阴篇）

下利，手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者死。

脾主四肢，脾藏虚寒，则手足厥冷，心主脉与血，心房血虚则无脉，欲温脾藏，莫如干姜甘草，欲强心房，莫如附子，则四逆汤其主方也，此为有脉者言之也，若血分中热度消歇，以主脉伏不鼓则非药方所及，手足依然逆冷，脉之伏者仍然不还而反见微喘，则是血虚于里，气脱于外，危在旦夕矣。

少阴负趺阳者为顺也

此句与上不接，当为另一条，尽少阴为病，每患寒湿下陷，但得寒尽阳回，即是生机，少阴病虽三急下证，及时而治皆可不死，为其以少阴而兼阳明也，故谓之顺

下利有微热而渴，脉弱者令自愈。

下利脉缓，有微热汗出，令自愈，设脉紧为解

下利一证，起于脾阳不升，而寒湿下陷，其脉当见沉紧，身冷无汗不言可知，尽阳气外散则脉见浮缓，太阳中风发热有汗者，脉必浮缓，其明证也，阴寒内据则脉见沉紧，厥阴下利，脉沉弦为下重，其明证也，是故下利一证，以出阳为顺，以入阴为逆，微热而渴者当复也，故皆令自愈而沉紧有力，不见缓弱之脉则为未解，缓字旧讹作数，陈修园不知此证为寒尽回阳，望文生训，反以为热利，夫热利为白头翁汤证，岂不药自愈之证耶。

下利脉数而渴者，令自愈，设不差必圉脓血，以有热故也，

人体之强弱视血热之存亡为进退，血热之存亡不可知，要当验之于脉，下利见阴脉，则难愈，见阳脉则易愈，其大较也，是故下利脉沉弦则病下重，由血热为水气所压，相抗于下部也，此为初病者言之也，病者脉微而厥则为下利清谷，由血中温度消亡而水气独胜也，此为病甚者言也，按其外证为恶寒，为肢冷，其里证为不渴饮，小便色白，莫不以阳气退为病进，至如下利脉数则血热渐高，加之以渴，则水气渐减，此即死阴尽去，生阳来复之佳兆，固当不药自愈，间亦有不即差者，则一变而圉脓血，此为阳回太暴然究非死证，白头翁汤，桃核承气汤，俱可随证酌用，要不当泥于始病之阴寒，而漫用桃花汤也。

下利脉反弦，发热身汗者愈。

下利一证，其脉始于沉弦，由沉弦而沉迟，由沉迟而沉微，其人因已垂死矣，若迟微之脉一变而为浮弦，则太阳寒水之气已受血热蒸化，将从皮毛外泄，仲师所谓反弦者，反之言转，弦之言紧，谓沉微之脉一转而成太阳浮紧之脉也，由浮紧而发热，由发热而汗出，则内陷之寒湿已从太阳外解，病有不愈者乎。

下利气者，当利其小便

下利一证，决无小便，此尽人之所知也，但仲师所谓下利气者，当利其小便，究属何因，其与后文气利用诃黎勒散止涩者究竟是一是二，此不可以不辨也，尽本节所谓下利气者，为方在下利肛门辟辟作声，一似转矢气者，气与腹中殊不相接，此利实关下焦（太阳篇，理中者，理中焦，此利在下焦，可与赤石脂，愚馀溢汤，不差当利其小便，即此证）

下焦阳气不通水道，闭塞气乃并注于肛门，于五苓散中重桂枝以达阳，合四苓以泄水，但令水泄于前，即气还其故而利自愈矣，若夫气利用止涩之诃黎散者，实因久利而气虚下陷，意与近人治晨泄用四神丸略同，予昔寓白克路，治乡人陶姓曾用之，所用为诃子壳，取其味涩能止，彼以药末味涩，不能下咽各入粥中，强吞之，日进一服，三日而止，与当利小便之证，病原固自不同也。

下利，寸脉反浮数，尺中自嗇者，必圉脓血

下利一证，其脉多见沉迟，而不应反见浮数为其寒湿下陷也，若浮数即为寒尽阳回而利将自止，但不应独见于寸而尺中自嗇嗇者，凝定不流之象，尽胞中血海凝嗇不通，气机不达于卫任是为瘀血，此证必见腹痛下达少腹，热在上，瘀在下，故必圉脓血也，此证不必治脓血，尽下利自止当从呕痈脓者，脓尽自愈之例，说解说伤寒论厥阴篇（如病者必欲服药，略用丹皮桃仁地鳖虫等味均可）

下利清谷，不可攻其表，汗出必胀满

下利清谷为太阳寒水不能作汗下，并太阴寒湿，冲激肠胃之证，太阳为寒水之府，少阴为寒水之藏，故在伤寒论中太阳少阴二篇不可攻表之戒，按胀满原属太阴寒证，下利清谷中阳垂绝，若更误汗，一线微阳外散，阴寒乃独据中宫，譬之一雍寒水，冬令坚水势将爆裂，设遇此变，惟大剂生附子以回阳，或当挽救一二，慎勿误认肝变也（近代医家多有此矣）

下利脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，必变冒汗出而解，下利清谷者，其人必微厥，所以然者，下虚故也。

下利一证，原属寒湿下陷而血热不能上抗，脉之所以沉迟也，若其面戴阳，而身有微热，即可知血分热度渐高，为寒尽阳回之渐，阳热内蕴，乃见变冒，变者身热而汗不居泄，冒者气上冲而呕之象也，此时心中极为懊农，逮肺与皮毛中含之水气，为阳热蒸逼乃澈，然汗出而愈矣，若夫下利清谷一证，其人必脉微肢厥，肠胃中阳气垂绝，所谓下虚者，久利而虚寒也，此为四逆汤证，学者不可不知。

下利后，脉绝手足厥冷，啐时脉还，手足温者，生脉不还者死，心主脉，下利脉绝，则心房血寒，脾主四肢，下利手足厥冷，则脾阳已绝，欲强心房，莫如生附子，欲温脾阳，莫如干姜，甘草，则四逆汤基主方也。假令服汤后一周时，心房得温而脉还，脾阳得温而手足热，则其病可以不死。尽此证不惟手足厥冷而肢体常有冷汗，粘腻如膏油，所下之物白如猪膏，又似冬月之肉炼，病者自觉脑中轰轰有声，久则魂飞账顶，身摇摇如坠万丈深潭，背有所著，则忽然惊觉，日数次，直待阳回之后，敛神魂始定，尽去死不远矣，予十五岁时，侍先严乘生公疾亲见之，尽始服高康泉芩莲汤而加剧，继服陈子雍外祖芩芍汤而病益不支，厥后，延赵云泉先生方用制附子五钱，吴萸三钱，干姜四钱，炙甘草三钱，五味子三钱，公丁香三钱，吉林参三钱，二剂后，手足始温，若服药后脉绝不还，则一身精血俱寒，虽有虜扁，无能为役矣，敬告同人，倪涵初症利三方，慎毋轻用而杀人也。

下利后，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温表宜四逆汤，攻表宜麻黄汤

下利而腹胀满为太阴寒湿内据，前于不可攻表条下，已详言之

身体疼痛则由太阳寒水，为表寒所变，不能化汗液而出皮毛，先温其里，后极其表，此为伤寒通例，温里固宜四逆，救表实用麻，伤寒论中太阳厥阴二条，此本条并为桂枝，不可盲从

下利，三部脉皆平，按之心下坚者，急下之，宜大承气汤

今之论治者，遇脉证不符之证，或从证不从脉，或从脉不从证，此意实本仲师即如

本节下利三部，脉皆平，而无滑大坚实之象，但不在急下之例，然按之而心下坚，心下当胃之上口，今按之而坚，胃中必有宿食梗塞，致上下之气不通，设在上之梗塞一日不去，则下利一日不止，此其所以法在急下，而不当从脉者也

下利，脉迟而滑者，实也，利未欲止，急下之，宜大承气汤

下利，脉迟为寒湿在里，血分不敌水分之证，尽胃为生血之原，胃所以能生血者。实关于胃底消食之胆汁，胆火盛而纳谷多，则富其生血之原而脉数，胆火虚而纳谷少，生血之原不足，故脉迟，按伤寒阳明篇云，脉迟食难用饱，饱则微烦，头眩必小便难，汗出不恶寒，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外已解，可攻里也，若汗多微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤，此太阴阳明同病，湿留肌腠表气不达，不当攻下之明证也。若脉迟而兼滑，则为内实，阳明篇又云，谵语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之，此即脉滑当下之例，尽病者内藏有所停蓄，则其脉滑是故上膈有湿痰者滑，妇人任娠者滑，肠胃宿食不去则亦滑，按此证必兼腹痛，故必通肠胃壅塞，然后痛定利止，此所以当急下也。

下利脉反滑者，当有所去，下乃愈宜大承气汤

下利之脉多沉迟，为其寒湿下陷也，若沉迟之脉转为滑疾，则阴脉转阳，其病必腹痛拒按，反之言转也，谓脉之本不如是也，病固有前一日甫用附子理中汤，后一日即当用大承气汤者，予昔年治江阴街肉店范姓男子亲见之，尽湿以下利而日消，寒以湿药而顿，尽胃中宿食不能与之俱去，故前此之缓痛喜按者，一变而为急痛拒按，则舍大承气汤外，岂复有愈疾之方治乎。

下利已瘥，至其年月日时复发者，以病不尽故也，当下之，宜大承气汤（见伤寒论阳明篇，又见瘥病）

血热盛壮之人，遇天气酷蒸，往往以多汗而胃中化燥，始则大便不行，继则口燥饮冷，夏令伏阴之体饮冷太暴，或且转为下利，究之利者自利，胃中燥实，依然不去，故仍宜用大承气汤以下之。予湘人辛未六月在红万字会治一山东人亲见之，一剂后不再来诊，尽已瘥矣。壬申六月，复见此人来诊，诊其脉，洪大而滑疾已，疏大承气汤方治矣，其人曰，去岁之病，承先生用大黄而愈，湘人告以亦用大黄，其人欣然持方去不复来，尽又瘥矣，又江阴街烟纸店主严姓男子，每年七月上旬，大便闭而腹痛，予每用调胃承气汤，无不应手奏效，殆亦血热太高，暑汗经其排泄胃中易于化燥，可见此证不忌冷饮，则湿流太阴部分而兼下利，不敢饮冷，则但病大实满痛，要之为承气汤证，若仲师所云下利已瘥，至其年月日复发为病不尽，世岂有病根不拔能安然眠食，待来岁，今日而复发者乎，故知病不尽为仲师失辞不可为训。

。

下利谵语者，有燥屎也，小承气汤主之（小承气汤方，大黄四两，枳实三枚，厚朴三两炙，上三味，以水四升，煮取一升二合，去渣分温二服，得利则止）

大便燥结之证，当有谵语为肠胃浊热上蒙脑气，心神为之恍惚也，若夫下利一证，正复不当谵语，仲师主以小承气汤，而决其有燥屎，按此即世俗所谓热结旁流，张隐庵注伤寒论以此证为必无特未观其通耳，说解说伤寒论厥阴篇，不赘。

下利便脓血者，桃花汤主之（桃花汤方，赤石脂一斤，一半全用，一半研末，干姜二两，粳米一升，上三味，以水七升，煮米熟，去滓，温服七合纳赤石脂末方寸匕，日三服，若一服愈余勿服）

下利便脓血，为少阴寒湿沉浸血络腐败之证，陈修园以为由寒变转为湿热，因而动血，此真大误，水分多于血分，不及注肾膀为溺乃溢入回肠而下利，水寒血凝，若冻家然，冻家既溃，即有脓血，下利便脓血者，正复如是非温化其寒而填止其湿，不惟下利不止，脓血又将加剧，此固寒水凝瘀血络，积久溃败之证，非寒变转为湿热，然后动血也，尽寒湿下注为第一病因，故桃花汤方治，以止涩之赤石脂为君，由寒湿浸灌，致内藏血络腐败为第二病因，故干姜次之，由下利而脾精耗损，为第三病因，故粳米又次之，假令当小便不利腹痛之时，早用四逆理中，或不至下利而便脓血也，余详伤寒论少阴篇，不赘。

热利下重者，白头翁汤主之，（白头翁汤方，白头翁二两，黄连、黄柏、秦皮各三两，上四味，以水七升，煮取三升，滓去温服一升，不愈更服）

热利之别于寒利者，热利之证，臭秽逼人，往往不可乡迹，而寒证无之，热利之证身热而气粗，面垢而色浮，而寒证无之。热利有滑大动数之脉，而寒证无之，兼此数者，乃能如航海南针，不迷所向，究其所以下重者，则以湿热并居，阻塞气分，秽物不得宣泄也，白头翁汤方治，用白头翁秦皮，以清凉破血分之热，黄连黄柏以苦燥而兼凉性者，除下焦之湿，于是湿热立去，气无所阻而利自止矣。所以不用气分药者，湿热去而气自通也。若后人所用香连丸即治此证，而识解已落后一层矣（按此与前一条对文，使人知寒热之辨）

下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，栀子豉汤主之

（栀子豉汤方，栀子十四枚擘，香豉四合绵裹，上二味，以水四升，先煮栀子得二升半，纳豉煮取一升，去滓分二服，温进一服，得吐则愈，按方后末八字，宜从张氏删之）

心下当胃之上口，胃中燥热，则薰灼心下而烦，固自有阳明燥证，虽经下后，心中懊侬而烦者，则下利后之更烦，安知非胃中有燥屎宜大承气汤之证，但有燥屎者，

心下必硬，今按之而濡可见烦为虚烦，尽下利后津液消耗，阴不抱阳，由是在表则浮阳不收，在里则余热不去，变结而生虚烦，甚有反覆颠倒用中窒塞及心中热痛者，然究为病后余邪，故但用豆豉以发表汗，生山栀以降里热，而虚烦可解，所谓在表者散而去之，在高者引而下之也（栀子生用，下走大肠，伤寒太阳篇，病人旧微溏者不可与之，其明证也）

下利清谷，里寒外热，脉微欲绝，汗出而厥，通脉四逆汤主之（通脉四逆汤方，附子一枚生用，干姜三两，强人可四两，甘草二两炙，上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服）

下利清谷，为完谷不化，胃中阳气消亡之证也，胃底消食之胆汁日见薄弱，不能消入胃之水饮，乃挟未化之杀食直下小肠，大肠是为里寒，寒据中宫，逼真阳外浮，是病外热，外热则汗出，里寒则手足厥逆，以病情论，里寒为真外热为假，里寒外热下原胶脉微欲绝四字，说详伤寒发微中，尽阳亡于外而脉微欲绝，故方治为通脉四逆汤，用生附子一枚以强心房，而脉之伏者，起以心主脉故也，干姜四两炙甘草三两以助脾阳，而手足之厥逆者，温以脾主四肢故也，里寒外热，真阳外浮，外内不通，故加葱九茎以通之，寒凝血瘀，腹中必痛，故加芍药以疏之，此仲师用通脉四逆之旨也。

下利肺痛，紫参汤主之

紫参汤方

紫参半斤，甘草三两

上二味，以水五升，先煮紫参，取二升，内甘草煮取一升半，分温三服

下利一证，未闻有肺痛者，且肺痛当是何病，所痛之处究系何部分，究竟是寒是热，历来注家绝无分晓，此所当研核者也，按内经云，一阳为病，善咳善泄，尽少阳之火，下注则为泄利，上注于肺则为咳，燥火上迫肺有所壅，乃至咳而肺痛，则此证为热而非寒也，然则痛在何部分，曰其痛当在胸中，予当见病肺痛之人，肠中当隐隐作痛，此即痛在胸中之明证，致本书肺痛方治为桔梗甘草汤，尽桔梗以泄壅，甘草以除毒，而肺痛可止，陈修园疑紫参为桔梗之误，理或然也

气利，诃黎勒散主之

诃黎勒散方

诃黎勒十枚煨

上一味为散，粥饮和顿服

说解详上下利气者，节兹不赘，诃黎勒今名诃子，味涩而苦，煨不透则研不细，入咽梗塞，前于同乡陶姓亲验之

疮痈，肠痈，浸淫病脉证治第十八

诸浮数脉，应当发热而反洒淅恶寒，若有痛处当发其痈

凡外证初起，必先恶寒，此其大较也，尽痈之所由成，血络闭于寒湿而营气不通，营变生热脉乃浮数，血以凝涩而内停，则阳气不能独行于表分，此所以当发热而洒淅恶寒也，遇此脉证，虽形似伤寒，而实为痈疽，始则恶寒，继则发热，寒热日作，若疔发然数日后，瘀血蕴蒸化热，始知痛处，此与将溃之，冻家正复相似，无论在何部分，皆当以药发之，大约人体外证之属寒者，除流注外，发背脑疽，最为重大，惟世传阳和汤一方，与仲师当发其痈之旨最合，若误投寒凉败毒之品，十不活一，所以然者，为血络凝于寒湿，非疔毒流火属于阳证者比也，附阳和汤方

阳和汤方

麻黄三钱去根节，炮姜三钱，熟地黄一两，鹿角胶三钱，肉桂一钱，寒重加附子

师曰，诸痈肿欲知有脓无脓，以手掩肿上，热者为有脓，不热者为无脓

痈毒初起，以肿大见红色为顺，而皮色不变平塌不起者为逆，大率由寒而热，由热而肿，由肿而痛，痛剧则瘀血蒸化为脓，痛减则脓已成，身亦渐凉，扶而去之，疮口掩以拔毒生肌药，其证立愈，此因痛减而知有脓之说也，仲师验脓之法，则以肿处热不热为验，此又以热而知有脓之说也，予按痈疽大证，必有极大之脓前沿，坚硬不化，疮上极热灼手处，即为脓头所在，以刀扶之，百不失一，仲师之言，则固信而有微也。复有体虚未易肿大者，或妇人病在下体，未便开刀者，仙方活命饮，成效卓著，当附存之

附仙方活命饮方

乳香，没药各二钱，炙甲片五钱，皂角刺三钱，防风一钱，大贝四钱，生甘草二钱，归尾二钱，生黄芪三钱，赤芍四钱，银花三钱，排脓加白芷，上药水煎服，即日止痛，脓成自溃，未成即消。

肠痈之为病，其身甲错，腹皮急如肿状，按之濡（此下与后条错简，今校正）时时发热，热汗出，反恶寒，其脉迟紧者，脓未成，可下之，大黄牡丹汤主之，脉洪数者，脓已成，不可下也（三句旧误在上，今校正）

大黄牡丹汤方

大黄四两，牡丹一两，桃仁五十个，冬瓜仁半斤，芒硝三合

上五味，以水六升，煮取一升，去滓，内芒硝，顿服之，有脓当下如无脓当下血。

肠衰一证，由于血凝气滞，阴络内阻，营气干涩，不能外润腠表，则肌腠为之甲错，甲错者血枯之象也，在里之气血不通，乃成内痈，此证始以水寒而血凝，继以血凝而腐烂，若冻家然，日久化热，即成溃疡矣，血阻于内，气膨于外，故腹皮之急如鼓，但有气而无水，故按之濡时发热，自汗出，复恶寒者，肺与大肠为表里，皮毛为肺所主，肠内病痛，邪热薄皮毛，故时发热，热胜而皮毛开，故自汗，汗后毛孔不闭，风乘其虚故复恶寒，脉迟而紧则里热未盛，毒血尚凝聚未散，不难一下而尽，所谓曲突从新也，以其大肠壅阻也，用大黄芒硝以通之，以其身甲错知其内有干血也，用桃仁丹皮以攻之，以发热自汗复恶寒，知大肠移热于肺，肺主之皮毛，张于标热而不收也，用泻肺除热之冬瓜仁以清之，此大黄牡丹汤之义也，若夫里热既盛，脓成血溃，至于两脉洪数，则非一下所能尽，仲师不曰脓已成赤豆当归散主之乎。（方见百合狐惑篇中）究其所以，不可下者，譬之流寇，溃散则难为攻，不如方聚之易为殆也，当记癸丑十一月，若华之母病此，腰腹俱肿，有时发热自汗，有时不甚发热，痛不可忍，按之稍定，于冬至前二日，用大黄五钱，丹皮一两，桃仁五十粒，冬瓜子八十粒，芒硝三钱，服后腹中腹痛，午后下血半净桶，而腹平痛止，不啻平人矣，辛未四月，强鸿培嗣子福全病此，既京宝隆医院矣，西指为盲肠炎，并言三日后大开刀，福全不解，私间看护以破腹告富全惧，弃其衣而遁，翌日，抵予小西门寓所以腹中剧痛求诊，尽下经三次而腹痛止矣，又壬申午治大白鸣钟慎大衣壮裘姓少年亦如之，癸酉年治陵姓少女腹右旁痛，痛经四月，身体瘦弱，西医不敢开刀，由同乡高长佑推荐，予以此方减轻授之，当夕下泥，黑粪痛未止，稍稍加重，遂大下黑粪，如河泥，其痛乃定，调理一月，方能出险，尽亦危矣。己亥八月，四明史惠甫寅此，已由姜佐景用前方下过，未能拔除病根，予用生大黄五钱，冬瓜仁一两，桃仁八十粒，丹皮一两，芒硝三钱，外加当归赤豆，二诊加赤芍五钱，败酱草五钱，所下黑粪并如污泥状，病乃出险并附记之。

肿痛者少腹肿痞，按之即痛，如淋小便自调，腹无积聚身无热，脉数，此为内有痈脓（内字上有肠字误）薏苡附子败酱散主之（腹无积聚下，一旧讹在上节，今校正）

薏苡附子败酱散方

薏苡仁十分，附子二分，败酱五分

上三味杵为散，取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服，小便当下

肿见于外，谓之肿痛，不类病在大肠，气膨腹皮，但见肿伏也，按此节所列病状，曰少腹肿痞，按之即痛，如淋小便自调，显系少腹疽，伤寒太阳篇少腹硬满，小便自利者，下血乃愈，又云少腹硬小便不利者，为无血也，小便自利其人如狂者，血

证谛也，此可见病在血分者，水分必无疑，今少腹肿痞，按之即痛如淋小便自调，与少腹硬而小便自利有何差别，病当在胞中血海，岂得更谓之肠痈，且以证情论，小便自调下，当与上节腹无积聚连属为薏苡附子败酱散证，观于方治后小便当下字，但可决为少腹肿痞证，方治断非其身甲错之方治矣，肿痞在少腹，上不及脐，如知腹无积聚病根即在少腹，不似标阳内陷，故身无热，但据少腹肿痞按之即痛如淋之病状，加之以脉数，便可知血已成脓然则肠内有痈脓实为内有痈脓之误，要知证虽化热，病原实起于肾寒，血海遇寒而凝，凝则痛，久而化热，血之凝者腐矣。故方治十倍利湿开壅之薏苡而破血热排脓之败酱草半之，略用生附子以解凝而止痛，数不及败酱之半，然后少腹之脓乃得从小便中出，予直决其为少腹疽，王鸿绪以为患在少腹之内为小肠疽，陈修园又以为小肠痈，俱谬误，不然少腹承下焦水道由肾藏出，与小肠之下自接大肠者，何尝有丝毫干涉耶，曾记辛未正月，予子妇人妹嫁江阴北门外程姓者病此，尽准备剧痛不能安睡，小介时时出，粘腻白物，有时微带红色，所出不过一滴，出之先痛不可忍，赴医院求诊，西医饮以药水，七日不减，其夫以病状来告，予用重剂仙方活命饮加当归四两，向杂量肆买赤豆一升，先煎后入他药，阴以茶铤嵩入医院，伪言开水服之，半小时即能安睡，明日用原方二剂肿消，月余生一子，尽此证多出妊娠之妇，凉由气血凝聚化热，伤及血海所致学者幸致意焉。

问曰，寸口脉浮微而嗇，法当亡血，若汗出，设不汗出者云，何曰，若身有疮，被刀斧所伤，亡血故也。

人之一身，皮毛之内，尽含水分，水分所以能化气外泄者，全恃周身之血热，血热之盈亏不可知，以寸口脉为之验，脉微而嗇是为阴虚，阴虚之人或吐血，或盗汗，是为虚劳本证，今见此极虚之脉，既不吐血，又无盗汗，病既不属虚劳，则其人必有夙疾，或身有疮疡而脓血之扶去者过多，或向受刀创而鲜血之流溢加剧，虽境过情迁，而营气既衰，断不能复充脉道，尽脉之虚正不系乎新病也。

病金疮，王不留行散主之

王不留行散方

王不留行十分，八月八日采，蒺藜细叶十分，七月七日采，桑东南根白皮十分三月三日采，甘草十八分，黄芩二分，川椒三分，厚朴二分，干姜二分，芍药二分

上九味，前三味烧灰存性，各别杵节合为散，服方寸匕，小疮即粉之，大疮但服之，产后亦可服

此方有桑皮之润，厚朴之燥，黄芩之寒，椒姜之热，大致金创流血，创口干燥增痛，故宜润，血去既多，湿寒停阻脾阳，故宜燥，血虚则生内热，故宜凉，血分热度

以亡血而低，中阳失运宜温，而终以通利血脉止金创血为要，故以王不留行，蒺藜细叶为方中主药，而芍药佐之，又复倍用甘草以和诸药，使得通行表里，此王不留行散之大旨也。

排脓散方

枳实十六枚，芍药六分，桔梗二分

上三味杵为散，取雉子黄一枚，以药散与雉黄相等，饮和服之，日一服

予按此方之上，脱去病证，以方治重用枳实当为胃痛

排脓汤方

甘草二两，桔梗三两，生姜一两，大枣十枚

上四味以水三升，煮取一升，服五合日再服

按此为肺痈方治，故与桔梗汤同

浸淫疮从口起，流向四肢者可治，从四肢流来入口者不可治，浸淫疮黄连粉主之（方阙）

浸淫疮为脂水流溢之通称，说详藏府经络篇，黄连苦寒能清大毒，许半龙治疗毒重用之，往往取效而其性尤燥。能去湿热，湿热既去，疮中脂水乃不至蔓延流溢也，然则黄连粉方虽阙，其意则大可知也。

跌蹶手指臂肿转筋狐疝虫病脉证第十九

师曰，病跌蹶其人但能前不能却，刺腓入二寸，此太阳经伤也。此湿从下受之证也，跌蹶为足背经脉转戾，其人能前不能却，要为寒湿伤筋之证，昔大禹因治水，久居湿地病湿，至于两足不相过，后世巫者效之，谓之禹步可为明证，仲师所云刺腓二寸，断为太阳经伤者，尽太阳之经入中贯腓内，出外踝之后至小指外侧，寒湿伤其经脉，血瘀不通，故强直而不能却，刺腓二寸正所以泻此瘀也，惟近世内科能用针者少，予尝患右臂竣痛，自肩至于尺泽，长女昭华用毛姜四两，川乌三两，草乌五两，红花二两，良姜一两，每准浓煎薰洗，月余竟愈，则寒湿伤经，似亦不妨用之也。

病人当以手指臂肿动，此人体润润者，藜芦甘草汤主之（方阙）

内经云，风胜则动，湿胜则肿，仲师言手臂肿动，身体润润，此可知为风湿痰涎走窜，指臂延及周身之证，与风癰证略同，特风癰无此表证耳，按子和儒门事亲云，一妇病风癰，其始一二年发后即日发，甚至日数发，求死不得，什凶岁采野草充粮，见草若葱状，采蒸饱食，胸膈间胀闷顷之涌吐胶痰，数日，约一二斗，甚昏困，后遂轻健如平人，以所食葱访人，即藜芦也，尽风痰内壅，积久旁窜，积者为本，窜者为标，用藜芦者，涌吐而扶其壅也，所民用甘草者，恐藜芦苦寒败胃，甘味以调之也，近癰证有日服控涎丹一钱，久而自愈者，亦所以去痰涎也。

转筋之为病，其人臂脚直，脉上下行，微弦转筋入腹者，雉矢白散主之

雉矢白散方

雉矢白为末，取方寸匕，以水六合和温服

转筋入腹之病，予未之见，原其病情则与痉证之宜大承气汤者略同，痉证云，脚攀急，与此证臂脚直又何异，痉证燥热，阴液垂绝，故急下以极之，所以除里热也，此证用下气破积通利大小便之雉矢白散，亦所以除里热也，所以然者，里热不除，则筋脉受灼而不得柔和，故必通其大肠，使阳明燥气内熄而筋脉乃和，考葛仙方中头足往后扯动，弯曲不伸其形如弓，用雉矢白三钱，酒五杯，用竹箸搅千遍，日服二次，予按此即痉病之卧不著席证，痉病自中风传来，易于化燥，内藏燥而筋脉受灼，以致全身强急，故借内经治膨胀之雉矢酖以下之，尽亦金匱用大承气汤之义也。然则转筋用雉矢白散，亦何独不然乎。

阴狐疝气者，偏有大小，时时上下，蜘蛛散主之

蜘蛛散方

蜘蛛十四枚熬，桂枝半两

上二味为散取八分一匕，饮和服，日再蜜丸亦可

此寒邪并少阳湿热并注睾丸之证也，湿热偏注，睾丸一胀一否，则偏有小大，发时胀而偏坠，不发则如平人，故时时上下，以其病在下体，与蚀下为狐同例，故谓之阴狐疝，蜘蛛破瘀消肿，昼隐夜出，为阴类之虫，取其下入阴部，桂枝通阳宣变，能达肝胆沦陷之气，破瘀则寒湿不凝，通阳则变热外散，而偏坠可愈矣，予昔在同仁辅元堂改散为煎，治愈二人，用桂枝三钱，蜘蛛一枚炙存性，一人二剂愈，一人一剂愈，章次公王慎轩皆亲见之。今则相隔久远，并病者，姓与居址而忘之矣，乙亥重九日，有倪姓来诊，其证时发时止，今以遇寒而发，偏坠微痛，夜有寒热，睡醒汗出，两脉迟滑，方用大蜘蛛一枚炙过，川桂枝四钱，一剂即愈，此为前病肠痈之史惠甫介绍，并附记之。

问曰，病腹痛有虫，其脉何以别之，师曰，腹中痛，其脉当沉，若弦反洪大故有疣虫。

此从脉象之异，决其为有虫之痛也，凡腹痛沉为寒湿下陷，直四逆汤证耳，脉弦为肝邪乘脾，直小建中汤证耳，若不沉不弦而腹痛，则既非寒湿内停，又非肝胆郁陷，故可决为虫痛，然洪大二字，亦为仲师失词，脉不足据当以病状参验之，不然岂大实满之阳明证，其脉独不洪大耶。

疣虫之为病，令人吐涎心痛，发作有时，毒药不止者，甘草粉蜜汤主之

甘草粉蜜汤方

甘草二两，白粉二两即铅粉，白蜜四两

上三味，以水三升，先煮甘草取二升，去滓内粉蜜搅令和煮，如薄粥温服一升，差即止。

疣虫之为病，常起于脾藏寒湿，由寒湿积为水痰，少阳之气不达于三焦，水痰感少阳生气，乃生疣虫，涎生于痰涎，故其腹多涎，疣饮吐涎，胃不能容，随即倾吐而出，此所以令人吐涎也，心痛者，心下窜痛，疣上入膈故痛，非真心痛也，疣安静则如平人，窜动则痛欲死，故发作有时此疣病之大概也，然竟有毒药不能奏效者，则以病者曾用杀虫猛药，剂量太少，疣虫醉而不死，后遂狡避不食也，故不能猛攻，莫如诱劫，不得已而用甘草粉蜜，使虫贪蜜之甘而不知铅粉之毒，此亦陈人畏宋万多力使妇人饮之酒醉而执之之计也。用甘草者，欲病人有受铅粉之毒也，先母侍婢曾患此，始病吐疣一二日后，暴厥若死，治以乌梅丸，入口即吐，予用甘草五钱

，先煎去滓以铅粉二钱，白蜜一两调饮之，半日许，下疣虫如拇指大者九条，其病乃愈，然时医辄非笑之，夏虫不可语冰稟其然乎。

疣厥者其人当吐疣，今病者，静而复时烦，此为藏寒，疣上入膈，故烦，须臾复止，得食而呕又烦者，疣闻食臭出，其人当自吐疣，疣厥者，乌梅丸主之（乌梅丸方，乌梅三百个，细辛六两，干姜十两，黄连一斤，当归，川椒各四两，附子，桂枝，人参，黄柏各六两，上十味，异捣节，合治之，以苦酒渍乌梅，一宿去核，蒸之五升米上饭熟捣成泥，和药令相得，内白中，与蜜杵二千下，丸如梧子大，先食饮服十丸，日三服，稍增至二十丸，禁生冷滑臭等食）

疣厥非手足逆冷，乃心下暴痛，病者目珠上出，螟然若死之谓，间亦有痛极而手足冷者，要其立名之义，正不在此也，按此证丸药不效，不妨改丸为汤，曾记无锡强福全未病肠痛时，先病腹痛，痛无定时，忽作忽止，知为虫，已服丸半斤矣，痛如故后即改丸为汤，二剂而差，说解详伤寒论，兹不赘

妇人妊娠病脉证治第二十

师曰，妇人得平脉，阴脉中弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之，于法六十日当有此证，设有医治逆者，却一月加吐下则绝之。

妊娠之脉，关后有余，尺跳动，右甚为女，左甚为男，此历试不爽者也，今师云妇人得平脉，阴脉小弱，何乃适得其反，尽妊娠停经之初，本无他病故脉如平人，血凝子宫，胎气尚微故阴脉小弱，非如四五月后，胎气壮盛之比，月事既停，统血之脾藏顿滞，脾精之上输者少，故渴，脾阳失运，消谷之力微，故不能食，更有湿痰停阻胸中时欲呕者，俗称恶阻。仲师不言也，尽已统于不能食中，非脱漏也。凡见此证，脉平而表无寒热，即可断为妊娠，主以桂枝汤者，所以助脾阳而疏胸中水气也（方解详伤寒发微太阳篇）所以六十日方见此证者。为始停经时中气尚疏，上中二焦未有所觉也，此证不当治渴及呕，治之为逆，设治渴而误用清燥滋阴之品，胃中心寒，设治不能食而误投下药，脾湿又将下陷，治不得法，后一月必加吐下，中气败也，绝其药并斥其医，庶几勿药有喜乎。

妇人宿有癥病，经水断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，此为癥痼害，妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也，下血者后断三月，衃也，所以不止者，其癥不去，故也当下其癥，桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸方

桂枝，茯苓，丹皮，桃仁去皮尖熬，芍药各等分

上五味，末之炼蜜丸如兔屎大，每日食前服一丸，不知加至三丸

欲安食民，必除盗贼，欲养良苗，必除莠稗，此尽人之所知也，然则欲孕妇之安胎，不去其宿疾可乎，设宿癥不去，或经断未及三月，即有漏下之变，所以然者，养胎之血，不能凝聚子宫，反为宿癥所阻，从旁溢出，胎失所养则动在脐上，其实胎元损，癥痼害之也，然亦有三月后而胎动下血者，其证亦为癥，仲师言六月动者，赅四月至六月言之耳，前三月经水通调，忽然中止，当可决其为胎，若经断三月之后，忽然下血，其为衃血横梗，不能融洽何疑新血与衃血不和，因不渗漏之隙，不下其癥胎必因失养而不安，仲师设立桂枝茯苓丸，以缓而下之，尽癥之所由成，起于寒湿，故用桂枝以通阳，茯苓以泄湿，丹皮，桃仁，赤芍则攻瘀而疏达之，固未可以虚寒漏下之治治也，间亦有寒湿固癥之证，阻隔腹中，不下血而胎元不足者，曾记丁卯新秋无锡华宗海之母经停十月，而腹不甚大，始由丁医用疏气行血药，即不觉胀满，饮食如常人，经西医考验，则谓腹中有胎，为腐败之物压住不得长大，欲攻而去之，势必伤胎，宗海邀予赴锡诊之，脉啬不滑，不类妊娠，当晚与丁医商进桃核承气汤，晨起下白物如胶痰，更进抵当汤，下白物更多，胀满悉除，而腹忽

大，月余生一女，母子俱安，孙子云，置之死地而后生，稟其然乎。

妇人怀妊六七月，脉弦，发热其胎愈胀，腹痛恶寒少腹如扇（平声）所以然者，子藏开故也，当以附子汤温其藏（见伤寒）

怀妊六七月，胎已长成，血凝于下，热度不高，太阳寒水化气者少，脾藏乃气虚生湿，寒湿内壅，故胎胀流入足太阴部分，故腹痛，脾阳不能外达，故发热而恶寒，弦脉为寒，水湿凝固，此伤寒金匮之通例，以为肝病者，谬也。间有肝乘其虚，故先用小建中汤以实脾，凡脉见弦急，俱为水胜血寒，胎气张于内，少腹膨急而子藏开，风寒袭之，故少腹如扇，如扇云者，谓逐阵冷气相逼也，附子汤方用附子以温肾，肾下水道接膀胱，故温肾而少腹自暖，茯苓白术人参以泄水而扶脾，湿邪去则寒热止而胎胀平，芍药能调阴络阻滞故治腹痛，伤寒论所谓腹痛加芍药也。

师曰，妇人有漏下者，有半产后因续下血不绝者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻胶艾汤主之

胶艾汤方

干地黄六两，川芎，阿胶，甘草各二两，艾叶，当归各三两，芍药四两

上七味，以水五升，清酒三升，合煎取三升，去滓内胶，令消尽，温服三升，日三服，不差更作

妇人妊娠，有宿癥不去，致经血妄行者，前既出桂枝茯苓丸方治矣，但经血妄得，不能一致有下少数之血，相续不绝者，有因半产，气虚不能摄血，续下不止者，有冲激大下者，设妊娠见此证，但腹中痛脐上不见跳动者，即为内无宿癥，宿癥利用攻，无癥则利用补，胞中之血不得上行冲任二脉，阻塞下陷，故名胞阻胶艾汤方，地黄，阿胶以养血，川芎，艾叶以升陷而温寒，炙草以扶统血之脾，归芍以行瘀而止痛，而下血腹痛愈矣。当记丁巳年治潘姓漏下证，用仲师方治，改两为钱，服后腹中胀甚，二日而漏下止，二十日后生一男，今十七岁矣。

妇人怀孕，腹中疝痛，当归芍药散主之

当归芍药散方

当归，川芎各三两，芍药一斛，茯苓，白术各四两，泽泻半斛，上六味，杵为散，取方寸匕，酒和日二服。

妇人怀孕，全恃养胎之血，因怀孕之故，周身气血环转较迟，水湿不能随之运化，

乃停阻下焦而延及腹部，此即腹中疴痛所由来，方用芎归芍以和血，并用茯苓泽泻，白术以泄水而去湿，但令水湿去而血分调，疴病自止，尽治病必伏其所主，宿食腹痛，则治以承气，得下即痛止，寒利腹痛则治以四逆理中，寒去则痛止，肝乘脾腹痛则治以小建中，脾安则痛止，疣虫腹痛则治以乌梅丸，虫下则痛止，皆不泛用止痛之药，当归芍药散之治孕妇疴痛，亦犹是耳，自世多不识病原之医士，乃有通治之套方，而古法寢芜矣。

妊娠呕吐不止，干姜人参半夏丸主之

干姜人参半夏丸方

干姜，人参各一两，半夏二两

上三味，末之，以生姜汁糊为丸梧子大，饮服十丸，日三服

妊娠之妇，经血下停，上膈当然湿阻，故六十日后当见干呕不能食之证，惟湿困脾阳，不妨竟用桂枝汤，但得脾阳略振胃气自和，若夫湿积成水停蓄心下，渗入于胃，胃中虚寒，遂有呕吐不止之变，法当去水温中，仲师因立干姜人参半夏丸方，但令心下之水，与胃中之寒并去，呕吐自定，但半夏一味，决宜生用，并不可浸去麻性，以半数之干姜掺杂，又加姜汁为丸，入口必然不麻，否则药精华而用渣滓，以之泄水，恐无济也。

妊娠小便难，当归贝母苦参丸主之

当归贝母苦参丸方

当归，贝母，苦参各四两

上三味，末之炼蜜丸如豆大，饮服三丸，加至十丸

小便难而上焦无热，则下焦水道不利，不由浮阳吸引可知，饮食如故，则心下又无水气，当见妇人淋带多者，湿痰必少，见湿痰上泛，淋带即少，则此证要由血虚生热，湿痰下注成淋，阻塞水道所致，贝母本去痰之品，亦主淋涩，此即湿痰与淋带随发异名之确证，方用当归贝母苦参丸，当归补血，苦参泄热，此为妊娠大法，而主要则全在贝母一味，为其去淋涩之瘀塞而小便始通也，所以用丸不用汤者，则以湿浊粘滞非一过之水所能排决也。

妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之

葵子茯苓散方

葵子一升，茯苓三两

上二味杵为散，饮服方寸匕，日二服，小便利则愈。

妊娠之妇，血凝气弱，入胃水饮运化较难，故有气留积心下，上泛而呕吐者，亦有阻于膀胱，淋涩不清而小便不利，由肌及表，阳气不通，则洒淅恶寒水气上乘，不凌心而犯头目，则心下不悸而起即头眩，葵子茯苓散专以滑窍利水为主，其病当愈，葵子滑胎而不忌者，所谓有故无陨亦无陨也。

妇人妊娠宜当服当归散

当归散方

当归，黄芩，芍药，川芎各一斛，白术半斛

上五味杵为散，酒服方寸匕，日再服，妊娠常服即易产，胎无所苦，产后百病悉主之

妊娠之妇，血凝而气聚，血凝则易生热，气聚则易生湿，湿热相搏，则病腹痛，当归散所以为常服之品也，归芍川芎以和血，内芩以清热，白术以燥湿，但令湿热清而血脉和，其胎即安，后世医家有胎前宜凉之说，由此方用黄芩始也。

妊娠养胎，白术散主之

白术散方

白术，川芎，蜀椒去汗，牡蛎各三分

上四味杵为散，酒服一钱匕，日三服，夜一服，但苦痛加芍药，心下毒痛倍加川芎，心烦吐痛不能食饮加细辛一两，半夏大者二十枚，服之后更以醋浆水服之，若呕以醋浆水服之复不解者，小麦汁服之，已后渴者，大麦粥服之，病虽愈，服之勿置。

人体有强弱，强者血分多于水分，而热度常高，弱者水分多于血分，而寒湿为胜，观当归散与白术散之异，知胎前宜凉之说不可为训也，寒水太胜，则血热被压，下陷而不能升，白术散方白术以燥湿，牡蛎以泄水，川芎以升陷，蜀椒以散寒，但令寒水下泄，血温上升，其治即安，况水盛血虚之人，养胎尤为不易。

故仲师于当归散，后别无曙益之药，独于本方之后，辨证加药并出善后方治，何其郑重分明乎，此无他，水微而血盛不过热变生燥，不似水胜血寒者，必有坠胎之变也，血瘀则腹痛，故加芍药以通络，水停心下，收藏血变，故加升陷之川芎水泛凌心寒渍入胃，以至心烦吐痛（此痛与具饮内痛同）不能食饮，故加细辛，半夏以去水而蠲饮，服以醋浆者所以平胆胃而止呕也，不解以小麦汁服之者，以小麦养心除烦，兼能利水故也，若夫病已而渴常服大麦粥者，以病原起于血虚，胃为生血之原，和胃降逆，俾能食饮，正所以补虚也。

妇人伤胎，怀身腹满，不得小便，从腰以下重如有水状，怀身七月，太阴当养不养，此心气实，当枣泻劳宫及关元，小便微利则愈。

此承上养胎，旁及失养之证也，尽胎得养则安，失养则伤，但胎气营养不惟外借药力，抑更视其本体，初受胎二月，肝液养之，胎气安静，三四月胆火养之，胎至是而始动，五六月脾精养之，脾藏多湿，腹至是而始大，七八月肺阳养之，肺主气，故气充而液下济，九十月肾阴养之，肾主水故腹以多水而益大，设令肺阴养胎之期为湿邪凝阻不能下济，湿之所聚，太阴气化不宣，因病腹满，气闭于上，水吸于下，故不得小便，第观其腰以下重，如有水状，便可知病在下焦矣，水气篇云，肿在腰以下，当利小便，非阴证欬，但膈上气疏，利用从膈上气闭便当曲治，所以然者，不宣上气，无论五苓散，猪苓汤百无一效。正恐愈利而愈塞也，湿停于中，心气不得下交，则变而上逆心气实者，非心气自实，以有所阻隔而然也，脉中营气不动，脉外之卫气不得独行，心气闭于上，则肾气窒于下，故故掌心之劳宫，脐下之关北朝鲜，上下两泄，令小便微利即愈，譬之今人开煤油铁箱，上下各开一钉眼，以器下承之，油自从钉眼出，若但有下眼，便涓滴不出矣，附难产方法。

妇人临产有先下水一日而小儿不下者，有气血两虚小儿欲出不出者，长女昭华制方活人甚多，壬申冬十一月，长子湘人之室，亦以下水一日用之附录之，以告存心济世者，尽一举而救人二命也。方用生潞党二两，当归三两，牛膝四两，上三味，浓煎顿服食顷即产，尽取其气血两补，并利用牛膝之坠胎也，气分充满者，去党参加牛膝一两。

妇人产后病脉证治第二十一

问曰,新产妇人有三病,一者病痉,二者病变冒,三者大便难,何谓也

师曰,新产血虚多汗出,喜中风,故令病痉,亡血复汗,寒多故令变冒,亡津液胃燥,故大便难。

妇人怀孕周身血及水液尽资养胎之用,至于临产养胎之血及水液,载胎以出,譬之顺水行舟,随舟下,产后血液虚耗下不待言,阴亡于内,则阳张于外,阴耗阳张,故令肠胃内燥,肌腠外疏,营魄弱而汗液泄,风乘其虚始则中风,风燥伤筋因转为痉,此即栝蒌桂枝汤证也,脾为统血之藏,血虚则脾精不行,肠胃燥而大便难。此即脾约,麻仁丸证也,血分与阳气合则温,与阳气离则寒,西医谓血中无气者妄也,但内含而不外散耳(血中无气安有热度)产后妄血,而阳浮于上,阳浮则表虚而汗出,阴寒袭虚,内藏微阳逆不能支,因致变而上冒,若暴厥状,此桂枝去芍药加龙骨牡蛎汤证也。以上三证,并为亡阳伤津要其为大便之难则一,设不大便无所苦不妨徐俟,津液之复,大便自通,虽不治亦可也。

产后变冒其脉微弱,呕不能食,大便反坚,但头汗出,所以然者,血虚而厥,厥而必冒,冒家欲解,必大汗出以血虚下厥,孤阳上出故头汗出,所以产妇喜汗出者,亡阴血虚阳气独盛,故当汗出,阴阳乃复,大便坚呕不能食,小柴胡汤主之。

此申上节变冒大便难出而发明,其病理非谓小柴胡汤可通治,变冒大便难也,仲师所以不出方治者,正以证有轻重,剂量可随时增减也,至不明病理而妄治之,则殆矣。证情由于血虚自当以养血为主,是故产后血虚,不惟桂枝去芍药加龙骨牡蛎为治标之法,而初非正治,即仲师小柴胡汤亦为大便坚呕不能食而设,亦非通治变冒,变冒之脉所以微弱者,亦由血虚,血虚则肝阴亏而胆液生燥,少阳之气上逆,则呕不能食,呕则胃燥,津液不能下溉大肠而大便坚,故治此者,但需小柴胡汤以平胆胃之逆,使膈上津液足以下润大肠,诸恙可愈,若夫虚阳上浮则但头汗出,阴虚阳越,则卫不与营和,但令助营气之弱便与卫气相接,其病自愈,曰冒家欲解,必大汗出乃愈者。此即藏无他病,先其时发汗则愈宜桂枝汤之例也。如营气过弱异于血实不行,即当去芍药,阳气上盛,吸水不降,即当加龙骨牡蛎,可以片言决也,陈修园乃谓小柴胡汤通治变冒及便难,有是理乎,予当治湖南曹姓妇产后冒风恶寒泄泻之证,经前医两进小柴胡汤,泄泻虽止,而壮热头晕,多汗而喘,一身尽疼,恶露不行,予谓产后百脉空虚,风寒易入,此即恶寒泄泻所由来,此时不用温中补虚,反用解外之小柴胡汤张发其阳气,因有发热头晕之变,瘀血为阳气,吸引不得下行,故身痛,阳气变冒于上,故多汗而喘,予即认定虚寒,用潞参三钱,炙黄芪三钱,熟地黄二两,归身五钱,附子三钱,麦冬四钱,外加姜枣一剂而浮阳减,继以胶艾汤而恶露通,夫小柴有心汤能致变冒,岂有本变冒而反用小柴胡汤之理,早间见仲师此方,专为大便坚呕不能食而设,尽以止少阳之呕逆,留胃液而润肠燥,

并欲下行之腑气，不为浮阳吸引也，仲师恐人误为变冒方治，故于节末另担大便坚，呕不能食两层，二者之中又以呕不能食为主，然非好学深思心知其意，固未易为浅见寡闻道也。

病解能食，七八日更发热者，为胃实，宜大承气汤主之

病解能食，则胆胃气平而呕吐止，胃中津液得以下润大肠矣，（小柴胡汤重用黄芩，令人大便泄，屡验）乃至七八日更发热者，此必非阴虚生热可知也，但按其脉而滑大，便当乘胃气之强，用大承气汤以攻之，所谓曲突从新也，独怪近世医家，遇虚羸之体，虽大实之证，不敢竟用攻剂，不知胃实不去热，势日增及其危，篇而始议攻下，有惜其见几不早耳。

产后腹中疝痛，当归生姜羊肉汤主之，并治腹中寒疝，虚劳不足（疝音较急也，陈修园以为缓痛，殊谬误）

产后下血过多，其人水分不足，则因虚生燥而大便难，水分过多则因虚生寒而腹中疝痛，当归生姜羊肉汤，当归以补血，生姜以散寒，羊肉以补虚，而疝痛可止，惟治腹中寒疝虚劳不足，宜于本方中加生附子一枚，非惟去病兼能令人有子，予于赵振声妻张氏亲验之，尽前此所以不孕者，以其有痛淋也（每痛必下白物一滴）服此方而痛淋止矣。

产后腹痛，烦满不得卧枳实芍药散主之

枳实芍药散方

枳实烧令黑勿太过，芍药各等分

上二味，杵为散，服方寸匕，日三服，并主痈脓，大麦粥下之

产后腹痛有三，一为虚寒之痛，上节所谓疝痛是也，一为蓄血之痛，后节枳实芍药散治之有愈者是也，一为胃实血不流行之证，即此烦满不得卧者是也，血少而不能交会于心则烦，胃气顿滞则满，胃不和则胀满而不得卧，方用芍药以通血分之瘀，枳实以导胃之滞，并用大麦粥，以调养肝脾，但使血分通调中气舒畅，烦满自止，烦满止然后营卫调适，卧寐坦然矣。

师曰，产妇腹痛，法当以枳实芍药散，假令不愈者，此为腹中有瘀血著脐下，宜下瘀血汤主之，亦主经水不利

下瘀血汤方

大黄一两，桃仁三十个，庶虫三十枚去足熬，按此即地别虫

上三味，末之，炼蜜和为四丸以酒升煮丸，取八合顿服之，新血下如豚

前证为血少不能流通兼胃浊失降之故，故其腹痛，虽与虚寒有别要犹未为实证也，惟用前方不效者，乃可决为产后瘀血，而利用急攻胞中之血，由冲任吸引而上者，经脐下为冲要，故血瘀必著脐下，按下瘀血汤方治，大黄桃仁与抵当同，惟用庶虫而不用郅虫水蛭则与抵当异，此二方所以不同者，要不可以不辨也，产后血去既多，不同经闭之证，故不用吮血之虫类，恐兼伤及新血也，庶虫生于废秽之中，善于攻窜，而又不伤新血，故于产后为宜，虽亦主经水不利，气体虚羸者，或宜之，要末可去坚癖之干血也。

产后七八日，无太阳证，少腹坚痛，此恶露不尽，热在里，结在膀胱也（二句旧认为节末，今校正）不大便，烦燥发热，切脉微实，日晡时更们烦躁发热，（此句旧认在日晡句上，无理今校正）不食，食则谵语，至准夜即愈，大承气汤主之

产后七八日，无太阳证，则不病瘕乃变冒，可知，若少腹坚痛则为产后恶露不尽，外虽无热，正以热结在里而血瘀胞中，此节尽借热入血室，引起阳明实证，故热在里二语，当在恶露不尽下。今在节末，则传写之误也，设证情为热入血室，则营气夜行于阳，当得夜分谵语，设但见不大便烦燥发热，犹难断为阳明实证，惟切其脉滑大而实，乃可断为胃家实，加以日晡所太阴湿土当王，阳气衰而地中水气上行，此时不能稍抑其阳气，反见心中烦乱而手足无所措，热势倍于日中，即可断为阳明亢热，且不食则已，食即谵语，至准备中阴盛之时，谵语反止，其不为热入血室而为阳明实证明矣。仲师言宜大承气汤者，恐人误认为桃核承气证也，曾记戊辰年高长顺女病此二十余日，已更数医矣，其证能食，日晡所必发壮热，脉大而实，予用生大黄四钱，厚朴二钱，枳实四钱，芒硝三钱，一剂热余，即系此证，愚按更倍发热四字，当在日晡时烦躁下，伤寒论以日晡所发热属阳明可为明证，反在日晡句上亦误特订正之

阳旦汤方

桂枝三两去皮，芍药三两，甘草二两炙，生姜三两切，大枣十二枚劈，附子一枚，牡桂四两

产后之证，肌表空虚，中风较易续，续云者，以其虚而易受，故时乘而续受也，续而复续，因致数十日不解，头微痛，恶寒时时有热，此皆太阳中风，桂枝汤的证，太阳中风，肌腠闭而皮毛开，故汗出，湿痹肌肉，内困脾阳，故心下闷，伤寒论所谓紧在太阴也，湿在心下，胃不能受，则为干呕，皮毛之浮汗，但泄水气而肌理之营气不得，故虽至数十日，阳旦证依然不减，仍当用桂枝加桂并加炮附子一枚之阳

旦汤，以助里阳而发肌理之汗，其病方愈，所以加牡桂附子者，桂枝汤治其水病

病久而里阳虚，非加桂附以助之，肌理之汗不出也

产后中风发热而正赤，喘而头痛，竹叶汤主之

竹叶汤方

竹叶一把，葛根三两，防风，桔梗，桂枝，人参，甘草各一两，附子一枚炮，生姜五两，大枣十五枚

上十味，以水一斗，煮取二升半，分温三服，覆使汗出颈项强，用大附子一枚，皮之如豆大，前药扬去沫，呕者加半夏半升洗

产后中风发热起于血去过多而营气虚寒，风本阳邪易于发热，不似寒邪外薄皮毛之内，水气生寒，必待营热内抗然后发热也，但发热而面色赤，则阳变于上，与恶寒时时有热者异，喘而头痛则与头微疼者亦异，夫面正赤为胃热上薰，痰饮篇可证也。然产后体虚，岂宜胃家未实，加大黄以利之，此一难也，中风表证未罢，固不应急攻其里，但在表之浮阳，吸阳明浮热上升，于清热一层，岂宜置之不论而本体又甚虚寒，此二难也。惟喘而头痛，究为风热相搏，竹叶汤方治，竹叶葛根以清胃热，防风，桔梗以散风而定喘，余则仍从阳旦汤意，去芍药而加入人参，所以去芍药加人参者，则以阴虚不任苦泄而急于营养之故，伤寒少阴下利，真武汤去芍药吐下后液亏，桂枝白虎二汤加人参，此其例也，予早年闻北京产妇三日后即服吉林参汤，一月后，产妇气体如未产时，此其明证，又按本方清太阳阳明风热，温脾藏之虚寒与桂枝加葛根汤，栝蒌桂枝汤用意略同，不使阳邪内陷经输，发为柔痉，倘亦上工治未病之旨乎。

妇人乳中虚，烦乱呕逆，安中益气竹皮大丸主之

竹皮大丸方

生竹茹，石膏各二分，桂枝，白薇各一分，甘草七分

上五味，末之，枣肉和丸，弹子大，饮服一丸日二夜三服，有热倍白薇，烦喘者加枳实一分

妇人乳汁为精血所脂，常见乳子之妇，终年月事不行，可为明证，乳中虚者，或产妇体本虚羸，纳杀减少，或因小吮乳过多，乳少不能为继，于是营阴不足，心中烦乱，胃纳既少，生血之原本自不足，加以无压之吸吮，引动胆胃之火，发为呕逆，

仲师出竹皮大丸方治，竹茹，石膏以清胆胃之逆，三倍甘草以和中气，减半桂枝白薇以略扶中阳而清里热，更用枣和丸，以扶脾而建中，但令胃热除而杀食增，则生血之原既富，胆胃之上逆自平矣。

产后下利虚极，白头翁加甘草阿胶汤主之

白头翁加甘草阿胶汤方

白头翁，甘草，阿胶各二两，秦皮，黄连，柏皮各三两

上六味，以水七升，煮取二升半，内胶令消尽，分温三服

产后下利，寒热不同，今胆云下利虚极，白头翁加甘草阿胶汤主之，此仲师之失辞，不可为训者也。夫热利下重，则为白头翁汤证，加甘草以补中，阿胶以养血，亦第为热利虚极而设，夫产后血瘀不行，腐败而下利为热，血去过急因而受凉而下利为寒，予当于丙午六月治梁姓妇人，因产后纳凉下利腹痛，予用附桂炮姜，略加白头翁秦皮，一剂而利止，所以用白头翁秦皮者，以新产不无血热也，所以去黄连柏皮者，以暴受新凉不胜苦寒也，若必执成方以治病，与乡愚用单方何以异哉。

妇人杂病脉证治第二十二

妇人中风七八日，续来寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之

妇人中风，延至七八日，适当经水初断，热除身凉，既而续发寒热，发作有时，不似病中风时昼夜无间，虽在中工，亦当知其非桂枝汤证，究其所以然则以经水初断，标阳乘虚而陷血室，因是血结胞中，乘营气夜行于阳，发为寒热，旦即明了，一如疟之休作有时，但热邪甫陷胞中定无干血，故但需小柴胡汤，使标阳之陷而入者，升发而出之，其病当愈，更不须桃核承气也，此虚实之辨也。

妇人伤寒发热，经水适来，尽日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室，治之无犯胃气用上二焦，必自愈。

伤寒始病，有已发热未发热之别，妇当伤寒发热之期，经水适来，则胞中之血未虚，发热则周身血分热度高，以至高之血热合始行之经血热乃并入血室，卫气尽行于阳，水分无热，故明了。营气夜行于阳，血分有热，故暮即谵语，如见鬼状（俗称热昏）

此证血热在下，但需攻瘀。其病当已，所谓血自结下之愈也，断不可因谵语而妄用承气汤伤及胃气，亦不可发太阳之汗，损上中二焦水液，致血热益无控制，桃核承气汤，抵当汤丸，下瘀血汤，皆足以治之，陈修园乃以为无方之治深于治，尽未识仲师之旨也。

妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除脉迟身凉和胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之。

中风当翕翕热之候，仍不免啬啬恶寒，此时病气全在肌表，在妇人虽经水适来，决无里证，乃得病七八日，脉迟身凉，则肌表邪热已解，似可无余病矣，乃一变为胸胁下满，如结胸状，设为太阳标热并水气结于胸胁，要惟有硬满而痛，不当谵语，谵语为阳明实证所常有，但此谵语当如上节之发于暮夜，不在旦尽，以七八日经水适来推之，便可知标阳内陷血室，所以然者，经后血室空虚，邪热易为入也，热陷在经后，必无干血为患，故但刺乳旁一寸之期门，以泻肝胆之热，诸恙自平，尽胸胁主上中二焦，肾下至膀胱属下焦，并为少阳部分，热变胸胁，则犹未及下焦，随少阳之热结于上中二焦者，先刺期门经泻之，不使下陷胞中，久成干血，所谓曲突从新也。

阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出，当刺期门，随其实而泻之，识然汗出者愈。

阳明为病，往往血热炽盛，迫水液而外泄，血热炽而肠燥，故谵语，水液涸于自汗，故阙上痛，斯二证，虽不下血，亦在所必有。若妇人病此，但头汗出，而一身无汗，似不当见谵语，则谵语固不由肠燥也（非大承气证）太阳阳热随三含糊则陷胸中，则为蓄血，蓄血者不下血，今乃热血妄行，则此证又不同血结也（非抵当证）尽水液不外泄，与热并居，若沸汤，然随三焦而下陷胸中血海之血乃被灼而横溢，故惟泻期门以泄肝胆之变，使血分之热得以外达表皮，俾皮毛水分，受血热而蒸化成汗，则热退而病解矣。

妇人咽中如有炙肉，半夏厚朴汤主之

半夏厚朴汤方

半夏一升，厚朴三两，茯苓四两，生姜五两，苏叶二两

上五味，以水一斗，煮取四升，分温四服，日三夜一服

湿痰阻滞，咽中气机不利，如有物梗塞，吐之不出，咽之不下，仲师于无可形容中，名之曰有炙肉，即俗所称梅核气也，方用姜夏以去痰，厚朴以宽胸膈，苏叶以开肺，茯苓以泄湿，务令上膈气宽，湿浊下降，则咽中出纳无阻矣。此方癸酉二月于四明刘姓男子为小异耳，又接近世效方，有用半青半黄梅子，以食盐淹一昼夜，取出晒干，再淹再晒，以盐水干为度，每用青铜钱二枚夹二梅子麻札入磁瓶封固，埋地下百日取出，每用梅子枚含口中半刻，咽中梗塞即消，当附存之（曾记早年居乡时，见城隍庙道士宋左丞治咽喉痛胀闭塞，用青梅破开去核，中包明变烧灰研末，和皂角末少许吹入，吐出痰涎无算，咽喉即通，足见酸味之青梅当别具挥发性，不当如旧说之收敛矣。

妇人藏燥，悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠喜伸，甘麦大枣汤主之

甘麦大枣汤方

甘草三两，小麦一升，大枣十枚

上三味，以水六升，煮取三升，分温三服亦补脾气

师但言妇人藏燥而不言何藏，然病情方治可知也，肺主悲，亦主哭，悲伤欲哭，病当在肺，凡人倦则欠伸，精神强固则否，所以数欠伸者，脾阳不振而中气怠也，凡人饮食入胃，由脾也散津上输于肺，脾精不能运输，则肺藏燥，肺阴虚则主气之藏窒塞，故悲伤欲哭，方后别出亦补脾气四字，可知病机专属肺藏矣。方用甘麦大枣，专取甘未之药，俾脾精上输于肺，肺阴既充，则下足以贯注百脉，外足以输精皮

毛，内外调达，气机舒畅，略无抑变不和之气，悲伤欲哭之证，乃可不作，曰如有神灵者，甚言不能自主也。

妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞，当先治其吐涎沫，小青汤主之，涎沫止，乃治痞，泻心汤主之。

膈间有寒饮，乃吐涎沫，此宜温药和之者也，乃不用温药而反下之，上膈水痰断不能一下而尽，加以卫气不行，水气变于皮毛之里，一经误下，在表水液乘虚入里，乃留积心下而成痞，正恐反被吸引，不得下达，尽先解表而后攻里，此固伤寒金匱之通例也。

妇人之病，因虚积冷结气，为诸经水断绝，至有历年血寒积结胞门，寒伤经络，凝坚在上，呕吐涎唾，久成肺痿（旧认作痛，今校正）形体损分，在中盘结，绕脐寒疝，或两胁疼痛，与藏相连，或结热中，痛在关元，脉数无疮，肌若鱼鳞，时著男子非止妇，身在下来多（来旧认作未，今校正）经候不匀，令阴制痛少腹恶寒，或引腰脊下根气街，气冲急痛，膝胫疼烦，奄忽眩冒，状如厥颠（旧认巅，今校正）或有夏惨，悲伤多嗔，此皆带下，虚实紧弦行其针药，治危得安，其虽同病，脉各异源子当辨记，勿谓不然。

此统述妇人经水之病也，人之一身，水分与血分平均，乃无有余不足之弊，若血分不足，水分不受血热蒸化，则寒凝气结而月事不行，血凝气结则痛，不及此时用附子汤以温子，至有历年寒伤胞门，癥瘕凝涸而坚癖，虽用抵当汤合桂枝茯苓丸下之，犹恐其无济也，大抵水寒血变之证，久必生热，若冻家然，始则寒凝而痛，久乃热变而溃，故有寒在上焦者，始则呕吐涎唾，久变则成肺痿，肺痿肺痛篇云，肺痿或从呕吐，亡其津液，与此呕吐涎唾久成肺痿正同，尽液伤而燥，病在外不比血热壅阻，病在肺藏之里，外燥为痿，里实为痛，故肺痛但有辟辟燥咳，必无呕吐，此云痛者误也。内经云肺热叶焦，乃生痿痹，上痿下痹，故曰形体损分，或寒湿据于中部，出胃入肠，绕脐而痛，是名寒疝，此证脉必弦紧，寒在外则恶寒，在里则不欲食，发即白津出，手足厥冷，此大乌头煎证也，其痛连两胁，牵制肾藏，甚则痛及少腹，此血虚水寒之当归羊肉汤证也。所谓热结于中者，亦缘水寒血凝，积久生热所致，始则痛，痛久则腐烂，瘀血生热，则脉数，外无疮疡而血瘀在里，血不行于肌表，故肌表鱼鳞，此虚劳大黄廬虫丸证也。此证下后血必纯黑，下之不早必至虚极而死，癸酉正月，予于四明陈姓少年见之其证，肌腠甲错，腹部外皮焦黑，按之刺手，渴饮，澈夜不寐，大便累日不行，予因其内有干血也，用百合地黄合桃核承气轻剂，当晚下黑血算下后觉恶寒甚，天明肢厥脉伏，病家大惊，乃就近延四明某医士投以炮姜附子，脉出身和，后予以附子理中继之，已得安睡并能食，病家以为无患矣，后闻于六七日，病例者一寐不醒，尽干血虽去而正气不支矣，然后欢时著男子非止女身之说，信而有微也，在下未多于义未通，当系来字之误，温经汤方后月水来过多，当即此证，否则上既有血结胞门一证，此更别出经候不匀一证，

岂得谓之未多耶，间月再来或经行多日，以致前后参差不一，皆得以来多名之厥阴之络入于阴中，血亏而络燥，故令阴制痛，血海在少腹左右，血海不温，故少腹恶寒，腰为藏，后通督脉，水湿壅滞，阳气不通，则本藏及背脊痠疼，气街为足阳明动脉，在腿腹之交，亦名气卫，此脉由髀关抵伏兔，下膝月实循经外廉，下至足跗，寒湿上阻，阳气被压，故气冲急痛，膝胫疼烦，此脉水藏不足，则燥而制痛，为阳明之大承气证，水湿太过，阳气内陷，乃见此证，肾藏寒水一日不泄，阳气一日不通，桂枝芍药知母汤，麻黄附子细辛汤，俱可参酌用之，血虚之人，往往猝然眩暈，颠仆道左，状如厥颠者，谓如暴厥而颠仆也。此证西医谓之脑贫血，治此者宜大补气血，近代所传防眩汤，大有成效，此证气血两虚，气虚则多悲，血虚则善怒，忽然颠仆，忽然悲哭，忽然嗔怒，状若神灵所作，其实非有鬼神，昔人谓之带下病（凡血虚阴亏痠瘕蓄血之类皆是，不专指淋涩）始病不觉，久乃羸瘦，此证多由血虚生寒，故但曰脉虚多寒，而无脉实多热之证。妇人有十二痠九痛七害五伤三因，其三十六病，变端百出，皆当决之天脉，脉左为阴，属精与血，右为阳，属气与水，或水盛而血寒，或液枯而血燥，而论脉终以紧弦者，紧则以始病气结于外，在内之血热犹足与之相抗，至于沉弦，则水寒而血热消沮矣。治此者或针泻期门，或针引阳气，血结者，气实，药以泻之，水寒者阳虚，药以温之，所以针药异同者，谓验其脉而知病原不同也，此节或仲师自述师承，或门人述仲师之训，与全书文体不类，或亦因论列妇人杂病而附存之歟。

问曰，妇人年五十所病下利，数十日不止，暮即发热，少腹里急腹满，手掌烦热唇口干燥，何也，师曰，此病属带下，何以故，曾经半产瘀血在少腹不去，何以知之，其证唇口干燥，故知之，当以温经汤主之。

温经汤方

吴茱萸三两，当归，川芎，芍药，人参，桂枝，阿胶，丹皮，生姜，甘草各二两，半夏半升，大枣十二枚

上十二味，以水一斗，煮取三升，分温二服，亦主妇人少腹寒，久不受胎兼治崩中去血，或月水来过多，及至期不来。

据内经女子，七七四十九而天癸绝，则妇人年五十所而病下利，数十日不止，似与月事无关，但营气夜行于阳，今病者暮即发热，病在血分，可知，加以少腹里急，则瘀当在膀胱血海，腹满为脾湿下陷，手掌烦热唇口干燥，脾精不得上行之象也，以病原论，当用大黄庶虫丸，以现状论，当用附子理中丸，然则师何以指为带下证，所用者乃为温经汤，治远因而不据近因，不可不求其故也。尽带下之证，寒湿下注而浮阳上升，下寒故少腹急，上燥故唇口干，尽此妇旧有淋浊，少腹常急，究其远因则以曾经半产，少腹留积败血，久而腐化乃下白物，寒湿从之，历年不愈，津液下渗，故唇口燥，积瘀不尽，故少腹急，此二证，为未经下利时所恃有，今淋涩

中止，而病下利，知其血寒湿胜，陷入大肠，瘀血业经腐烂，故不用大黄庶虫丸病不在中而在下，故不用附子理中汤，用温经汤者，推其原以为治也，方中芎归芍胶丹皮，以和血而通瘀，桂枝以达变而通阳，生姜半夏以去水，麦冬人参甘草以滋液而润上燥，吴茱萸疏肝燥脾，温中除湿，故不治利而利可止也，予按此为调经统治之方，凡久不受胎经来先期后期，或经行腹痛，或见紫黑，或淡如黄浊之水，施治无不愈者，曾记寓华废坊时，治浦东十余年不孕之妇，服此得子者六七家，江阴街四明范姓妇亦然，此其成效也。

带下，经水不利，少腹满痛，经一月再见者，土瓜根散主之

土瓜根散方，

土瓜根，芍药，桂枝，庶丸各三分

上四味，杵为散，酒服方寸匕，日三服

带下经水不利，少腹满痛，其为胞中蓄血，可知血瘀则生热，血分有热故经一月而再见，且行经之期，既以有所阻疑不得畅遂，余血停顿，遂与后月正期经水合并充溢，不及期而先事排泄，满者必溢，理固然也，土瓜即王瓜，味苦性寒，能驱热行瘀，黄瘿变黑，医所不能治，用根捣汁，平旦温服，午刻黄从小便出，即愈，此可证通瘀泄热之作用，芍药能通凝闭之血络，故疡科方书常用京赤芍庶虫即地别虫，生窠下乱柴尘土中，善攻积秽，不穴坚土，故大黄庶虫丸下瘀血汤用之。伤科亦用之，取其不伤新血也。用桂枝者，所以调达肝脾，变凝结为疏泄也，此土瓜根散之旨也。

寸口脉弦而大，则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名曰革，妇人则半产漏下，男子则亡血失精（原本无末句，当系浅人删去，特补出之，并删旋覆花汤主之及方治）此节一见于虚劳，一见于吐衄下血，二篇皆无方治，多男子则亡血失精七字。尽节末但有妇人句，语意近未举也，不知何时浅人将末句删去，又将肝著方治旋覆花汤入，药不对病，此又何足致辨，若钱乙所谓半产漏下，气已下陷，焉有用旋覆花下气之理，特为中下人说法耳。妊娠篇不云妇人漏下及半产后下血不绝，胶艾汤主之乎，然则无干姜者为胶艾汤加干姜即为胶姜汤，方治即在后一节，本条特为后一节补出脉象，原本固无方治也，说解详前。

妇人陷经漏下，黑不解，胶姜汤主之

胶姜汤方（即胶艾汤加干姜，见千金方）

此承上节虚寒相搏言之，以虚寒之故，因病漏下，病由出于寒湿下陷，故名陷经，

因寒湿下陷而瘀血色黑者，日出不已，则法当温化，吾友丁甘仁云，凡吐血下血见黑色者，皆当用附子理中汤以温运脾阳，服凉药者多死，数十年来不爽，则陷经黑不解之当用温药，要可类推，胶姜汤方治，虽阙，其必为胶艾汤加干姜无疑也，方解门面胶艾汤下兹不赘。

妇人少腹如敦状（敦音对，古礼器，体圆而膨其外，旁有两环，俗音如得有瓦敦，锡敦诸器，形略同古器）小便微难而不渴，生后者此为水与血俱结在血室也，大黄甘遂汤主之

大黄甘遂汤方

大黄四两，甘遂，阿胶各二两

上三味，以水三升，煮取一升，顿服，其血当下

少腹满如敦状，谓如敦之膨其外也，少腹为血室所寄，膨在少腹则胞中有蓄血可知，设令小便自利，直抵当汤证耳，乃小便微难而不渴，水液略无亏损，此即为产后水与血俱结胞门之确证（未产时水与血俱供养胎，产后排泄未尽，乃见此证）而为平人之所无，尽养胎之血及水，混合不别，临产则送小儿及胞衣出产门，一时不能畅泄，余者遂积胞中，治此者便当水血同治，大黄甘遂汤，甘遂以泄水，阿胶入血分，以生新血而去瘀，大黄入大肠令水与血俱从大便出，少腹之满，可以立除，此与桃核承气汤，抵当汤，下瘀血汤之用大黄同意，尽取后阴容积较宽瘀血之排泄易尽也。

妇人经水不利下，抵当汤主之（抵当汤方，水蛭，麝虫各三十个熬，桃仁三十枚，大黄三两，酒浸，上四味，水五升，煮取三升，温服一升）

妇人经水下利，有虚实寒热之分，虚者宜温经汤，兼有湿热则宜土瓜根散，产后水与血俱结胞中，则宜大黄甘遂汤，前数条已详言之，然则此条何以但言不利下，而主治乃为抵当汤，尽此条不举病状者，为其于伤寒太阳篇已借言之也。太阳篇云，热在下焦，下腹当硬满，小便利者，下血乃愈，抵当汤主之，又云脉沉结，少腹硬，小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之其明证也，按此证少腹必结痛，大便必黑，要以小便利为不易之标准，使但用寻常通经之药，岂有济乎，予昔在同仁辅元堂治周姓十七岁少女时经停五月矣，以善堂忌用猛药，每日令服大黄庶虫丸不应送诊期后，病者至江阴街寓所求诊，月事不行，已抵七月，予用麝虫水蛭各一钱，大黄五钱，桃仁五十粒下之，下后以四物中参芪善后，凡二剂，十年来于江阴街遇之，始知其嫁于小古门朱姓，已生有二子矣。

妇人经水闭不利，藏坚癖不止，中有干血，下白物，樊石丸主之

樊石丸方

樊石三分烧，杏仁一分

上二味，末之，蜜丸枣核大，纳藏中，剧者再纳之

妇人经闭累月不至，犹未知其何证也，若子藏坚癖少腹硬满不消，干血久停，因湿热而腐烂时下白物，（俗名白带）其病固显然矣。尽始则因热结而成干血，其继因浊痰下注而留湿，湿热蒸化，干血乃成白带，当见妇人有痰病者，痰多则无淋，淋多即无痰，可为明证，故外治之法，要以去湿为主，而三倍樊石，佐杏仁以破下陷之湿痰，而湿浊可去矣。

妇六十二种风，腹中血气刺痛，红蓝花酒主之

红蓝花酒主

红蓝花二两

上一味，酒一大升，煎减半，顿服一半，未止再服

此节张隐庵注其有意味，兹特引申之以搏其趣，张云红花色赤多汁，生血行血之品也，陶隐居主治胎产血晕，恶血不尽，绞痛（绞作疴）胎死腹中，此可知红花作用，专主调适血分矣，又云治风先治血，血行风自灭，此又可知红花虽行血之品，其作用实能治风矣，但血虚生风，有从内发者，有从外受者，从内发者忽然头目眩转，令人倾仆，此宜气血两补，重用参术归芍地黄者也，从外受者皮毛开泄，感受阳邪，此宜桂枝汤者也，红蓝花酒，究治何风，然观于方治用酒，可知其专主外风矣，灵枢云，饮酒者，卫气先行于皮肤，卫任之络，散于皮肤腠理间，肌表血虚，易受外风，故以生血行血之红花主治，而以酒助其药力，使得行于肌表，以拒外风之侵入，妇人月事时下，卫任之血不足，故治风以此方为宜，要之为外皮腠及筋骨竣疼之病，与中风正自不同，近世验方有用延胡索当归牡桂等分研末，以酒调服，治周身痛不可忍者，意与此同，曰六十二种风，不过言通治之统方，举多数也，血行则腹中刺痛止，故亦兼治之，固不在六十二种之内也。

妇人腹中诸疾痛，当归芍药散主之

妇人腹中疾痛，大要由于水湿太甚，血菀不通，前于妊娠篇妇人怀孕节言之已详，但怀孕之人，水血俱停，人尽知之，不知杂病亦有相类者，尽妇人经水，按月而行，故血常不足，血不足而水湿有余，乃变结于太阴部而为痛，此方泄湿行血，故可通治，要不惟为妊娠设也。

妇人腹中痛，小建中汤主之

此证俗名下肝气，妇人胸襟为处境所限，因而狭小，稍有拂逆则气不沉而入腹，立见胀痛，所谓肝乘脾也，伤寒太阳篇云，阳脉急，阴脉弦法当腹中急痛，宜小建中汤主之，重用甘味之药者，内经所谓肝苦急，食甘以缓之也。

问曰，妇人病，饮食如故，烦热不得卧而反倚息者何也，师曰，此名转胞，不得溺也，以胞系了戾，故致此病，但当利小便则愈，肾气丸主之

肾气丸方

干地黄八两，山药，山茱萸各四两，泽泻，丹皮，茯苓各三两，桂枝一两，附子一枚炮

上八味末之，炼蜜和丸，梧子大，酒下十五丸，加至二十丸日再服

饮食如故则脾胃无热病可知，烦热不得卧，又似阳明热证，若果阳明生燥，上膈决无水气湿痰，岂有反倚息如病痰，饮咳逆之理，此甚可疑也，然究其所以倚息之，故则以小便不通之故，尽下流不通，则上源壅塞，其所以不通者，则以转胞了戾之故，通其小便，则上膈水气下行而倚息自平，所以烦热不得卧者，则以下焦闭结，而少阳之热上薰也，泄其水邪热之上薰者，息矣，然则何以不用泄水之五苓散，曰，此阴阳两虚之证，恐其愈泄而愈不通也，当见有气闭而小便不通者，以木通，四前，猪苓等药治之，百无一效，或用白归身一两，川芎五钱，佐以柴胡升麻，一服即通，可见地黄，山萸，山药之补阴，桂附之扶阳，为至不可少，必非专用茯苓泽泻同等之药所能奏功也。用丹皮者，所以通壅塞也（肠痈篇有大黄牡丹汤，可为明证）

蛇床子散方

蛇床子

上一味，末之，以白粉少许，和合相得如枣大，帛里内之，自然温（当云不痒）妇人寒湿下注阴中，或为白带，或为败血，久久化热，皆足生虫，多而窜动，则痒不可忍，以川椒百部洗之，往往不效，惟蛇床子散足治之，昔年予治一妇人历节风愈后，自言阴痒不可忍，自用明燹泡水洗之，时稍定，少顷痒如故，予以此方授之，二日而瘥（详历节篇）尽以蛇床子之燥，烈合铅粉之杀虫，湿去虫死，其痒乃止，但予实变法用之，使之煎汤坐盆中洗之，然后扑以铅粉，此可知仲师立方之旨，在燥湿杀虫而不在祛寒矣。陈修园乃谓遥承上节令阴制痛，少腹恶寒证，出其方治，岂其然乎，又按阴寒不孕，另是一证，仲师当别有方治，近世所传吴茱萸，蜀椒各

八两为末，炼蜜为丸，弹丸大，帛里内阴中，日夜一换，一月后，子宫温和即孕，用法与此方相似或即仲师之遗方欢，否则本条所列病证与方治固了不合也。

少阴脉滑而数者，阴中即生疮，蚀疮烂者，狼牙汤洗之

狼牙汤方

狼牙三两

上一味，以水四升，煮取半升，以帛缠筋如藕，浸汤，沥阴中，日四遍

少阴脉手太阴动脉之尺部也，属下焦，脉滑而数，属下焦湿热，湿热注于焦，或为淋带，或为太阳蓄血，犹未可定，为阴蚀也，惟阴中痒痛腐烂乃可决为阴中生疮，狼牙草近今所无，陈修园以为可用狼毒代之，未知验否，但此证有虫与毒，即世俗所谓杨梅疮，似不知暇蟆散为宜，方用硫磺三钱，胡椒二钱，研末纳暇蟆口中，用线扎住，外用黄泥和水厚涂，入炭火烧之，俟泥圉红透取出，候冷去泥细研，忘用铁器用时经小磨麻油调，以雉毛蘸涂患处，去其毒水，数日毒尽，虽肉烂尽亦愈，此葛仙肘后方也，自来注释家从事说理不求实用，岂仲师著书之旨欢。

胃气下泄，阴吹而正喧，此杀气之实也，膏发煎主方（膏发煎方，猪膏半斤，乱发如雉子大三枚，上二味和膏中煎之，发消药成，病从大便（旧误作小）便出

凡大便燥实之证，由回肠灼烂前阴者，则小便已而阴中疼热，其有不兼阳明实热而燥实者，在妇人则有阴吹，此非可以大承气汤治之也，阴吹如转矢气声，实由大便不通，矢气无从下泄，转从间道出，此证但苦肠中燥矢与阴络固结，故但用膏发煎以和血，滑肠，则大便通而阴吹止矣，校千金云，太医史脱家婢黄病，服此燥粪下便差，神验，乃知方后从小便出为传写之误，黄坤载泄湿通膀胱之解，为大不通也。又按门人吴炳南之妻每患肠燥，纳杀不多，授以大半夏汤，服之甚效，间一二日不服，燥结如故，吴私念此胃实肠燥之证，乃自制猪膏发煎服之，一剂而瘥，乃知仲师杀气之实四字，早有明示人以通治他证之路，不专为阴吹设也。

跋

戊辰之冬，家君注金匱发微成，托人抄写不意为其友人借阅，稿多散佚，乃于辛未之春，整理残稿，续加注释，由家君用湘人抄录一通，于是复成完书，稿藏于家，今年正月乃门诸子，以家君行年六十有九，藉祝暇称斛，谋刊刻行世，玆曰可，乃由裴君德炎与钱君颂霞商定，托医学书局代售，预约，次第校印订成书，其校字之役乃归黄君汉栋与湘人分任之，湘人虽学识浅，于医学未能深造，而观家君数十年，殚精极神之作，今且风行海内传之永久，深喜私原之克成也，敬述数语，以志缘起，丙子闰三月上浣男湘人谨跋。

重刊（伤寒）（金匱）发微跋

余髫龄多病及冠，荏弱如故，因有志学医，冀，一以健身，一以救人，吾父知而善之，遂负笈潺上，学岐黄术于丁师福保仲姑之门，丁师谓中医之道深遂难明，不若西医之易于入门，即授以生理，病理，解剖，药物诸书，分门指示前后三年，丁师见余时时涉猎中医，乃曰汝既吾国医，独学无师，势焉能入室，吾挚手江阴曹颖甫先生，文章道德著于当代，余力治医，卓然成家，今中医之驰名海上者多出其门，余为汝介绍，余大喜，执贽请见曹师为人和谐可亲，当时即授以所著伤寒发微一书，并为讲述麻黄汤之义理，滔滔不倦，余顷耳神会，不觉饥渴之皆忘也，丙子岁，师年六十有九，乃门诸子祝暇称斛金谓，师云伤寒发微久已刊行，而金匱发微一书稿成已久，尚未付梓，及宜寿之梨枣，以成全璧众议既协嘱余主其事，书成委肆经书，不胫而走，未及期年，伤寒金匱二书，竟罄无存书，八一三之变，曹师遇难，伤寒金匱二书，纸版原存医学书局，亦以书肆易主，竟不知去向，书尽版毁，求书者以无书为苦，今年春，千顷堂书局谋为重印，以余为金匱发微之发行人，驰书计议，余惟曹师是书，久为医界所推崇，但前此发行为数不多，知者憾之，今再版刊行，不特名著能广为传播，对于今日研究祖国医学遗产，亦大有帮助，协为筹划，排印既成附记数语于末，公元一九五五年八月下浣日，门人无锡钱颂霞谨识。